



Análisis de Situación de Salud de la Red de Servicios de Salud San Miguel, 2026**Dirección Regional de Salud Cajamarca****Red de Salud San Miguel****Oficina de Epidemiología**

Jr. Bolívar S/N, San Miguel.

Email: redsaludsanmiguel@gmail.com

Autores:**Redacción y análisis:**

Dra. Jessica E. Tucumango Alcántara

Mg. Yuli Alcántara Ramírez

Lic. Silvia M. Soberón Romero

Equipo técnico de apoyo regional:**1. Procesamiento de datos y dirección técnica**

Oficina Regional de Epidemiología DIRESA Cajamarca Unidad
de Análisis de Situación de Salud
Ing. Raquel Malaver

2. Priorización de problemas con impacto sanitario y definición de líneas de acción

Consejo Provincial de Salud San Miguel

Apellidos y Nombres	Institución
Ing. José Carlos Quiroz Calderón	Alcalde Municipalidad Provincial San Miguel.
Mg. Jenny Bardales Celis	Directora Red de Salud San Miguel
Lic. Kathia Emily Hernández Rodas	Red de Salud San Miguel.
Anderson Cubas Bartolo	Subprefectura de San Miguel
Ing. Jorge Guitierrez Huingo	Gerente Desarrollo Social – MPSM.
Dr. Carlos Enrique Alvarado Castillo	Director de UGEL San Miguel.
Mayor. José Luis Ramírez León	Jefe PNP – San Miguel.
Ps. Luis Miguel Cruzado Cueva	Promotor del CEM San Miguel
Mg. Lorena Medina Díaz	Directora de la IESP- ABL San Miguel.

Mg. Jenny Bardales Celis
Directora de la Red de Salud San Miguel

Dra. Jessica E. Tucumango Alcántara
Coordinadora de Epidemiología

Equipo de Gestión

Recursos Humanos, Mauro Tucumango Intor

Servicios de Salud, Mg. Yuli Alcántara Ramírez

Planeamiento Estratégico/Epidemiología, Dra. Jessica E. Tucumango Alcántara

Atención Integral, Lic. Silvia M. Soberón Romero

Medicamentos Insumos y Drogas, Q.F. Leonel Zenteno Ricce

Logística/Informática y estadística, Téc. Rosa Mary Montenegro Cubas

Salud Ambiental, Téc. Juan Hernández Rodas

Calidad/CPC-Emergencias y Desastres, Ing. Marila Cruz Ochoclo

Contabilidad, Téc. Adelmo Peralta Rodas.

CONTENIDO

SIGLAS Y ACRÓNIMOS.....	2
I. INTRODUCCIÓN.....	3
II. ASPECTOS GENERALES.....	4
III. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS	5
3.1. Ubicación y límites	5
3.2. Superficie territorial.....	6
3.3. Clima	6
3.4. Pisos altitudinales	7
3.5. Cuencas hidrográficas.....	8
IV. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS.....	9
4.1. Composición y estructura de la población	10
V. ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES.....	14
5.1. Determinantes estructurales	14
5.2. Determinantes intermedios.....	19
5.3. Factores psicosociales.....	23
5.4. Sistemas de salud.....	25
VI. ANÁLISIS DE SALUD ENFERMEDAD	54
6.1. Análisis de la morbilidad	54
6.2. Análisis de la mortalidad	63
VII. VINCULACIÓN DEL ASIS CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	72
VIII. ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES SOCIALES Y DESIGUALDADES	75
IX. LÍNEAS DE ACCIÓN.....	91
X. CONCLUSIONES	93
XI. RECOMENDACIONES	93

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

INEI	: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
PNUD	: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
SIRRED	: Sistema de Registro de Eventos de Emergencias y Desastres de Salud.
PAM	: Pasivos ambientales mineros.
MEM	: Ministerio de Energía y Minas.
IDH	: índice de desarrollo humano.
ENAH	: Encuesta Nacional de Hogares
IPRESS	: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
PEA	: Población Económicamente Activa.
ENDES	: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar
RDRS	: Resolución directoral regional de Salud.
CLAS	: Comités Locales de Administración de Salud.
INFORHUS	: Registro sistematizado e integrado de los recursos humanos en salud.
SIS	: Seguro Integral de Salud.
APN	: Atención Prenatal.
SIVIGYP	: Sistema de Vigilancia de Gestantes y Puérperas
SRC	: Sistema de referencia y contra referencia.
PROMSA	: Promoción de la Salud.
SIEN	: Sistema De Información Del Estado Nutricional.
DCI	: Desnutrición Crónica Infantil.
SIEN	: Sistema de Información del Estado Nutricional.
CIE	: Clasificación internacional de enfermedades.
PNCT	: Programa Nacional de Control de Tuberculosis.
SINADEF	: Sistema Informático Nacional de Defunciones.
RMM	: Razón de Mortalidad Materna.
MCI	: Modelo de Cuidado Integral de Salud.
APS	: Atención Primaria en Salud

I. INTRODUCCIÓN

El análisis de la situación de salud (ASIS) es un proceso que describe y analiza la situación con respecto al estado de salud y sus determinantes sociales en una población, así mismo constituye una herramienta de gestión pública para la toma de decisiones por parte de los gobiernos locales y otros actores sociales de la provincia. El propósito del documento es identificar, priorizar y exponer las necesidades y brechas de salud, así como las determinantes sociales que afectan a la población de los trece distritos de la provincia, con el fin de proponer líneas de acción para su control, que forman parte del proceso de planificación y la toma de decisiones.

La gestión sanitaria de la provincia de San Miguel debe abordarse de manera integral, adoptando el enfoque de los determinantes sociales de nuestro ámbito territorial que influyen en la salud, las mismas que deben tener respuesta por parte del sector salud, educación, gobierno local y la sociedad para efectuar los cambios que mejoren las condiciones de vida y salud de la población.

San Miguel tiene una marcada ruralidad y una geografía extensa, factores como el limitado acceso a los servicios de saneamiento básicos (agua potable y desagüe), el acceso a los servicios de salud, la pobreza, el nivel educativo, la cultura y las barreras geográficas determinan la persistencia de los problemas de salud como la desnutrición, anemia, enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles que impactan en la salud de la población. Por ello se hace necesario contar con las herramientas sistematizadas y operativas que permitan conocer la situación de salud y el perfil epidemiológico, priorizando las acciones en los grupos más vulnerables y en las zonas de mayor riesgo.

El presente documento enmarca el proceso de elaboración del análisis de situación de salud de la provincia de San Miguel del año 2025, a través del análisis de entorno, de los determinantes sociales de salud, de los problemas del estado de salud, los problemas con impacto sanitario, priorización de los territorios vulnerables y propuestas de líneas de acción. La salud de la provincia de San Miguel no solo debe ser responsabilidad del sector salud sino debe comprender un desafío multisectorial que incluya a todos los actores sociales de ámbito para tomar acciones articuladas que mejoren la calidad de vida de la población sanmiguelina.

II. ASPECTOS GENERALES

Desde años remotos la provincia de San Miguel posee conocimiento de la medicina tradicional, usando diversidad de la flora para el tratamiento de las enfermedades; ligado a las creencias mágico religiosas y a la autoatención comunitaria.

La llegada de los españoles y la fundación del pueblo de San Miguel marcaron el inicio de una crisis sanitaria debido a las diferentes enfermedades que trajeron (como la peste, sarampión, viruela, malaria, influenza) ante las cuales la población no tenía inmunidad, provocando la muerte de muchos pobladores. La lejanía del territorio y el inaccesible acceso a la provincia no permitieron contar con atención en salud adecuada y de calidad, la mayoría de la población dependía de los curanderos, parteras y autócratas de ese entonces. Las personas enfermas eran llevadas en acémila hacia las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Cajamarca.

En el año 1964, es creada como la provincia de San Miguel, título que permitió obtener la autonomía administrativa y descentralización de los recursos del estado. Años después se crea el primer centro de salud de la capital provincial y posteriormente en los distritos de mayor población como Niepos, San Gregorio, Llapa y Tongod. Se iniciaron las actividades preventivas promocionales en los establecimientos de la provincia.

El fenómeno de El Niño (1983 y 1998), la epidemia del cólera y la peste en los años 1991 mostraron las deficiencias en infraestructura en saneamiento básico, así como en los servicios de salud. Este acontecimiento marcó el inicio de la participación y empoderamiento comunitario, a través de la educación sanitaria.

Hace más de 20 años, la creación de la Red de Salud San Miguel en la provincia, ha logrado expandir la cobertura sanitaria en todos los 13 distritos, aun así, persisten los problemas sanitarios relacionados a la desnutrición crónica infantil y anemia, así como el incremento de los problemas de salud mental como las enfermedades no transmisibles (cáncer, hipertensión y diabetes) por los cambios en los estilos de vida.

San Miguel tiene por misión “Garantizar adecuados procesos de gestión para la atención integral de la salud a favor de las comunidades, proporcionándoles los medios necesarios para salvaguardar su salud, ejerciendo mayor control sobre ella y propiciando la participación activa de la sociedad civil y autoridades locales en la Provincia de San Miguel”.

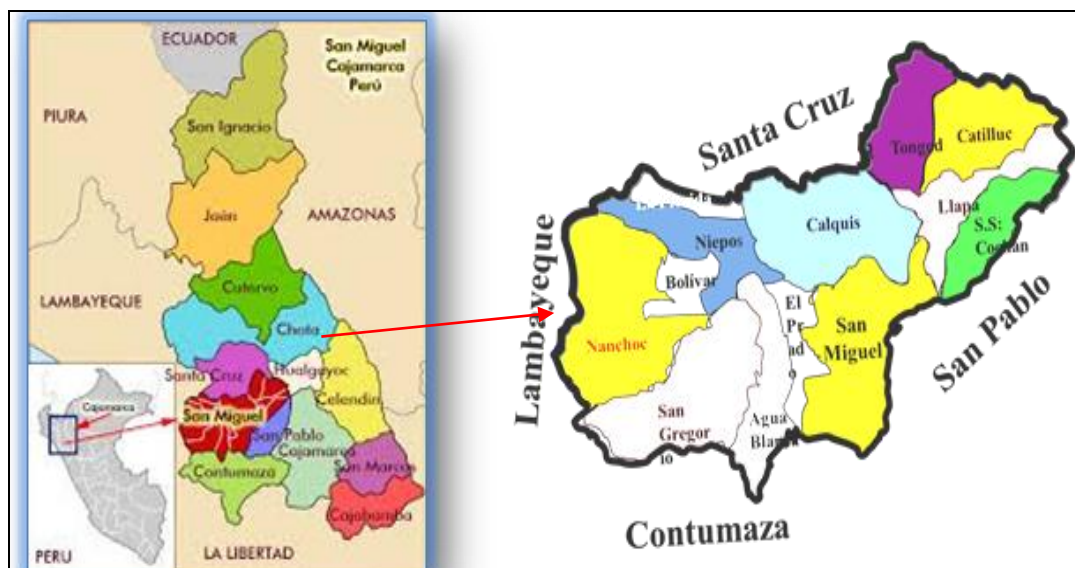
III. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS

3.1. Ubicación y límites

Ubicación: la provincia de San Miguel se ubica al sur oeste del departamento de Cajamarca, en la sierra norte del país; con una latitud sur 78° 59' 48'', a 140 km de la provincia de Cajamarca y a 56 km del distrito de Chilete.

Dentro de su ámbito, la provincia de San Miguel tiene 13 distritos: Bolívar, Calquis, Catilluc, El Prado, La Florida, Llapa, Nanchoc, Niepos, San Gregorio, San Miguel, San Silvestre de Cochan, Tongod y Unión Agua Blanca; los mismos que conforman 5 micro redes con 48 IPRESS.

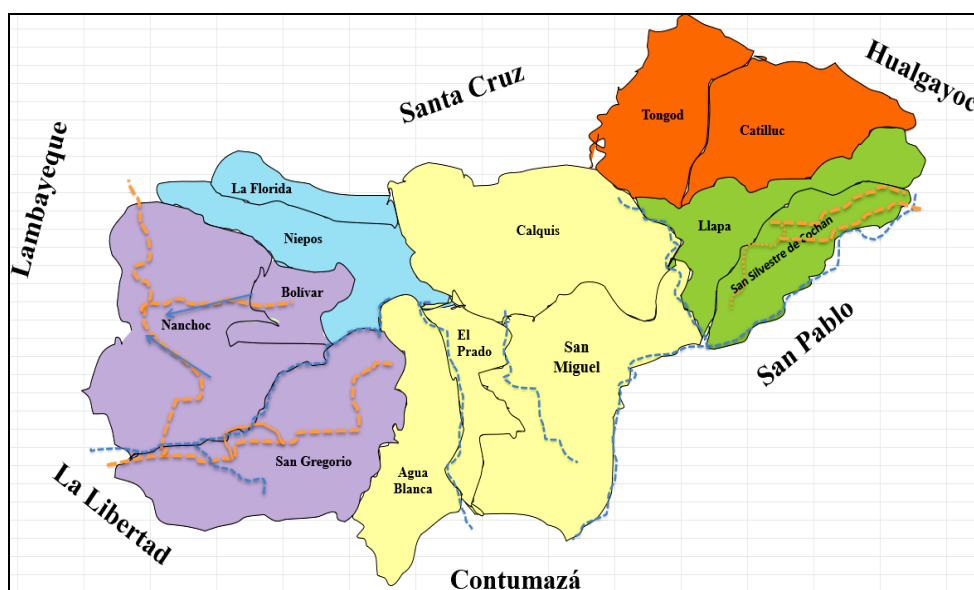
Mapa 1. Mapa político de la provincia de San Miguel: ubicación geográfica



Fuente: Google maps. Elaborado por oficina de Epidemiología - Red San Miguel, 2025

Límites: San Miguel limita por el norte con la provincia de Santa Cruz; por el sur con la provincia de Contumazá; por el este con la provincia de Hualgayoc y San Pablo, y por el oeste con la provincia de Chepén de la región La Libertad.

Mapa 2. Límites geográficos de la provincia de San Miguel



Fuente: Google maps. Elaborado por oficina de Epidemiología - Red San Miguel, 2025

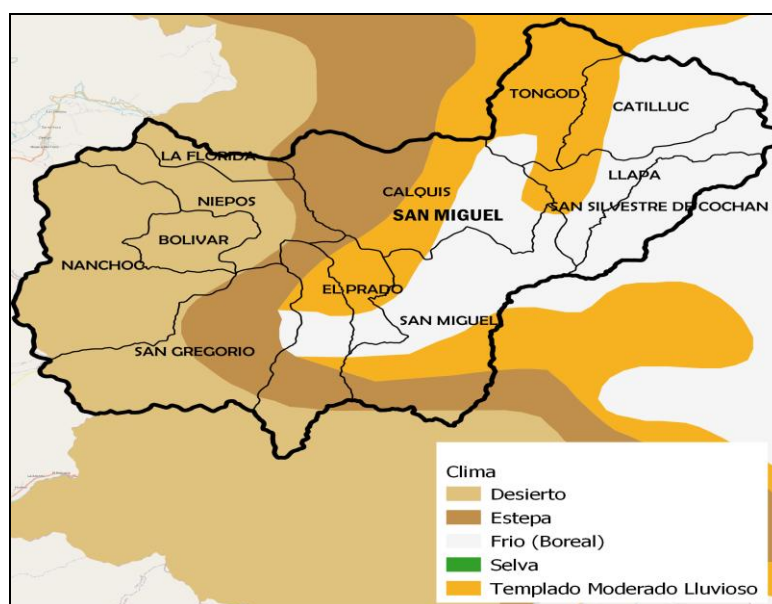
3.2. Superficie territorial

Extensión y relieve: la superficie territorial provincial es de 2,541.88 Km², lo que constituye el 7,5 % de área departamental, está íntegramente ubicada en la vertiente del Pacífico, siendo los distritos de San Miguel, Calquis y el Nanchoc los más extensos y ocupan cerca del 50 % del territorio de la provincia, los distritos menos extensos son la Florida y el Prado.

3.3. Clima

Clima y temperatura: La provincia de San Miguel presenta una variedad de clima; en la región costa o chala se ubica el distrito de Nanchoc con clima cálido y seco por la ausencia de lluvias. En la región yunga marítima están los distritos El Prado, Llapa, Nanchoc, Niepos, San Miguel, Unión Agua Blanca, Bolívar, La Florida y San Gregorio donde el clima varía entre cálido y templado con escasas lluvias. En la región quechua; parte de los distritos de San Miguel, Calquis, Catilluc, El Prado, Llapa, Cochán, Niepos, Tongod y Unión Agua Blanca, el clima varía entre templado y frío, con lluvias más abundantes que en la Yunga. La región Jalca; parte alta de los distritos de San Miguel, Calquis, Catilluc, Tongod, Llapa, Cochán, El Prado, Niepos y Unión agua Blanca, el clima es muy frío y lluvioso con frecuentes heladas y granizadas.

Mapa 3. Climas, provincia de San Miguel.



Fuente: ZEE OT Región Cajamarca, 2022.

3.4. Pisos altitudinales

Limites altitudinales: San Miguel se encuentra a 2 650 msnm, la cual presenta una topografía extremadamente accidentada y compleja, dentro de su ámbito tiene cuatro cuencas hidrográficas, así como la presencia de la Cordillera Occidental de los Andes que determina desniveles de más de 3 500 m.s.n.m. entre las zonas altas, las mayores elevaciones de la provincia, y de 400 m.s.n.m. en el distrito de Nanchoc; lo que determina un territorio donde predomina lo pendiente y lo escabroso.

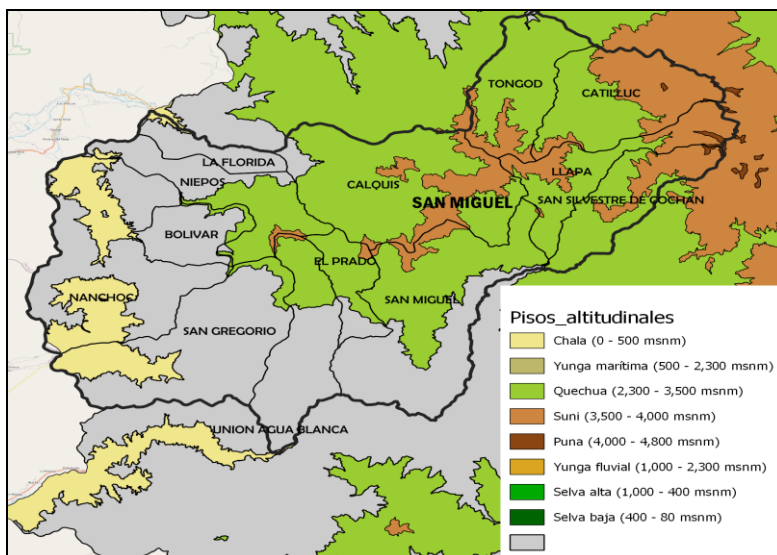
Tabla 1. Provincia de San Miguel: distritos con mayor y menor altitud

Distrito	Altitud m.s.n.m
San Miguel	2665 m.s.n.m
Llapa	3200 m.s.n.m
Calquis	2855 m.s.n.m
El Prado	2830 m.s.n.m
Unión Agua Blanca	2900 m.s.n.m
San Silvestre de Cochan	3237 m.s.n.m
La Florida	1200 m.s.n.m
Niepos	2451 m.s.n.m
Nanchoc	400 m.s.n.m
Bolívar	917 m.s.n.m
San Gregorio	1854 m.s.n.m
Catilluc	2759 m.s.n.m
Tongod	2645 m.s.n.m

Fuente: Atlas de Cajamarca (atlascajamarca.pe), 2022.

La provincia de San Miguel tiene diferentes regiones naturales que van desde la costa o chala (hasta 500 m.s.n.m) como es el distrito de Nanchoc, hasta la región la quechua (2 300 a 3 500 m.s.n.m) donde están ubicados la mayoría de los distritos.

Mapa 4. Pisos Altitudinales, provincia de San Miguel



Fuente: ZEE OT Región Cajamarca, 2022.

3.5. Cuencas hidrográficas

La Hidrografía de la provincia de San Miguel está inmersa en cuatro cuencas:

- ✓ **Cuenca del Chancay (Río Chancay):** pertenece a la vertiente del Pacífico, es de régimen irregular y está conformado por los ríos Tacamache y Perlamayo que nacen en la Cordillera Occidental de los Andes, concierne parte de las provincias de Chota, Hualgayoc, San Miguel y la totalidad de la provincia de Santa Cruz. Esta comprendida entre las cotas 4,050 y 250 m.s.n.m. Su colector principal es el río Chancay, y los principales tributarios por la margen derecha descendiendo el río San Juan, la quebrada Huamboyoco, los ríos Cirato y Maichil; por la margen izquierda descienden el río Cañad y San Lorenzo. El caudal registrado en la estación de aforo Racarumi, registra 35.70 m³/seg.
- ✓ **Cuenca del Zaña (Río Zaña — Río Nanchoc — Río Tingués):** se encuentra ubicada en la parte norte del país, abarcando una extensión de 1,600 km², se ubica entre las provincias de Santa Cruz y San Miguel, entre las alturas de 3 700 y 350 msnm. Su colector principal es el río Zaña, sus principales tributarios por la margen derecha son las quebradas Palmo, Cedro, El Plátano y el Río Udimá; por la margen izquierda los ríos La

Majada, Cascarilla, Las Argollas, La Laja, Nanchoc, así como las quebradas Tucatis y San Isidro. El caudal registrado es de 13,59 m³/seg. Esta cuenta forma parte del territorio de los distritos de Niepos, Bolívar y Nanchoc.

- ✓ **Cuenca del Jequetepeque o Chilete (Río Puclush — Río Payac y Río San Miguel):** está comprendida entre la presa Gallito Ciego y divisorias cuencas, comprende las provincias de San Miguel, San Pablo, Cajamarca y Contumazá, entre las cotas 4 050 y 150 msnm. Su colector principal es el río Jequetepeque, conformado por la unión de los ríos Magdalena y su afluente Chetillano, Puclush o San Miguelino. El Jequetepeque tiene como afluentes, por la margen derecha el río Pallac, por la margen izquierda los ríos Chanta, Contumazá y Huertas. En la provincia de San Miguel los distritos que forman parte de la cuenca son: San Gregorio, Unión Agua Blanca, El Prado, San Miguel, Calquis, Llapa y Cochán.
- ✓ **La cuenca del Chamán (Río Chamán o Río Loco):** la cuenca del río Chamán tiene una extensión de 1 569 km²; el subsistema hidrográfico del río Chamán está conformado por las confluencias del río San José y la quebrada San Gregorio, las cuales están comprendidas en la provincia de San Gregorio, en su recorrido cruza los caseríos Sauce, Zapote entre otros.

IV. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

El escenario demográfico de la provincia de San Miguel muestra tendencias preocupantes en el 2025 referente a la mortalidad y la migración de la población en comparación a los años 2023 y 2024, donde la población se mantenía relativamente estable; esto puede estar asociado a la migración juvenil hacia otras provincias o países en busca de nuevas oportunidades, lo que reduce la base poblacional y acelera el envejecimiento en la provincia de San Miguel.

Asimismo, la natalidad va en descenso continuo, pasando de 326 nacimientos (2023) a 307 (2025), siendo la reducción del 5,8 % de nacimientos en solo dos años, mientras que la tasa de natalidad se mantiene estática en 7 por cada 1 000 habitantes, lo que indica un envejecimiento poblacional que estaría ligado a los cambios socioculturales como: mayor acceso a educación y empleo para las mujeres, retraso en la edad de matrimonio y maternidad y preferencia por familias más pequeñas; así como un mejor acceso a métodos anticonceptivos y programas de planificación familiar.

En tanto, las defunciones entre 2023 y 2024 bajaron de 61 a 42, sin embargo, en 2025 se incrementaron a 200, un aumento del casi el 400 % respecto a los años anteriores; este cambio brusco en la tasa de mortalidad (de 1 a 5 por cada 1 000 habitantes) puede explicarse por una combinación de algunos factores como incremento de accidentes de tránsito, enfermedades no transmisibles y crónicas, tener población longeva, algunos atentados o violencia, recién nacidos afectados por complicaciones perinatales y desigual acceso a servicios obstétricos, y otros asociados a los estilos de vida.

La esperanza de vida es consecuencia directa del aumento de muertes, San Miguel en últimos tres años viene retrocediendo en este indicador, pasando de 76.4 años a 76.2 años en 2025, esto depende directamente de factores como la calidad de vida que puede tener una persona en cuanto a su alimentación y entorno en donde vive.

Cuadro 1. Dinámica poblacional, región Cajamarca, 2023-2025

Indicador	2023	2024	2025
N° de nacimientos	326	314	307
Tasa de natalidad x 1 000	7	7	7
N° de defunciones	61	42	200
Tasa de mortalidad x 1 000	1	1	5
Esperanza de vida al nacer	76.3	76.4	76.2

Fuente: ORE Cajamarca, 2026.

Elaborado por oficina de Epidemiología - Red San Miguel, 2025

4.1. Composición y estructura de la población

4.1.1. Población provincial por curso de vida y sexo

La población de la provincia de San Miguel, para el año 2025 fue de 43 651 habitantes, siendo el 50,1 % población masculina y el 49,9 % femenina, menor a los años 2023 (44 692 hab) y 2024 (44 219 hab), la reducción de la población puede estar asociada al mejor acceso de la población a los programas de planificación familiar, reduciendo los nacimientos y población infantil en algunos distritos de la provincia, otro factor es la migración juvenil por estudios.

De acuerdo al curso de vida, observamos que la población adulta es la de mayor presencia en la provincia con un 39, 2 %, seguida de la joven (16,8 %) y adulta mayor (15,7 %); si comparamos de acuerdo al sexo, los adultos y niños varones fueron la mayor población, al igual que las mujeres en los mismos cursos de vida.

Cuadro 2. Población de la provincia de San Miguel por curso de vida y sexo, 2025

Curso de vida	2025	
	M	F
Niños (0 -11 años)	3803	3795
Adolescentes (12 -17 años)	2388	2384
Joven (18 - 29 años)	3675	3669
Adulto (30 -59 años)	8560	8544
Adulto mayor (60 a más años)	3420	3413
Total	21846	21805

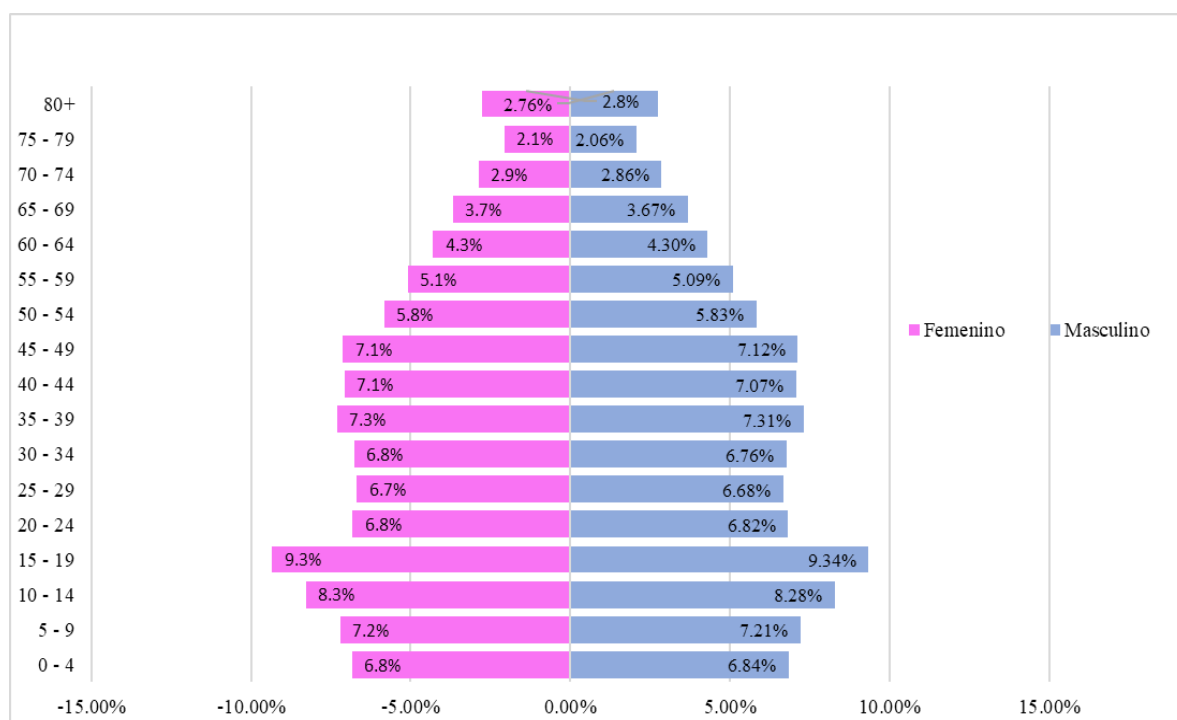
Fuente: ORE Cajamarca, 2026.

Elaborado por oficina de Epidemiología - Red San Miguel, 2025

4.1.2. Pirámide poblacional

La pirámide poblacional de la provincia de San Miguel para el año 2025 fue de población estacionaria o estancada, debido al equilibrio entre la mortalidad y la natalidad durante ese año. Se observa una base y estructura similar entre las edades de 0 a 49 años lo que indica que el crecimiento natural de la población es bajo. A partir de los 50 años, la población se reduce progresivamente, pero con porcentajes aún significativos en los grupos de 60 a 79 años, esto evidencia una disminución de la mortalidad general y un aumento en la longevidad. Asimismo, notamos que los grupos de 15 a 39 años concentran los mayores porcentajes (entre 7 % y 9 %), lo que sugiere una población en edad productiva predominante, aumentando la esperanza de vida y disminución del crecimiento natural de la población. En cuanto al sexo, tanto la población femenina como la masculina mostraron igual tasa de crecimiento en todos los grupos de edad, lo que refleja tasas de crecimiento similares y ausencia de sesgos de género en la distribución.

Gráfico 1. Pirámide poblacional, Provincia de San Miguel, 2025



Fuente: ORE Cajamarca, 2026. Elaborado por oficina de Epidemiología - Red San Miguel, 2025

4.1.3. Población por provincia y distritos, curso de vida

De acuerdo a la data de la oficina de informática y estadística de la Dirección Regional de Salud, muestran que la tendencia de crecimiento poblacional de la provincia de San Miguel ha disminuido considerablemente en los últimos dos años, pasando de 44 692 habitantes en el año 2023 a 43 651 habitantes para el año 2025.

El distrito de San Miguel concentra la mayor población adulta y adulta mayor en los últimos tres años, seguido de Llapa y Calquis; mientras que la población del distrito de Bolívar ha venido disminuyendo en este periodo, siendo la población adulta y adulta mayor la que más habita en el lugar. También se viene observando que la población no es del todo estática en los diferentes cursos de vida, pues se evidencia que durante el año 2024 y 2025 algunos distritos mostraron pequeño crecimiento poblacional, situación que puede estar relacionada con la migración de personas por razones laborales hacia nuestro territorio.

Cuadro 3. Población por provincia y distritos de San Miguel, por curso de vida, 2023-2025

Distrito	2023						2024						2025					
	Niños (0-11 a)	Adolescente (12-17 a)	Joven (18-29a)	Adulto (30-59a)	Adulto mayor (>60 a)	Total	Niños (0-11 a)	Adolescente (12-17 a)	Joven (18-29a)	Adulto (30-59a)	Adulto mayor (>60 a)	Total	Niños (0-11a)	Adolescente (12-17a)	Joven (18-29a)	Adulto (30-59a)	Adulto mayor (>60 a)	Total
San Miguel	2226	1425	2287	4926	2475	13339	2289	1494	2361	5081	2539	13764	2481	1601	2403	5379	2219	14083
Bolívar	169	110	183	464	298	1224	167	110	174	438	281	1170	170	103	169	434	226	1102
Calquis	699	456	793	1570	653	4171	669	446	769	1523	632	4039	702	450	744	1544	530	3970
Catilluc	497	266	494	1065	339	2661	464	254	468	1007	318	2511	467	253	448	1009	271	2448
El Prado	315	151	251	581	306	1604	430	178	293	679	358	1938	414	210	325	785	344	2078
La Florida	285	182	350	780	476	2073	274	176	334	744	452	1980	260	176	321	741	372	1870
Llapa	746	466	743	1612	756	4323	730	450	708	1534	719	4141	682	461	679	1531	597	3950
Nanchoc	193	108	194	544	283	1322	195	109	189	522	269	1284	200	114	181	526	223	1244
Niepos	520	360	438	1003	704	3025	490	343	411	936	656	2836	492	333	392	921	526	2664
San Gregorio	374	198	311	857	462	2202	333	186	298	818	443	2078	306	184	286	817	369	1962
San Silvestre de Cochán	613	355	586	1404	575	3533	577	346	564	1354	554	3395	545	350	538	1369	466	3268
Tongod	473	217	390	873	310	2263	423	219	396	894	315	2247	442	222	396	941	279	2280
Unión Agua Blanca	444	327	499	1162	520	2952	440	315	477	1107	497	2836	437	315	462	1107	411	2732

Fuente: OITE– Red San Miguel, 2026

Elaborado por oficina de Epidemiología - Red San Miguel, 2025

4.1.4. Población afiliada al SIS

Durante el periodo 2023 al 2025, observamos que el número de afiliados en la provincia de San Miguel se incrementó en 7775 afiliados, siendo el distrito de San Miguel el que más afiliados tuvo en los tres años, en comparación al distrito de Bolívar.

Asimismo, se puede evidenciar que para el año 2025 las afiliaciones han tenido un ligero incremento en la mayoría de distritos, pero el que más afiliados ha tenido es San Miguel con 14 772, seguido de Llapa (5532) y Calquis (4707); por otro lado, los distritos con menos afiliados son Bolívar (1668) y Nanchoc (1647).

Se puede observar que la población INEI (cuadro 3) no coincide con la población de afiliados (tabla 2), la diferencia entre ambas fuentes es bastante amplia; en el 2023 la diferencia de población es de 4 203 personas; en el 2024 es de 12 392 y en el 2025 es de 13 019; lo que evidencia que la población real de la provincia es mucho más alta y puede estar dispersa en otras provincias y regiones.

Tabla 2. Afiliados al SIS por distritos, provincia San Miguel, 2023 – 2025

Distrito	2023	2024	2025
Bolívar	1328	1650	1668
Calquis	4144	4687	4707
Catilluc	3239	3602	3579
El Prado	4775	3889	3848
La Florida	2225	2682	2683
Llapa	4685	5525	5532
Nanchoc	1409	1638	1647
Niepos	3562	4149	4159
San Gregorio	2290	2626	2604
San Miguel	11086	14665	14772
San Silvestre de Cochan	4204	4753	4735
Tongod	2988	3478	3468
Unión Agua Blanca	2960	3267	3268
Total	48895	56611	56670

Fuente: Unidad de Seguros – DIRESA Cajamarca, 2026

Elaborado por oficina de Epidemiología - Red San Miguel, 2025

V. ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES

5.1. Determinantes estructurales

Pobreza económica

La pobreza se mide con el valor de la canasta mínima alimentaria y no alimentaria, cuyo costo para el año 2019 fue S/ 352 soles por persona; las personas cuyo gasto es menor son considerados pobres. En la provincia de San Miguel, el distrito de Bolívar tiene menor porcentaje de pobreza monetaria, en comparación al distrito de San Silvestre de Cochan, situación que puede estar relacionada a la oportunidad laboral y el deficiente acceso a los servicios básicos.

Tabla 3. Pobreza monetaria por distritos, provincia San Miguel, 2017

Distrito	%
Bolívar	39,5
Calquis	66,2
Catilluc	60,1
El Prado	65,7
La Florida	47,9
Llapa	45,0
Nanchoc	44,7
Niepos	55,9
San Gregorio	59,5
San Miguel	44,1
San Silvestre de Cochán	70,1
Tongod	52,3
Unión Agua Blanca	59,3
Provincial	52,9

Fuente: Sistema de Información Distrital para la gestión pública -2017
Elaborado: Oficina Epidemiología Red San Miguel, 2025

Educación

La provincia de San Miguel registra una tasa de analfabetismo del 12,7 % en la población, lo que significa que casi 1 de cada 2 personas de 15 años a más no sabe leer ni escribir. A nivel de distritos, Llapa y Calquis son los que tienen mayor porcentaje de población analfabeta, lo cual está relacionado con la ruralidad de la zona, la geografía dispersa de sus comunidades y las desigualdades de género; en comparación a los distritos El Prado y Bolívar, donde su población tiene mayor acceso a la costa, logrando mayor oportunidad de estudios.

Tabla 4. Número de personas con analfabetismo por distritos, provincia San Miguel, 2017

Distrito	%
Bolívar	8,1
Calquis	13,9
Catilluc	13,1
El Prado	6,0
La Florida	12,6
Llapa	14,3
Nanchoc	9,1
Niepos	10,7
San Gregorio	10,5
San Miguel	19,0
San Silvestre de Cochán	13,4
Tongod	9,6
Unión Agua Blanca	13,7
Provincial	12,7

Fuente: Sistema de Información Distrital para la gestión pública -2017
Elaborado: Oficina Epidemiología Red San Miguel, 2025

En cuanto a la educación, la provincia de San Miguel cuenta con 460 instituciones educativas públicas, de las cuales el 42,6 % son de nivel inicial, 44,1 % del nivel primario y 13,3 % del nivel secundario. Si bien es cierto se cuenta con instituciones educativas, pero no todos los niños acceden a una, situación que está relacionado con factores económicos, geográficos y sociales. Muchos niños dejan de estudiar por iniciar un trabajo para el apoyo económico de su familia, así como con las actividades agrícolas y ganaderas de la familia, situación que también puede estar relacionada por la ausencia de uno de los progenitores.

Como provincia, en el año 2017, se tuvo una deserción del 1,6 % de niños que no asisten a una institución educativa, siendo el distrito de Unión Agua Blanca (2,7 %) el que más deserción tuvo, en comparación a Catilluc (0,9 %) y Nanchoc (0,9 %).

Tabla 5. Número de niños que no asisten a la escuela, por distritos, provincia San Miguel, 2025

Distrito	%
Bolívar	1,9
Calquis	1,7
Catilluc	0,9
El Prado	1,8
La Florida	1,5
Llapa	1,0
Nanchoc	0,9
Niepos	1,7
San Gregorio	1,7
San Miguel	1,9
San Silvestre de Cochan	1,9
Tongod	1,3
Unión Agua Blanca	2,7
Provincial	1,6

Fuente: Sistema de Información Distrital para la gestión pública -2017
Elaborado: Oficina Epidemiología Red San Miguel, 2025

Desempleo

La tasa de desempleo en la provincia de San Miguel para el año 2017 fue del 3 %, mientras que en el distrito El Prado fue del 10,1 %, mucho mayor a los otros distritos; mientras que Bolívar tuvo la menor tasa de desempleo (0,4 %). Esta situación se debe a que más del 70 % de la población económicamente activa (PEA) se dedica a la agricultura y ganadería. La existencia de trabajo formal en el sector público y privado es casi ausente.

Tabla 6. Porcentaje de desempleo por distritos, provincia San Miguel, 2017

Distrito	%
Bolívar	0,4
Calquis	0,7
Catilluc	0,6
El Prado	10,1
La Florida	7,2
Llapa	2,0
Nanchoc	4,8
Niepos	2,5
San Gregorio	1,9
San Miguel	3,7
San Silvestre de Cochán	1,2
Tongod	1,6
Unión Agua Blanca	2,6
Provincial	3,0

Fuente: Sistema de Información Distrital para la gestión pública -2017

Elaborado: Oficina Epidemiología Red San Miguel, 2025

Dependencia económica

Como provincia la dependencia económica es del 65,4 %, mientras que, como distritos, Niepos tiene mayor porcentaje (80,5 %) en comparación a los demás; en tanto, San Silvestre de Cochán tiene un 58,4 %. Este indicador está relacionado con la demografía de la provincia y la existencia de los programas sociales como JUNTOS. San Miguel tiene una elevada migración de jóvenes hacia las ciudades de la costa y Cajamarca, ya sea por estudios o trabajo, situación que ha generado que los hogares sean habitados por niños y adultos y adultos mayores, donde uno de los mayores de edad tiene que sostener el hogar económicamente.

Tabla 7. Porcentaje de hogares con dependencia económica por distritos, provincia San Miguel, 2025

Distrito	%
Bolívar	69,1
Calquis	65,8
Catilluc	59,6
El Prado	65,3
La Florida	64,8
Llapa	65,9
Nanchoc	65,6
Niepos	80,5
San Gregorio	65,1
San Miguel	61,9
San Silvestre de Cochan	58,4
Tongod	62,5
Unión Agua Blanca	66,1
Provincial	65,4

Fuente: Sistema de Información Distrital para la gestión pública -2017
Elaborado: Oficina Epidemiología Red San Miguel, 2025

Densidad del estado

La IDE mide la capacidad del estado en proveer los servicios básicos de una comunidad, como agua, luz, salud, educación e identidad. La provincia de San Miguel tiene una densidad del estado (IDE) del 0.65 %, esta tiene una brecha entre los diferentes distritos, mientras que, como distritos, Tongod y Bolívar tiene mayor densidad del estado que Calquis.

Los distritos de Llapa, Catilluc, Tongod, San Miguel, Niepos, La Florida, Calquis, Unión Agua Blanca, El Prado, Nanchoc, San Gregorio y Bolívar cuenta con comisaría y juzgado de paz. La mayoría de instituciones como agencia agraria, banco de la nación y fiscalía se ubican en los distritos de San Miguel, La Florida y Tongod.

En cuanto al acceso a internet y telecomunicaciones, todas las capitales distritales tienen, pero no todas sus comunidades.

Tabla 8. Porcentaje de densidad del estado por distritos, provincia San Miguel, 2017

Distrito	%
Bolívar	0,64
Calquis	0,44
Catilluc	0,55
El Prado	0,59
La Florida	0,60
Llapa	0,59
Nanchoc	0,60
Niepos	0,52
San Gregorio	0,50
San Miguel	0,58
San Silvestre de Cochán	0,52
Tongod	0,64
Unión Agua Blanca	0,55
Provincial	0,65

Fuente: Sistema de Información Distrital para la gestión pública -2017

Elaborado: Oficina Epidemiología Red San Miguel, 2025

5.2. Determinantes intermedios

5.2.1. Circunstancias materiales

Viviendas con acceso agua potable

El agua tiene una estrecha relación con la vida de las personas, pues es un agente esencial de salud o enfermedad. Si está contaminada se convierte en uno de los principales vehículos de transmisión de enfermedades gastrointestinales y dérmicas. De acuerdo al Sistema de Información Distrital para la gestión pública del 2017, la provincia San Miguel alcanzó el 49,3 % de viviendas con acceso agua potable, es decir tienen una conexión domiciliaria en sus hogares, ya sea de zona urbana o rural.

En cuanto al acceso de agua por distritos, tenemos que, San Gregorio ocupa el último lugar de viviendas con disponibilidad de agua potable (17,1 %), situación que está muy relacionada con la escasa gestión de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) rurales y el gobierno local del ámbito, así como con la dispersión geográfica de las comunidades, muchas de ellas se ubican sobre los sistemas de agua, dificultando la llegada del suministro a sus hogares, generando que busquen otras fuentes de agua con que abastecerse para su consumo diario.

En tanto, el distrito de La Florida es el de mayor acceso de agua potable que suministra a los hogares (65,9 %), la mayor parte de su población vive en la zona urbana, además de tener una empresa a cargo del suministro del agua que trabaja con su gobierno local. En la zona rural del distrito aún se evidencia la falta de intervención en algunas juntas de agua.

Si bien es cierto la mayoría de comunicados rurales tienen una conexión domiciliar en sus viviendas, pero esto no garantiza que el agua dotada sea potable todo el tiempo, sino depende muchas veces de los recursos económicos con los que cuente la JASS para la compra del insumo (cloro). Además, del deficiente mantenimiento de los sistemas de agua potable y la escasa importancia por parte de los gobiernos locales que no asumen el rol que les compete para mantener la sostenibilidad de los sistemas de agua.

Tabla 9. Porcentaje de viviendas con acceso agua potable, por distritos, provincia San Miguel, 2017

Distrito	%
Bolívar	44.2
Calquis	31.9
Catilluc	46.6
El Prado	54.3
La Florida	65.9
Llapa	55.9
Nanchoc	43.3
Niepos	39.5
San Gregorio	17.1
San Miguel	52.9
San Silvestre de	59.5
Cochan	57.6
Tongod	55.9
Unión Agua Blanca	55.9
Provincial	49.3

Fuente: Sistema de Información Distrital para la gestión pública -2017
Elaborado: Oficina Epidemiología Red San Miguel, 2025

Viviendas con acceso a desagüe

Se considera que los hogares tienen saneamiento básico cuando poseen servicio higiénico conectado a red pública dentro o fuera de la vivienda, letrina ventilada, pozo séptico o pozo ciego o negro. Según el Censo del 2017, la provincia de San Miguel alcanzó el 64,2 % de hogares con acceso a desagüe.

Al igual que el acceso agua, San Gregorio también tiene déficit de viviendas con acceso a desagüe (40,4%), en comparación a los demás distritos; situación que puede estar relacionada con la geografía del distrito y la ubicación de las viviendas si estás quieren tener un servicio higiénico con arrastre hidráulico, realidad que no es de toda la zona rural, pues la mayoría cuenta con letrinas fuera de sus viviendas, las mismas que se encuentran en pésimo estado de conservación.

En tanto, el distrito de Calquis obtuvo la mayor cantidad de viviendas con acceso a desagüe (76,1 %), que puede estar relacionada con los diversos proyectos de inversión en saneamiento básico que han gestionado los diferentes gobiernos locales de los últimos 8 años, como son la implementación de biodigestores en la mayoría de comunidades del distrito.

Tabla 10. Porcentaje de viviendas con acceso a desagüe, por distritos, provincia San Miguel,

2017

Distrito	%
Bolívar	58,6
Calquis	76,1
Catilluc	63,2
El Prado	47,4
La Florida	72,7
Llapa	68,0
Nanchoc	49,3
Niepos	63,1
San Gregorio	40,4
San Miguel	69,1
San Silvestre de Cochán	75,9
Tongod	65,1
Unión Agua Blanca	46,5
Provincial	64,2

Fuente: Sistema de Información Distrital para la gestión pública -2017

Elaborado: Oficina Epidemiología Red San Miguel, 2025

Hacinamiento

La provincia de San Miguel tiene una población mayormente rural, situación que puede estar relacionada con el hacinamiento en algunos hogares de bajos recursos económicos, así como familias nucleares y extensas que muchas veces comparte una única vivienda. De acuerdo al censo 2017, Tongod tiene el 29,8 % de familias que viven hacinadas, en comparación a San Gregorio que solo tiene el 6,5 %. La diferencia entre ambos distritos se relaciona con las oportunidades de salir del lugar de origen hacia otros lugares, como es el caso de la población de San Gregorio, que va hacia la región La Libertad, que en su mayoría son jóvenes y/o adultos, quedando solo los adultos mayores y menores de edad. Mientras que en Tongod la situación es diferente, la mayoría de población vive en el mismo lugar, se desplazan de forma esporádica para atención de otros servicios particulares o compras, pero siempre regresan a su lugar de origen.

Tabla 11. Porcentaje de hogares hacinados, por distritos, provincia San Miguel, 2017

Distrito	%
Bolívar	13.6
Calquis	24
Catilluc	25.5
El Prado	11
La Florida	10.5
Llapa	11.8
Nanchoc	9.6
Niepos	19.8
San Gregorio	6.5
San Miguel	11.2
San Silvestre de Cochán	9.9
Tongod	29.8
Unión Agua Blanca	13.2
Provincial	14.5

Fuente: Sistema de Información Distrital para la gestión pública -2017

Elaborado: Oficina Epidemiología Red San Miguel, 2025

Hogares que cocinan con leña y/o estiércol

El uso de leña y/o estiércol es mayormente común en los hogares de la zona rural, como es el caso de la provincia de San Miguel; situación que puede estar relacionada con el aislamiento geográfico, la falta de transporte y la pobreza económica, que no permite el acceso a la compra de un balón de gas. Debido a esta situación las familias de la zona rural han optado por la construcción de fogones, cocinas caseras o mejoradas que permiten hacer uso de los recursos disponibles en su ámbito, como leña, ramas o estiércol.

El 63,6 % de los hogares de la provincia de San Miguel utilizan leña y/o estiércol, mientras que, por distrito, Calquis tiene el 79 % de la población que hace uso de estos dos biocombustibles, en comparación a Bolívar (51,4 %), escenario que nos indica que en este último hacen uso de otros combustibles como el gas para la preparación de sus alimentos.

El uso constante de estos combustibles naturales trae como consecuencia la presentación de enfermedades respiratorias graves y agudas, así como problemas oftalmológicos.

Tabla 12. Hogares que cocinan con leña y/o estiércol, por distritos, provincia San Miguel, 2017

Distrito	%
Bolívar	51,2
Calquis	79,0
Catilluc	61,2
El Prado	65,4
La Florida	66,3
Llapa	62,8
Nanchoc	53,6
Niepos	63,2
San Gregorio	58,7
San Miguel	61,4
San Silvestre de Cochán	71,9
Tongod	61,9
Unión Agua Blanca	59,0
Provincial	63,6

Fuente: Sistema de Información Distrital para la gestión pública -2017
Elaborado: Oficina Epidemiología Red San Miguel, 2025

5.3. Factores psicosociales

Migración

La falta de empleo en la provincia trae como consecuencia la migración de los jóvenes en busca de nuevas oportunidades laborales y de estudio. Muchos de ellos se ven motivados a salir por la influencia de familiares que migraron de forma exitosa hacia las ciudades de Trujillo, Chiclayo, Cajamarca y Lima. Otro factor son las condiciones donde viven, el hacinamiento y la convivencia familiar relacionado a violencia familiar ocasiona que la población salga de su lugar de origen.

En el último censo del 2017, la provincia de San Miguel alcanzó el 10,4 % de migración, siendo el distrito de Nanchoc el que más migración tuvo (27 %), mientras que Niepos solo tuvo el 4,5 %. La diferencia del 22,5 % entre ambos distritos está relacionada a la cercanía que tiene la población de Nanchoc hacia las ciudades de la región de Chiclayo (Oyotun aproximadamente 30 min), mientras que Niepos es más distante (3 horas).

Tabla 13. Porcentaje de población migrante por distritos, provincia San Miguel, 2017

Distrito	%
Bolívar	13,2
Calquis	7,2
Catilluc	12,8
El Prado	15,2
La Florida	18,3
Llapa	5,3
Nanchoc	27,0
Niepos	4,5
San Gregorio	15,0
San Miguel	12,5
San Silvestre de Cochán	5,0
Tongod	6,7
Unión Agua Blanca	11,7
Provincial	10,4

Fuente: Sistema de Información Distrital para la gestión pública -2017
Elaborado: Oficina Epidemiología Red San Miguel, 2025

Emigrantes

La emigración de la población sanmiguelina está relacionada a la falta de oportunidades laborales y económicas, la mayoría depende de la agricultura y la ganadería de la zona. No hay oportunidad de seguir una carrera profesional, no existe universidad solo un pedagógico en la capital del distrito, situación que empuja a salir del lugar. En los últimos 7 años la provincia de San Miguel ha tenido 75,3 % de población emigrante, siendo La Florida la que mayor emigración registró (150,4 %), a diferencia de Tongod (26,2 %).

Tabla 14. Porcentaje de población emigrante por distritos, provincia San Miguel, 2017

Distrito	%
Bolívar	70,4
Calquis	44,3
Catilluc	36,0
El Prado	140,1
La Florida	150,4
Llapa	77,1
Nanchoc	61,9
Niepos	140,6
San Gregorio	122,9
San Miguel	88,12
San Silvestre de Cochán	29,5
Tongod	26,2
Unión Agua Blanca	47,7
Provincial	75,3

Fuente: Sistema de Información Distrital para la gestión pública -2017
Elaborado: Oficina Epidemiología Red San Miguel, 2025

5.4. Sistemas de salud

5.4.1.1. Establecimientos de salud

a. Saneamiento legal y título de propiedad de los establecimientos de salud de la provincia de San Miguel, 2025

El saneamiento físico legal es un proceso obligatorio mediante el cual la Dirección Regional de Salud Cajamarca regulariza la situación jurídica de los terrenos e infraestructura de los centros y puestos de salud.

San Miguel, hasta el año 2025 tuvo 18 (37,5 %) establecimientos de salud saneados y 30 (62,5 %) no cuentan con la documentación de saneamiento. La mayoría de los establecimientos de salud tienen más de 20 años de construcción y la mayor parte de ellos son terrenos que fueron donados por algún poblador o la comunidad, razón por la cual no cuentan con los documentos para poder iniciar los trámites de saneamiento físico legal.

Asimismo, solo el 31,2 % de los establecimientos de salud tienen título de propiedad, mientras que el 68,8 % no lo tienen.

Cuadro 4. Saneamiento físico legal de los establecimientos de salud, provincia San Miguel, 2025

Distrito	N° EE. SS	Saneamiento físico legal		Título de propiedad	
		Si	No	Si	No
Bolívar	2	2		2	
Calquis	3	2	1	2	1
Catilluc	2		2		2
El Prado	5	1	4	1	4
La Florida	1		1		1
Llapa	7	1	6	1	6
Nanchoc	2	1	1	1	1
Niepos	4	4		4	
San Gregorio	3	2	1	2	1
San Miguel	7	2	5	2	5
San Silvestre de Cochan	6		6		6
Tongod	4	3	1		4
Unión Agua Blanca	2		2		2
Total provincial	48	18	30	15	33

Fuente: Patrimonio - Red de Salud San Miguel, 2025.

Elaborado por epidemiología Red de Salud San Miguel, 2025

b. Número, tipo y categorías de los establecimientos de salud

El 87,5 % (42) de establecimientos de salud cuentan con categoría vigente y el 12,5 % (06) no cuentan con personal profesional, requisito solicitado para ser categorizado. Como provincia se tiene 48 establecimientos de salud, de los cuales 32 (66,7 %) son categoría I-1; 10 (20,8 %) son categoría I-2; 05 (10,4 %) son categoría I-3 y solo 01 (2,1 %) es categoría I-4. Todos los establecimientos del ámbito provincial son del primer nivel de atención, enfocados en actividades preventivas promocionales, así como atención básica y referencias.

Cuadro 5. Número y categoría de los establecimientos de salud, provincia San Miguel, 2025

N°	Distrito	Número de IPRESS por categoría			
		I-1	I-2	I-3	I-4
1	Bolívar	1	1		
2	Calquis	2	1		
3	Catilluc	1	1		
4	El Prado	2	2		
5	La Florida			1	
6	Llapa	6	1		
7	Nanchoc	1		1	
8	Niepos	3	1		
9	San Gregorio	2	1		
10	San Miguel	7			1
11	San Silvestre de Cochán	4	2		
12	Tongod	3		1	
13	Union Agua Blanca	1	1		

Fuente: Servicios de Salud - Red de Salud San Miguel, 2025

Elaborado por epidemiología Red de Salud San Miguel, 2025

c. Establecimientos de Salud con Funciones Obstétricas y Neonatales Básicas y Esenciales (FONE)

En el año 2000, el Ministerio de Salud (MINSA) define a las funciones obstétricas y neonatales como las actividades que están relacionadas con la identificación, atención, seguimiento y cuidado a los procesos de gestación, parto, puerperio, atención del recién nacido y planificación familiar; de acuerdo al nivel de complejidad del establecimiento de salud y de acuerdo al rol que cumple en el sistema local de salud. El resultado de la encuesta FON da como resultado la capacidad resolutoria que tienen los establecimientos de salud de producir el tipo de servicios necesarios de acuerdo a su nivel de suficiencia, para responder y/o solucionar las diversas necesidades de salud de la mujer y del recién nacido

en forma oportuna e integral (incluye la satisfacción de los usuarios), permitiendo diagnosticar y dar tratamiento adecuado a un determinado grado de complejidad de daño.

La provincia de San Miguel tiene 48 establecimientos de salud que pertenecen a la jurisdicción de la Red de Salud San Miguel, de los cuales uno, el C.S. San Miguel cumple Funciones Obstétricas Neonatales Básicas (FON-B), los demás establecimientos son FON-P. Para la evaluación del 2025, solo 01 IPRESS (C.S. Catilluc) obtuvo la condición de aprobada en relación a su capacidad resolutoria; los 47 restantes no aprobaron la evaluación de funciones obstétricas y neonatales.

Cuadro 6. Capacidad resolutoria de los establecimientos de salud FONE, provincia San Miguel, 2025

Distrito	N° EE. SS	Capacidad resolutoria FON-P				Capacidad resolutoria FON-B			
		Del 30% al 50%	Del 50% al 70%	Del 70% a < 90%	Del 90% a más	Del 30% al 50%	Del 50% al 70%	Del 70% a < 90%	Del 90% a más
Bolívar	2	1	1						
Calquis	3		3						
Catilluc	2			1	1				
El Prado	5	1	3	1					
La Florida	1			1					
Llapa	7	3	3	1					
Nanchoc	2	1		1					
Niepos	4	1	2	1					
San Gregorio	3		3						
San Miguel	7	3	3					1	
San Silvestre de Cochán	6	2	4						
Tongod	4		3	1					
Unión Agua Blanca	2		1	1					
Total provincial	48	12	26	8	1	0	0	1	0

Fuente: ESSR- Red de Salud San Miguel, 2025

Elaborado por epidemiología – Red de salud San Miguel, 2025

d. Referencias y Contrareferencias

Los establecimientos de salud de la provincia de San Miguel realizan procedimientos administrativos y médicos para garantizar la continuidad de atención de los pacientes en estado de emergencia o por patologías que no pueden ser atendidas en las IPRESS del ámbito, permitiendo un traslado adecuado y oportuno hacia los hospitales de mayor complejidad de la

ciudad de Cajamarca, como Hospital Regional Docente de Cajamarca y Hospital Simón Bolívar, en caso de los establecimientos ubicados en los distritos de Catilluc, Tongod, Llapa, San Silvestre de Cochan, Calquis, Unión Agua Blanca, San Miguel y El Prado; mientras que los establecimientos de los distritos de Niepos, La Florida, Nanchoc, San Gregorio y Bolívar trasladan sus pacientes a los hospitales de la región La Libertad y Chiclayo por mayor accesibilidad, situación que viene generando pérdida de recursos (combustible, viáticos), debido que las hojas de referencia no son firmados por el personal de salud de esas regiones dificultando la devolución del pago por el SIS.

Cuadro 7. Flujo de emergencia, provincia de San Miguel, 2025

Origen de la referencia			Destino de la referencia		Distancia (km) entre	Tiempo (horas)	Medio más usado en la
Distrito	EE.SS.	Nivel	EE.SS.	Nivel			
Bolívar	P.S. Bolívar	I-2	Hospital Las Mercedes	II-2	200 km	6,00 hrs	Carro
			C.S. Nanchoc	I-3	30 km	1,00 hrs	Carro
Calquis	P.S. Calquis	I-2	C.S. San Miguel	I-4	18 km	1,00 hrs	Carro
Catilluc	C.S. Catilluc	I-3	Hospital Regional Cajamarca	II-2	176 km	6,00 hrs	Carro
El Prado	P.S. El Prado	I-2	C.S. San Miguel	I-4	70 km	4,00 hrs	Carro
La Florida	C.S. La Florida	I-3	Hospital Las Mercedes	II-2	240 km	8,00 hrs	Carro
Llapa	C.S. Llapa	I-3	Hospital Regional Cajamarca	II-2	290km	9,00 hrs	Carro
			C.S. San Miguel	I-4	40km	1.50 hrs	Carro
Nanchoc	C.S. Nanchoc	I-3	Hospital Las Mercedes	II-2	180 km	5,00 hrs	Carro
Niepos	P.S. Niepos	I-2	Hospital Las Mercedes	I-3	260 km	9,00 hrs	Carro
San Gregorio	P.S. San Gregorio	I-1	Hospital Chepén	II-1	140 km	5,00 hrs	Carro
San Miguel	C.S. San Miguel	I-4	Hospital Regional Cajamarca	II-2	280 km	8,00 hrs	Carro
San Silvestre de Cochan	P.S.S.S. Cochan	I-2	Hospital Regional Cajamarca	II-2	160 km	6,00 hrs	Carro
			C.S. Llapa	I-3	30 km	1,00 hrs	Carro
Tongod	C.S. Tongod	I-3	Hospital Regional Cajamarca	II-2	210 km	7,00 hrs	Carro
Unión Agua Blanca	P.S. Unión Agua Blanca	I-2	C.S. San Miguel	I-4	108 km	5,00 hrs	Carro

Fuente: Servicios de Salud- Red de Salud San Miguel, 2025

Elaborado por epidemiología – Red de salud San Miguel, 2025

Los establecimientos de nivel I-3 y I-4 son los puntos de contención para la referencia de pacientes para consulta externa de las IPRESS del nivel I-1, debido que estos cuentan con equipo completo de salud. También contamos con algunos I-2 que cuenta con un equipo completo de salud, como son Niepos, Bolívar, Casa Blanca, Cochan y Quinden Bajo. Cuando se requiere evaluación por especialista, los pacientes son referidos al Hospital Docente de Cajamarca, Hospital Simón Bolívar; así como a establecimientos de la regional La Libertad y Lambayeque.

Cuadro 8. Flujo de consulta externa, provincia de San Miguel, 2025

Distrito	Origen de la referencia		Destino de la referencia para la consulta externa			Distancia (km) entre EE.SS	Tiempo (horas)	Medio usado en la referencia
	EE.SS.	Categoría	EE.SS	Categoría	Servicio:			
Bolívar	P.S. Bolívar	I-2	Hospital Las Mercedes	II-2	General, gineco-obstetricia, cirugía	200km	6,00 hrs	carro
			C.S. Nanchoc	I-3	General	30km	1,00 hrs	carro
Calquis	P.S. Calquis	I-2	C.S. San Miguel	I-4	General	18 km	1,00 hrs	carro
Catilluc	C.S. Catilluc	I-3	Hospital Regional Docente Cajamarca	II-2	Medicina interna, pediatría, cirugía general, ginecología y obstetricia medicina física y rehabilitación, traumatología y ortopedia, nefrología, cardiología, neurología, neumología, gastroenterología, reumatología, oftalmología, urología, otorrinolaringología, dermatología, endocrinología, hematología, geriatría, oncología médica, cirugía pediátrica, psiquiatría.	176 km	6,00 hrs	Carro
El Prado	P.S. El Prado	I-2	C.S. San Miguel	I-4	General	70 km	4,00 hrs	carro
La Florida	C.S. La Florida	I-3	Hospital Las Mercedes	II-2	General, gineco-obstetricia, cirugía	240km	8,00 hrs	carro
Llapa	C.S. Llapa	I-3	Hospital Simón Bolívar	II-E	Geriatría, cirugía general, oftalmología, cardiología, pediatría, medicina física, ginecología, dermatología, neurología y rehabilitación	290km	9,00 hrs	Carro
Nanchoc	C.S. Nanchoc	I-3	Hospital Las Mercedes	II-2	General, gineco-obstetricia, cirugía	180km	5,00 hrs	carro
Niepos	P.S. Niepos	I-2	C.S. La Florida	I-3	General	260km	9,00 hrs	carro
San Gregorio	P.S. San Gregorio	I-1	Hospital Chepén	II-1	General, gineco-obstetricia, cirugía	140 km	5,00 hrs	Carro
San Miguel	C.S. San Miguel	I-4	Hospital Regional Docente Cajamarca	II-2	Medicina interna, pediatría, cirugía general, ginecología y obstetricia medicina física y rehabilitación, traumatología y ortopedia, nefrología, cardiología, neurología, neumología, gastroenterología, reumatología, oftalmología, urología, otorrinolaringología, dermatología, endocrinología, hematología, geriatría, oncología médica, cirugía pediátrica, psiquiatría.	280 km	8,00 hrs	carro
			Hospital Simón Bolívar	II-E	Geriatría, cirugía general, oftalmología, cardiología, pediatría, medicina física, ginecología, dermatología, neurología y rehabilitación	200 km	8,00 hrs	carro
			C.S. Mental Comunitaria Esperanza de Vida		Salud Mental	250 km	8,00 hrs	carro
S.S. Cocha	P.S. S.S. Cochan	I-2	C.S. Llapa	I-3	General	12km	0.5 hrs	carro
Tongod	C.S. Tongod	I-3	Hospital Regional Docente Cajamarca	II-2	Medicina interna, pediatría, cirugía general, ginecología y obstetricia medicina física y rehabilitación, traumatología y ortopedia, nefrología, cardiología, neurología, neumología, gastroenterología, reumatología, oftalmología, urología, otorrinolaringología, dermatología, endocrinología, hematología, geriatría, oncología médica, cirugía pediátrica, psiquiatría.	210 km	7,00 hrs	Carro
Unión Agua	P.S. U. Agua Blanca	I-2	C.S. San Miguel	I-4	General	108 km	5,00 hrs	carro

Fuente: Servicios de Salud- Red de Salud San Miguel, 2025
Elaborado por epidemiología – Red de salud San Miguel, 2025

San Miguel cuenta con 09 IPRESS que brindan servicio de apoyo al diagnóstico, estos están ubicados en los distritos de La Florida, Niepos, Nanchoc, Quinden Bajo, San Miguel, Llapa, S.S. Cochan, Catilluc y Tongod; la mayoría cuenta con infraestructura, pero no todos tiene los insumos necesarios para realizar los procedimientos solicitados por el personal médico, dificultando un diagnóstico y tratamiento oportuno; situación que ocasiona que el paciente salga por sus propios recursos o por referencia hacia otros establecimientos de mayor complejidad.

Cuadro 9. Flujo de apoyo al diagnóstico, provincia de San Miguel, 2025

Distrito	Origen de la referencia		Destino de la referencia para la consulta externa:			Distancia (km) entre EE.SS	Tiempo (horas)	Medio usado en la referencia
	EE.SS.	Categoría	EE.SS	Categoría	Servicio:			
Bolívar	P.S. Bolívar	I-2	C.S. Nanchoc	I-3	Laboratorio, ecografía	30km	1	Carro
Calquis	P.S. Calquis	I-2	C.S. San Miguel	I-4	Laboratorio, ecografía	18km	1	Carro
Catilluc	C.S. Catilluc	I-3	Hospital Simón Bolívar	II-1	Laboratorio/rayos X	176km	6	Carro
El Prado	P.S. El Prado	I-2	C.S. San Miguel	I-4	Laboratorio, ecografía	70km	4	Carro
	P.S. El Guayo	I-1	P.S. Quinden Bajo	I-1	Laboratorio	40km	40min	Carro
La Florida	C.S. La Florida	I-3	Hospital Las Mercedes	II-2	Laboratorio/rayos X	240km	8	Carro
Llapa	C.S. Llapa	I-3	Hospital Regional Docente Cajamarca	II-2	Laboratorio/rayos X	290km	9	Carro
Nanchoc	C.S. Nanchoc	I-3	Hospital Las Mercedes	II-2	Laboratorio/rayos X	180km	5	Carro
Niepos	P.S. Niepos	I-2	Hospital Las Mercedes	II-2	Laboratorio/rayos X	260km	9	Carro
San Gregorio	P.S. San Gregorio	I-1	Hospital Chepén	II-1	Laboratorio/rayos X	140km	5	Carro
San Miguel	C.S. San Miguel	I-4	Hospital Regional Docente Cajamarca	II-2	Laboratorio/rayos X	280km	8	Carro
			Hospital Simón Bolívar	II-1	Laboratorio/rayos X	280km	8	Carro
S.S. Cochan	P.S. S.S Cochan	I-2	Hospital Regional Docente Cajamarca	II-2	Laboratorio/rayos X	160 km	6	Carro
Tongod	C.S. Tongod	I-3	Hospital Simón Bolívar	II-1	Laboratorio/rayos X	210km	7	Carro
Unión Agua Blanca	P.S. U. Agua Blanca	I-2	C.S. San Miguel	I-4	Laboratorio, ecografía	108km	5	Carro
	P.S. Lives	I-1	P.S. Quinden Bajo	I-1	Laboratorio	60km	1	Carro

Fuente: Servicios de Salud- Red de Salud San Miguel, 2025

Elaborado por epidemiología – Red de salud San Miguel, 2025

Referente al número de ambulancias por distritos, Catilluc y San Miguel cuenta con dos ambulancias cada uno para el traslado de pacientes, mientras que los distritos de Bolívar, Calquis y San Gregorio no cuentan con ninguna, siendo una brecha para el traslado oportuno de sus pacientes por emergencia. Debido al uso constante y la demanda de traslados por emergencia las ambulancias necesitan de mantenimiento preventivo y correctivo, servicio que no es realizado de forma oportuna por trámites burocráticos con nuestro ente rector (DIRESA

Cajamarca), poniendo en riesgo la vida del profesional y los pacientes. Mencionar que desde el 2024 la ambulancia de Tongod se encuentra inoperativa, en condición de baja en el sistema SIGA patrimonial.

Cuadro10. N° de ambulancias, provincia San Miguel, 2025

Distrito	N° ambulancias
Bolívar	0
Calquis	0
Catilluc	2
El Prado	1
La Florida	1
Llapa	1
Nanchoc	1
Niepos	1
San Gregorio	0
San Miguel	2
San Silvestre de Cochán	1
Tongod	1
Unión Agua Blanca	1

Fuente: Servicios de Salud- Red de Salud San Miguel, 2025

Elaborado por epidemiología – Red de salud San Miguel, 2025

e. Distancias y tiempos entre los establecimientos de salud y el establecimiento de referencia de la provincia de San Miguel

San Miguel tiene establecimientos de salud que se ubican desde 30 minutos hasta 06 horas del centro referencial de la provincia (C.S. San Miguel), que este a su vez refiere a los hospitales de la ciudad de Cajamarca, en un tiempo de 8 horas entre ida y vuelta. La distancia va desde los 16 km hasta los 290 km, dependiendo del estado de las carreteras y el clima.

Cuadro 11. Distancias y tiempo entre los establecimientos de referencia, provincia San Miguel, 2025

Origen de la referencia			Destino de la referencia		Distancia (km) entre EE.SS.	Tiempo (horas)	Medio más usado en la referencia
Distrito	EE.SS.	Nivel	EE.SS.	Nivel			
Bolívar	P.S. Bolívar	I-2	Hospital Las Mercedes	II-2	200 km	6,00 hrs	Carro
			C.S. Nanchoc	I-3	30 km	1,00 hrs	Carro
Calquis	P.S. Calquis	I-2	C.S. San Miguel	I-4	18 km	1,00 hrs	Carro
Catilluc	C.S. Catilluc	I-3	Hospital Regional Cajamarca	II-2	176 km	6,00 hrs	Carro
El Prado	P.S. El Prado	I-2	C.S. San Miguel	I-4	70 km	4,00 hrs	Carro
La Florida	C.S. La Florida	I-3	Hospital Las Mercedes	II-2	240 km	8,00 hrs	Carro
Llapa	C.S. Llapa	I-3	Hospital Regional Cajamarca	II-2	290km	9,00 hrs	Carro
			C.S. San Miguel	I-4	40km	1.50 hrs	Carro
Nanchoc	C.S. Nanchoc	I-3	Hospital Las Mercedes	II-2	180 km	5,00 hrs	Carro
Niepos	P.S. Niepos	I-2	Hospital Las Mercedes	I-3	260 km	9,00 hrs	Carro
San Gregorio	P.S. San Gregorio	I-1	Hospital Chapén	II-1	140 km	5,00 hrs	Carro
San Miguel	C.S. San Miguel	I-4	Hospital Regional Cajamarca	II-2	280 km	8,00 hrs	Carro
San Silvestre de Cochán	P.S.S.S. Cochán	I-2	Hospital Regional Cajamarca	II-2	160 km	6,00 hrs	Carro
			C.S. Llapa	I-3	30 km	1,00 hrs	Carro
Tongod	C.S. Tongod	I-3	Hospital Regional Cajamarca	II-2	210 km	7,00 hrs	Carro
Unión Agua Blanca	P.S. Unión Agua Blanca	I-2	C.S. San Miguel	I-4	108 km	5,00 hrs	Carro

Fuente: Servicios de Salud - Red de Salud San Miguel, 2025

Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

5.4.1.2. Recursos humanos

a. Número de recurso humano por régimen laboral

La Red de Salud San Miguel tiene dentro de su ámbito 366 trabajadores, de los cuales 288 son trabajadores nombrados (DL. 276) y SERUMS, 48 son trabajadores CAS, 06 son locadores y 24 son trabajadores, 728 y por reposición judicial, todos están debidamente registrados en aplicativo INFORHUS, ingreso que lo realiza el personal de recursos humanos de DIRESA Cajamarca.

Los recursos humanos en salud comprenden el conjunto de profesionales, técnicos y personal auxiliar que desempeñan funciones asistenciales, administrativas, de gestión y apoyo en los establecimientos de salud, contribuyendo al cuidado, recuperación y mantenimiento de la salud de la población. Constituyen un componente fundamental del sistema de salud, ya que de su disponibilidad, distribución, competencias y desempeño depende en gran medida la calidad, oportunidad y continuidad de los servicios de salud.

El estudio de los recursos humanos permite evaluar la capacidad operativa de los establecimientos de salud para responder a las necesidades sanitarias de la población, identificando brechas de personal que puedan afectar el acceso y la calidad de la atención

El cuadro muestra que la provincia de San Miguel dispone principalmente de personal profesional y técnico para la prestación de servicios de salud, lo que fortalece la capacidad operativa de la red. Sin embargo, la importante proporción de trabajadores bajo regímenes temporales o de contratación administrativa refleja la necesidad de continuar fortaleciendo la estabilidad laboral del recurso humano, elemento clave para garantizar la continuidad, calidad y sostenibilidad de la atención en salud

Cuadro 12. Recurso humano según régimen laboral, provincia San Miguel, 2025

Grupo ocupacional	DL. 276	DL. 1057	Locación de servicios	Otro	Total
Funcionarios y Directivos	1				1
Profesionales	205	41	5	2	253
Técnicos	82	7	1		90
Otros				22	22
Total	288	48	6	24	366

Fuente: Recursos Humanos - Red de Salud San Miguel, 2025

Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2026

b. Número de recurso humano asistencial por tipo de cargo y tipo de régimen

La Red San Miguel cuenta con 24 profesionales médicos, de los cuales 20 son nombrados y SERUMS; 66 licenciados en enfermería, en su mayoría nombrados y SERUMS (52); 33 obstetras, mayormente nombrados y SERUMS (31); 11 psicólogos, 04 son SERUMS; 09 odontólogos, 05 SERUMS; 90 técnicos, 82 nombrados; y 109 profesionales de otras ramas, de los cuales 94 nombrados, entre ellos tenemos biólogos, médico veterinario, tecnólogos, ingeniero, abogado, otros.

En relación con el régimen laboral, predomina el personal nombrado bajo el régimen 276, con 288 trabajadores (84,21 %), seguido del régimen 1057 (CAS) con 48 trabajadores (14,04 %) y 6 trabajadores (1,75 %) prestan servicios mediante locación de servicios.

A pesar de contar con un robusto equipo de técnicos, y un número razonado enfermeros y obstetras distribuidos en el primer nivel de atención, la provincia sigue presenta una severa brecha de profesionales de salud como enfermeros, médico generales y especialistas. La presencia de un único Pediatra y un internista para toda la provincia restringe la capacidad de respuesta. Asimismo, el no contar con gineco-obstetra para la atención de las emergencias obstétricas y neonatales complejas que se registran en la provincia, se corre el riesgo de registrar muertes maternas en algún distrito del ámbito, pues en los últimos dos años se registraron 10 morbilidades materna extrema. Situación que limita la capacidad resolutoria del único establecimiento FONB (C.S. San Miguel) elevando la tasa de referencias hacia hospitales de mayor complejidad en la región (Cajamarca). para poder brindar una atención de calidad y con enfoque integral se necesita que todos los establecimientos de salud cuenten como mínimo con un equipo médico multidisciplinario.

Cuadro 13. Recurso humano según grupo ocupacional, provincia San Miguel, 2025

Cargo	DL. 276	DL. 1057	Locación de servicios	Otro	Total
Médicos	20	4			24
Enfermeros	52	12	2		66
Obstetras	31	2			33
Psicólogos	4	7			11
Odontólogos	5	4			9
Técnicos	82	7	1		90
Otros	94	12	3		109
Total	288	48	6	0	342

Fuente: Recursos Humanos - Red de Salud San Miguel, 2025

Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2026

c. Número de recurso humano administrativo por tipo de cargo y tipo régimen

La Red de Salud San Miguel cuenta con 24 trabajadores administrativos, de los cuales 18 son régimen laboral 728 y por reposición judicial.

El diagnóstico situacional del componente administrativo de la Red San Miguel para el año 2025 registra un total de 24 servidores públicos, cuya estructura contractual y distribución

funcional evidencia una marcada concentración en regímenes de contratación temporal y brechas críticas de personal especializado. Esta configuración presupuestaria y contractual expone que más del 75 % del soporte administrativo de la institución se encuentra bajo condiciones de temporalidad o de terceros, lo que demanda estrategias orientadas a la sostenibilidad y continuidad operativa de la gestión.

En el ámbito funcional, la distribución de los cargos denota un fuerte componente operativo y de soporte general, reflejado en los 18 servidores adscritos a la categoría de "Otros", la cual engloba las actividades técnico-administrativas esenciales de la red.

No obstante, el hallazgo más crítico del análisis se centra en la inexistencia absoluta de profesionales en las áreas de asesoría legal e ingeniería, registrándose cero (0) plazas cubiertas para los cargos de Abogado e Ingeniero en todas las modalidades de contratación. Esta carencia técnico-profesional representa una debilidad institucional severa, puesto que limita la capacidad de la Red Integrada de Salud para optimizar sus procesos de saneamiento legal, contrataciones, soporte de sistemas y gestión de la infraestructura sanitaria, configurándose como una prioridad inmediata para las próximas convocatorias y planes de asignación de personal.

Cuadro 14. Recurso humano administrativo según profesión, provincia San Miguel, 2025

Cargo	DL. 276	DL. 1057	Locación de servicios	Otro	Total
Abogado					0
Chofer	2	2			4
Ingeniero			2		2
Otros				18	18
Total	2	2	2	18	24

Fuente: Recursos Humanos - Red de Salud San Miguel, 2025

Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

5.4.1.3. Equipamiento

El equipamiento de los establecimientos de salud es un tema complejo que se ve reflejado en la atención directa de la población. Los establecimientos de primer nivel de atención como los puestos y centros de salud, según su nivel de categoría, deben contar con equipos básicos como: estetoscopios, tensiómetros, balanzas pediátricas y de pie, camillas de examen, cajas de parto e instrumental para suturas simples, esterilizadores, ecógrafos, unidades odontológicas y equipos básicos para laboratorio clínico.

El distrito de Bolívar tiene dos establecimientos de salud, el P.S. Bolívar (I-2) y P.S. San José (I-1), ambos tienen 25 equipos médicos, de los cuales 17 están operativos y 8 se encuentran inoperativos. No han recibido algún tipo de mantenimiento.

Cuadro 15. Equipamiento de los establecimientos de salud del distrito de Bolívar, provincia San Miguel, 2025

Equipos	Cantidad	Estado
Congeladora para vacunas	2	Operativo
Refrigeradora para vacunas	2	Inoperativo
Detector de latidos fetales portátil	4	Operativo
Detector de latidos fetales portátil	2	Inoperativo
Equipo nebulizador eléctrico portátil	1	Operativo
Hemoglobinómetro portátil	4	Operativo
Hemoglobinómetro	2	Inoperativo
Oftalmoscopio directo con mango recargable	2	Inoperativo
Glucómetro portátil	5	Operativo
Fetoscopio de pinar	1	Operativo
Total	25	

Fuente: Patrimonio - Red de Salud San Miguel, 2025

Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

El distrito de Calquis tiene tres establecimientos de salud en su ámbito, el P.S. Calquis (I-2), P.S. Taulis (I-1) y P.S. Gordillos (I-1); los cuales reportan 68 equipos médicos, 43 operativos y 25 inoperativos. Tampoco han recibido algún tipo de mantenimiento.

Cuadro 16. Equipamiento de los establecimientos de salud del distrito de Calquis, provincia San Miguel, 2025

Equipos	Cantidad	Estado
Refrigeradora para vacunas	9	Operativo
Refrigeradora para vacunas	2	Inoperativo
Congeladora para vacunas y paquetes	4	Operativa
Equipo nebulizador eléctrico portátil	1	Operativa
Equipo Doppler fetal portátil	5	Operativo
Detector de latidos fetales portátil	2	Inoperativo
Detector de latidos fetales de sobremesa	3	Inoperativo
Esterilizador eléctrico	1	Inoperativo
Esterilizador de calor seco	2	Operativo
Hemoglobinómetro portátil	10	Operativo
Hemoglobinómetro portátil	2	Inoperativo
Oftalmoscopio directo	1	Operativo
Pantoscopio	1	Inoperativo
Resucitador para adultos	2	Operativo
Resucitador neonatal	1	Operativo
Tensiómetro	14	Inoperativo
Tensiómetro	7	Operativo
Glucómetro portátil	1	Operativo
Total	68	

Fuente: Patrimonio - Red de Salud San Miguel, 2025

Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

El distrito de Catilluc tiene dos establecimientos de salud, el C.S. Catilluc (I-3) y P.S. Quilcate Alto (I-2), entre ambos reportan 79 equipos médicos, 64 operativos y 15 inoperativos. Catilluc por ser un establecimiento de mayor nivel cuenta con más equipamiento, en comparación a Quilcate Alto. Tampoco han recibido algún tipo de mantenimiento.

Cuadro 17. Equipamiento de los establecimientos de salud del distrito de Catilluc,
provincia San Miguel, 2025

Equipos	Cantidad	Estado
Refrigeradora congeladora	4	Operativo
Refrigeradora conservadora	7	Operativo
Detector de latidos fetales portátiles	3	Operativo
Equipo de crioterapia	1	Operativo
Equipo de rayos x dental rodable	1	Operativo
Equipo Doppler fetal portátil	4	Operativo
Equipo nebulizador	1	Operativo
Esterilizador	2	Operativo
Esterilizador	1	Inoperativo
Hemoglobinómetro portátil	6	Operativo
Oftalmoscopio directo	1	Operativo
Pantoscopio pediátrico	1	Operativo
Pantoscopio pediátrico	1	Operativo
Unidad dental eléctrica completa	1	Operativo
Unidad dental eléctrica completa	1	Inoperativo
Glucómetro portátil	4	Operativo
Equipo de baño maría	1	Operativo
Ecógrafo portátil	2	Operativo
Tensiómetro aneroide para adulto	20	Operativo
Tensiómetro aneroide para adulto	10	Inoperativo
Tensiómetro aneroide pediátrico	4	Operativo
Refrigeradora a kerosene	2	Inoperativo
Hemoglobinómetro portátil	1	Inoperativo
Total	79	

Fuente: Patrimonio - Red de Salud San Miguel, 2025

Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

El distrito El Prado tiene cinco establecimientos de salud en su ámbito, el P.S. El Prado (I-2), P.S. Lamasampa (I-2), P.S. Quinden Bajo (I-1), El Guayo (I-1) y P.S. Las Pencas (I-1); los cuales reportan 68 equipos médicos (43 operativos y 25 inoperativos), cantidad similar a los establecimientos del distrito de Calquis; observando la brecha de equipamiento en El Prado, pues este cuenta con más IPRESS en comparación a Calquis. Tampoco han recibido algún tipo de mantenimiento.

Cuadro 18. Equipamiento de los establecimientos de salud del distrito de El Prado, provincia

San Miguel, 2025

Equipos	Cantidad	Estado
Refrigeradora para vacunas	9	Operativo
Refrigeradora para vacunas	2	Inoperativo
Congeladora para vacunas y paquetes	4	Operativa
Equipo nebulizador eléctrico portátil	1	Operativa
Equipo Doppler fetal portátil	5	Operativo
Detector de latidos fetales portátil	2	Inoperativo
Detector de latidos fetales de sobremesa	3	Inoperativo
Esterilizador eléctrico	1	Inoperativo
Esterilizador de calor seco	2	Operativo
Hemoglobinómetro portátil	10	Operativo
Hemoglobinómetro portátil	2	Inoperativo
Oftalmoscopio directo	1	Operativo
Pantoscopio	1	Inoperativo
Resucitador para adultos	2	Operativo
Resucitador neonatal	1	Operativo
Tensiómetro	14	Inoperativo
Tensiómetro	7	Operativo
Glucómetro portátil	1	Operativo
Total	68	

Fuente: Patrimonio - Red de Salud San Miguel, 2025

Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

El distrito de La Florida es el único que tiene un solo establecimiento de salud en su ámbito y es de nivel I-3; cuenta con 73 equipos médicos, de los cuales 61 están operativos y 12 inoperativos, tampoco han recibido algún tipo de mantenimiento.

Cuadro 19. Equipamiento de los establecimientos de salud del distrito de La Florida, provincia San Miguel, 2025

Equipos	Cantidad	Estado
Refrigeradora para vacunas	4	Operativas
Refrigeradora para vacunas	2	Inoperativas
Congeladora eléctrica horizontal	2	Operativas
Autoclave	1	Operativas
Analizador bioquímico	3	Operativas
Parlantes para computadora	1	Inoperativas
Aspiradora de secreciones para adultos	3	Operativas
Aspirador de secreciones	1	Inoperativas
Centrifuga para 12 tubos	3	Operativas
Contador mecánico de células	1	Inoperativas
Detector de latidos fetales portátil	3	Operativas
Electrocardiógrafo	1	Operativas
Pantoscopio	2	Operativas
Pantoscopio pediátrico	1	Inoperativas
Resucitador manual pediátrico	1	Operativas
Tonómetro aplanético	1	Operativas
Unidad dental eléctrica completa	1	Operativas
Glucómetro portátil	3	Operativas
Equipo de rayos x dental rodable	1	Inoperativas
Equipo ecógrafo - ultrasonido portátil	1	Operativas
Equipo nebulizador eléctrico portátil	1	Inoperativas
Equipo nebulizador	3	Operativas
Equipo baño maría	1	Inoperativas
Equipo de baño maría	1	Operativas
Hemoglobinómetro portátil	4	Operativas
Tensiómetro aneroide para adulto	22	Operativas
Tensiómetro aneroide para adulto	3	Inoperativas
Tensiómetro aneroide pediátrico	2	Operativas
Total	73	

Fuente: Patrimonio - Red de Salud San Miguel, 2025

Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

El distrito de Llapa tiene siete establecimientos de salud en su ámbito, el C.S. Llapa (I-3), el P.S. Sabana (I-1), P.S. Pabellon Chico (I-1), P.S. Pampacuyoc (I-1), P.S. Uchuquinua (I-1), P.S. San Antonio de Ojos y P.S. La Calzada (I-1); los cuales reportan 130 equipos médicos; 101 operativos y 29 inoperativos. Tampoco han recibido algún tipo de mantenimiento.

Cuadro 20. Equipamiento de los establecimientos de salud del distrito de Llapa, provincia San Miguel, 2025

Equipos	Cantidad	Estado
Refrigeradora para vacunas	8	Operativo
Congeladora para vacunas y paquetes fríos 271 lt	6	Operativo
Autoclave	1	Inoperativo
Equipo de rayos X dental rodable	1	Inoperativo
Equipo nebulizador eléctrico portátil	3	Operativo
Equipo nebulizador eléctrico portátil	1	Inoperativo
Equipo Doppler fetal portátil	7	Operativo
Equipo de baño maría	5	Operativo
Equipo de alta frecuencia facial portátil	2	Operativo
Hemoglobinómetro portátil	16	Operativo
Hemoglobinómetro portátil	1	Inoperativo
Oftalmoscopio directo con mango recargable	2	Operativo
Pantoscopio	4	Operativo
Pantoscopio	2	Inoperativo
Resucitador manual adulto	1	Operativo
Unidad dental eléctrica completa	1	Operativo
Glucómetro	11	Operativo
Tensiómetro adulto	33	Operativo
Tensiómetro adulto	22	Inoperativo
Esterilizador	2	Operativo
Detector de latidos fetales portátiles	1	Inoperativo
Total	130	

Fuente: Patrimonio - Red de Salud San Miguel, 2025

Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

El distrito de Nanchoc tiene dos establecimientos de salud en su ámbito, el P.S. C.S. Nanchoc (I-3) y P.S. Carahuasi (I-1); entre ambos reportan 52 equipos médicos, de los cuales 41 están operativos y 11 inoperativos. Tampoco han recibido algún tipo de mantenimiento.

Cuadro 21. Equipamiento de los establecimientos de salud del distrito de Nanchoc, provincia San Miguel, 2025

Equipos	Cantidad	Estado
Congeladora eléctrica horizontal	3	Operativo
Congeladora eléctrica horizontal	1	Inoperativo
Refrigeradora para vacunas	8	Operativo
Refrigeradora para vacunas	2	Inoperativo
Centrifuga para 12 tubos	3	Operativo
Detector de latidos fetales portátil	3	Operativo
Detector de latidos fetales portátil	1	Inoperativo
Equipo ecógrafo - ultrasonido de 2 transductores	1	Operativo
Equipo nebulizador	3	Operativo
Equipo nebulizador	1	Inoperativo
Equipo baño maría	2	Operativo
Laringoscopio	1	Operativo
Microcentrífuga	1	Operativo
Oftalmoscopio directo	2	Inoperativo
Pantoscopio	2	Operativo
Resucitador manual pediátrico	1	Inoperativo
Resucitador manual adulto	1	Operativo
Unidad dental eléctrica completa	1	Operativo
Glucómetro portátil	4	Operativo
Hemoglobinómetro portátil	5	Operativo
Tensiómetro	3	Operativo
Tensiómetro	3	Inoperativo
Total	52	

Fuente: Patrimonio - Red de Salud San Miguel, 2025

Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

El distrito de Niepos tiene tres establecimientos de salud, el P.S. Niepos (I-2), P.S. El Naranjo (I-1), P.S. Lanchez (I-1) y P.S. Miravalles (I-1), entre todos suman 59 equipos médicos, de los cuales 48 están operativos y 11 inoperativos; ninguno ha recibido mantenimiento.

Cuadro 22. Equipamiento de los establecimientos de salud del distrito de Niepos, provincia San Miguel, 2025

Equipos	Cantidad	Estado
Refrigeradora para vacunas	7	Operativo
Congeladora eléctrica horizontal	4	Operativo
Detector de latidos fetales portátiles	3	Inoperativo
Detector de latidos fetales portátil	9	Operativo
Esterilizador eléctrico de aire seco x 39 lt	3	Operativo
Esterilizador	1	Inoperativo
Hemoglobínómetro portátil	2	Inoperativo
Hemoglobínómetro portátil	9	Operativo
Microcentrífuga	1	Operativo
Microscopio compuesto binocular	1	Operativo
Oftalmoscopio directo	1	Operativo
Espectrofotómetro	1	Operativo
Glucómetro portátil	5	Operativo
Glucómetro portátil	3	Inoperativo
Tensiómetro aneroide para adulto	6	Operativo
Tensiómetro aneroide para adulto	2	Inoperativo
Tensiómetro aneroide pediátrico	1	Operativo
Total	59	

Fuente: Patrimonio - Red de Salud San Miguel, 2025

Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

El distrito de San Gregorio tiene tres establecimientos de salud, el P.S. Casa Blanca (I-2), P.S. El Sauce (I-1) y P.S. San Gregorio (I-1), todos ellos suman un total de 40 equipos médicos, de los cuales 24 están operativos y 16 inoperativos; ninguno ha recibido mantenimiento.

Cuadro 23. Equipamiento de los establecimientos de salud del distrito de San Gregorio, provincia San Miguel, 2025

Equipos	Cantidad	Estado
Refrigeradora para vacunas	2	Operativo
Refrigeradora a kerosene	6	Inoperativo
Congeladora para vacunas	2	Operativo
Detector de latidos fetales portátil	6	Operativo
Hemoglobinómetro portátil	8	Operativo
Microscopio	1	Operativo
Glucómetro portátil	3	Operativo
Detector de latidos fetales portátil	1	Inoperativo
Congeladora para vacunas	1	Operativo
Detector de latidos fetales portátil	3	Inoperativo
Equipo Doppler fetal portátil	1	Inoperativo
Equipo ecógrafo básico de sobremesa	1	Inoperativo
Equipo nebulizador eléctrico portátil	1	Inoperativo
Hemoglobinómetro	1	Inoperativo
Laringoscopio	1	Inoperativo
Oftalmoscopio directo	1	Operativo
Glucómetro portátil	1	Inoperativo
TOTAL	40	

Fuente: Patrimonio - Red de Salud San Miguel, 2025

Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

El distrito de San Miguel tiene seis establecimientos de salud en su ámbito, el C.S. San Miguel (I-4), P.S. Chuad (I-1), P.S. Nitisuyo Alto (I-1), P.S. Santa Rosa (I-1), P.S. Tayapampa (I-1) y P.S. Chiapon (I-1), todos ellos suman un total de 254 equipos médicos, de los cuales 222 están operativos y 32 inoperativos; ningún equipo ha recibido mantenimiento.

Cuadro 24. Equipamiento de los establecimientos de salud del distrito de San Miguel, provincia San Miguel, 2025

Equipo	Cantidad	Estado
Esterilizador	9	Operativo
Esterilizador	3	Inoperativa
Analizador bioquímico	2	Operativo
Aspirador de secreciones	7	Operativo
Balanza	22	Operativo
Centrifuga para tubos	5	Operativo
Microcentrífuga	1	Operativo
Microcentrífuga	1	Inoperativa
Congeladora para vacunas y paquetes fríos	12	Operativo
Refrigeradora para vacunas	17	Operativo
Desfibrilador	3	Operativo
Cuna de calor radiante	2	Operativo
Cuna de calor radiante	1	Inoperativa
Bomba de infusión	5	Operativo
Detector de latidos fetales	23	Operativo
Detector de latidos fetales	4	Inoperativa
Equipo ecógrafo	3	Operativo
Electrocardiógrafo	2	Operativo
Equipo electroestimulador	1	Operativo
Equipo de anestesia de dos gases	1	Operativo
Equipo de termocoagulación	2	Operativo
Equipo de crioterap	1	Operativo
Equipo de fotopolimerización	1	Operativo
Equipo de rayos x dental	1	Operativo
Equipo de rayos x dental	1	Inoperativa
Equipo nebulizador	4	Operativo
Equipo nebulizador	3	Inoperativa
Equipo de baño maría	2	Operativo
Hemoglobinómetro portátil	21	Operativo
Hemoglobinómetro portátil	5	Inoperativa
Tensiómetro aneroide para adulto	61	Operativo
Tensiómetro aneroide para adulto	14	Inoperativa
Tensiómetro pediátrico	7	Operativo
Glucómetro portátil	7	Operativo
Total	254	

Fuente: Patrimonio - Red de Salud San Miguel, 2025

Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

El distrito de San Silvestre de Cochán tiene seis establecimientos de salud en su ámbito, el P.S. S.S. Cochán (I-2), P.S. Tantachual Bajo (I-1), P.S. Lucmillo (I-1), P.S. El Tambo (I-1), P.S. Cobro Negro (I-1) y P.S. Chiapon (I-1), todos ellos suman un total de 84 equipos médicos, de los cuales 75 están operativos y 09 inoperativos; ningún equipo ha recibido mantenimiento.

Cuadro 25. Equipamiento de los establecimientos de salud del distrito de San Silvestre de Cochán, provincia San Miguel, 2025

Equipo	Cantidad	Estado
Refrigeradora para vacunas	7	Operativa
Refrigeradora a kerosene	5	Inoperativas
Congeladora para vacunas	5	Operativa
Oftalmoscopio directo	1	Operativa
Detector de latidos fetales portátil	18	Operativa
Detector de latidos fetales portátil	3	Inoperativas
Hemoglobinómetro portátil	16	Operativa
Hemoglobinómetro portátil	1	Inoperativas
Glucómetro portátil	7	Operativa
Equipo nebulizador eléctrico portátil	1	Operativa
Centrifuga para tubos	1	Operativa
Resucitador manual adulto	1	Operativa
Tensiómetro adulto	17	Operativa
Pantoscopio	1	Operativa
Total	84	

Fuente: Patrimonio - Red de Salud San Miguel, 2025

Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

El distrito de Tongod tiene cuatro establecimientos de salud en su ámbito, el C.S. Tongod (I-3), P.S. Pisit (I-1), P.S. La Coronilla (I-1) y P.S. Chucllapampa (I-1), todos ellos suman un total de 73 equipos médicos, de los cuales 48 están operativos y 25 inoperativos; ningún equipo ha recibido mantenimiento.

Cuadro 26. Equipamiento de los establecimientos de salud del distrito de Tongod, provincia San Miguel, 2025

Equipo	Cantidad	Estado
Congeladora eléctrica horizontal	4	Operativa
Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 48 L	4	Operativa
Refrigeradora a gas	1	Inoperativo
Analizador bioquímico semiautomatizado	1	Operativa
Aspirador de secreciones	2	Operativa
Centrifuga para tubos	2	Operativa
Detector de latidos fetales portátil	10	Operativa
Detector de latidos fetales portátil	2	Inoperativo
Equipo nebulizador	2	Operativa
Equipo nebulizador	1	Inoperativo
Esterilizador	4	Inoperativo
Hemoglobinómetro portátil	8	Operativa
Hemoglobinómetro portátil	1	Inoperativo
Microcentrífuga	1	Inoperativo
Oftalmoscopio directo	2	Operativa
Pantoscopio pediátrico	1	Operativa
Resucitador para adultos	1	Operativa
Resucitador para adultos	1	Inoperativo
Unidad dental	1	Operativa
Glucómetro	4	Operativa
Glucómetro	4	Inoperativo
Tensiómetro aneroide para adulto	6	Operativa
Tensiómetro aneroide para adulto	10	Inoperativo
Total	73	

Fuente: Patrimonio - Red de Salud San Miguel, 2025

Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

El distrito de Unión Agua Blanca tiene dos establecimientos de salud en su ámbito, el P.S. Unión Agua Blanca (I-2) y P.S. Lives (I-1), ambos suman un total de 73 equipos médicos, de los cuales 48 están operativos y 25 inoperativos; ningún equipo ha recibido mantenimiento.

Cuadro 27. Equipamiento de los establecimientos de salud del distrito Unión Agua Blanca, provincia San Miguel, 2025

Equipo	Cantidad	Estado
Congeladora eléctrica horizontal	2	Operativo
Refrigeradora conservadora	2	Operativo
Refrigeradora a kerosene	1	Inoperativa
Detector de latidos	3	Inoperativa
Detector de latidos fetales portátil	5	Operativo
Detector de latidos fetales de sobremesa	1	Operativo
Equipo nebulizador	3	Operativo
Fetoscopio	3	Operativo
Hemoglobinómetro	6	Operativo
Resucitador manual pediátrico	1	Operativo
Tensiómetro adulto	6	Operativo
Tensiómetro pediátrico	2	Operativo
Tensiómetro adulto	6	Inoperativa
Glucómetro portátil	5	Operativo
Total	46	

Fuente: Patrimonio - Red de Salud San Miguel, 2025

Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

5.4.1.4. Infraestructura

La provincia de San Miguel cuenta con 48 establecimientos de salud, que corresponden al modelo de atención primaria de salud, donde la población accede a servicios básicos de prevención y promoción, así como atención ambulatoria. La dispersión geográfica de la provincia y sus comunidades, y la demanda de servicios sanitarios han mostrado una deficiente infraestructura, limitada capacidad de respuesta y equipamiento, no permiten brindar una atención integral y oportuna.

La mayoría de establecimientos fueron construidos hace varios años atrás, y actualmente presenten deterioro por el paso del tiempo y las condiciones climáticas, además del limitado presupuesto para su mantenimiento preventivo. Se ha observado ambientes reducidos para consulta, no hay accesibilidad para las personas con discapacidad, no cuentan con áreas administrativas, deficiente sistemas eléctricos y de saneamiento.

El 29,2 % de establecimientos se encuentra en aparente buen estado de infraestructura, mientras que el 70,8 % están en malas condiciones y necesitan ser intervenidas.

Cuadro 28. Infraestructura de los establecimientos de salud de la Red de Salud San Miguel, provincia San Miguel, 2025

Distrito	N° EE. SS	Estado de la infraestructura	
		Bueno	Malo
Bolívar	2	1	1
Calquis	3	1	2
Catilluc	2		2
El Prado	5		5
La Florida	1		1
Llapa	7	3	4
Nanchoc	2	1	1
Niepos	4		4
San Gregorio	3	2	1
San Miguel	7		7
San Silvestre de Cochan	6	2	4
Tongod	4	4	
Unión Agua Blanca	2		2
Total provincial	48	14	34

Fuente: Patrimonio - Red de Salud San Miguel, 2025

Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

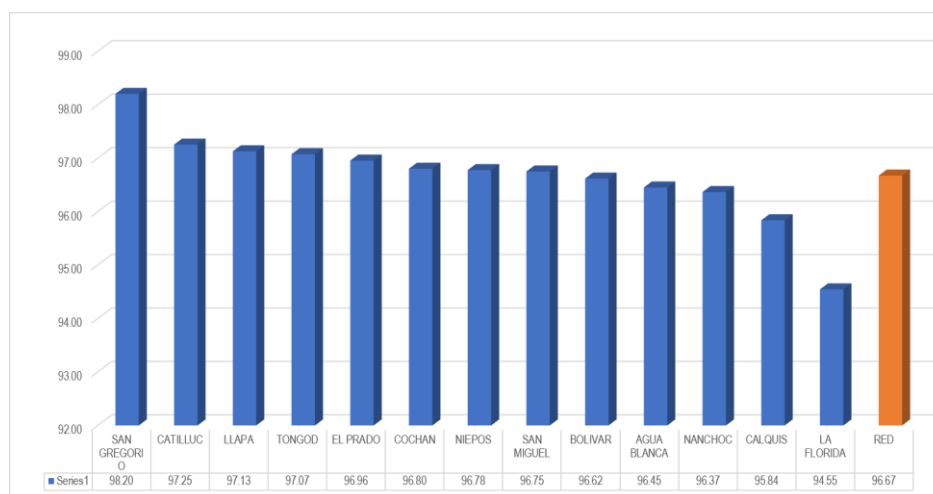
5.4.1.5. Medicamentos

La provincia de San Miguel, para el 2025 alcanzó una disponibilidad promedio del 96,65 % de medicamentos en los 48 establecimientos de salud, porcentaje mayor a la meta regional (>90 %); este logro fue gracias a la gestión constante que realizó el área de SISMED con las diferentes IPRESS, para procesos de redistribuciones, así como con DIREMID Cajamarca para los abastecimientos adicionales.

Los establecimientos de los distritos de Nanchoc, Bolívar y San Gregorio, que conforman la micro red Nanchoc obtuvieron el 97, 23 % de disponibilidad, en comparación a la micro red La Florida (distrito Niepos y La Florida) que obtuvieron el 94,81 %.

Por distritos, San Gregorio obtuvo el mejor porcentaje con 98, 2 % y La Florida solo logró un 94,6 %, la causa del no cumplimiento del 100% se debe a que la DIRESA Cajamarca no cuentan en su totalidad con los medicamentos requeridos.

Gráfico 2. Porcentaje de disponibilidad de medicamentos esenciales por distritos, provincia de San Miguel, 2025



Fuente: SISMED - Red de Salud San Miguel, 2025

5.4.1.6. Residuos sólidos

La vigilancia sanitaria de residuos sólidos hospitalarios en la provincia de San Miguel enfrenta una brecha muy importante en la norma sanitaria y las limitaciones logísticas de cada uno de los establecimientos de salud, situación que se evidencia al momento de realizar la supervisión y monitoreo mediante la aplicación de la Ficha 1 y 2, con la finalidad de verificar y evaluar el cumplimiento de los criterios administrativos establecidos y fortalecer la gestión institucional, así como con el manejo de las etapas de la gestión del manejo de los residuos hospitalarios.

El 80% de los establecimientos evaluado alcanzaron una calificación aceptable en la ficha 1, lo que evidencia un nivel adecuado de cumplimiento en la gestión administrativa; mientras que en la ficha 2 solo el 12,5 % (06) obtuvieron un puntaje aceptable, lo que indica el cumplimiento de las etapas de la gestión de los residuos hospitalarios, desde el acondicionamiento hasta la disposición final; el cumplimiento de estos establecimientos de salud se debe a que cuentan con una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) encargada de realizar el recojo y disposición final de los residuos generados (C.S. Catilluc, C.S. Tongod, C.S. Llapa y C.S. San Miguel), mientras que La Florida y Nanchoc tienen habilitado un micro relleno en buenas condiciones.

El incumplimiento de la gestión del manejo de residuos hospitalarios, está relacionada con la falta de presupuesto por parte del ente rector (DIRESA) para la construcción de área de almacenamiento de los residuos, así como para la contratación de un EO-RS para el recojo y disposición final, motivo por el cual el personal de salud busca otras alternativas para poder

evitar la “contaminación”, construyendo un mal llamado micro relleno donde dispone los residuos generados en la atención de la población.

Cuadro 29. Gestión de manejo de residuos sólidos hospitalarios, por distritos, provincia San Miguel, 2025

Distrito	N° EE. SS	Gestión del manejo de residuos sólidos hospitalarios (ficha 1 y 2)		Observaciones
		Cumple	No cumple	
Bolívar	2		2	No cuenta con infraestructura para disposición de residuos hospitalarios
Calquis	3		3	No cuenta con infraestructura para disposición de residuos hospitalarios
Catilluc	2	1	1	No cuenta con infraestructura para disposición de residuos hospitalarios
El Prado	5		5	No cuenta con infraestructura para disposición de residuos hospitalarios
La Florida	1	1		No cuenta con infraestructura para disposición de residuos hospitalarios
Llapa	7	1	6	No cuenta con infraestructura para disposición de residuos hospitalarios
Nanchoc	2	1	1	No cuenta con infraestructura para disposición de residuos hospitalarios
Niepos	4		4	No cuenta con infraestructura para disposición de residuos hospitalarios
San Gregorio	3		3	No cuenta con infraestructura para disposición de residuos hospitalarios
San Miguel	7	1	6	No cuenta con infraestructura para disposición de residuos hospitalarios
San Silvestre de Cochán	6		6	No cuenta con infraestructura para disposición de residuos hospitalarios
Tongod	4	1	3	No cuenta con infraestructura para disposición de residuos hospitalarios
Unión Agua Blanca	2		2	No cuenta con infraestructura para disposición de residuos hospitalarios
Total provincial	48	6	42	

Fuente: Salud Ambiental - Red de Salud San Miguel, 2025

Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2026

5.4.1.7. Sistemas de información

Los establecimientos de salud de la provincia de San Miguel operan principalmente con historia clínica en formato físico. De los 48 establecimientos que conforman la Red de Salud San Miguel, solo 7 (14,5 %) cuentan con módulos SIHCE-MINSA activos, como WawaRed e Inmunizaciones, los cuales son utilizados principalmente por profesionales médicos, obstetras y enfermeras.

El uso de estos módulos presenta diferencias entre los establecimientos. Se reporta un uso más continuo en establecimientos de categorías I-2 a I-4 ubicados en los distritos de San

Miguel, Calquis, Catilluc, La Florida, Nanchoc, San Gregorio y Tongod; mientras que, en Bolívar, El Prado, Llapa, Niepos, San Silvestre de Cochán y Unión Agua Blanca su utilización es eventual, situación relacionada con la rotación de profesionales, particularmente personal SERUMS.

Asimismo, el Centro de Salud San Miguel, categoría I-4, es el único establecimiento que cuenta con el sistema ONE VISION Clinic para el manejo de FUAS electrónicas. Sin embargo, el 97,9 % de las atenciones continúa registrándose mediante FUAS manuales, lo que limita la disponibilidad oportuna de información y puede afectar el reporte requerido para los procesos vinculados al SIS.

Respecto al equipamiento informático, se reporta que gran parte de los equipos tiene más de ocho años de antigüedad y requiere mantenimiento preventivo y/o correctivo. Asimismo, varios establecimientos disponen de una computadora de escritorio o laptop asignada exclusivamente a la UPSS Farmacia para el uso del SISMED, por lo que dichos equipos no están disponibles para otros procesos. El P.S. Quebrada Honda no cuenta con energía eléctrica, situación que condiciona el uso de equipamiento informático para el registro de información.

Equipamiento informático según categoría de establecimiento. Para el presente análisis se consideró la categoría de los 48 establecimientos registrada en el archivo RENIPRESS y la relación distrital de establecimientos empleada en el ASIS. La cantidad de equipos que se presenta a continuación corresponde al total por distrito, considerando todos sus establecimientos de salud, y no únicamente al punto de digitación distrital.

Cuadro 30. Equipos de cómputo, por distrito, provincia de San Miguel, 2025

Distrito	EESS	I-1	I-2	I-3	I-4	CPU (Regulares)	Monitores (Buenos)	Impresoras (Malas)	Total
San Miguel	7	6	0	0	1	18	18	10	46
Calquis	3	2	1	0	0	6	6	3	15
Tongod	4	3	0	1	0	11	11	6	28
Nanchoc	2	1	0	1	0	9	9	6	24
Bolívar	2	1	1	0	0	5	5	3	13
San Gregorio	3	2	1	0	0	6	6	3	15
El Prado	5	3	2	0	0	11	11	6	28
Unión Agua Blanca	2	1	1	0	0	5	5	3	13
La Florida	1	0	0	1	0	8	8	6	22
Niepos	4	3	1	0	0	7	7	3	17
Llapa	7	6	0	1	0	14	14	6	34
San Silvestre de Cochán	6	5	1	0	0	9	9	3	21
Catilluc	2	1	0	1	0	9	9	6	24
TOTAL	48	34	8	5	1	118	118	64	300

Fuente: Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística (OITE) – Red de Salud San Miguel, 2025

En cuanto al acceso a internet por distrito, El Prado, San Gregorio, Catilluc, Unión Agua Blanca y La Florida cuentan con el 100 % de sus establecimientos con acceso a internet; en tanto, Llapa es el distrito con menor cobertura, con solo el 28,6 % (2 de 7) de sus establecimientos conectados, seguido de San Miguel con 42,9 % (3 de 7).

En cuanto a conectividad, 31 de los 48 establecimientos (64,6 %) cuentan con acceso a internet, principalmente mediante los operadores Bitel y Movistar con señal 4G/LTE. Los establecimientos de Catilluc (I-3), Tongod (I-3), Nanchoc (I-3), La Florida (I-3), Llapa (I-3) y San Miguel (I-4) disponen de un servicio fijo de internet. En contraste, 17 establecimientos (35,4 %), principalmente del nivel I-1, no cuentan con acceso a internet por encontrarse en zonas de difícil acceso o sin cobertura de señal celular.

Cuadro 31. Establecimientos de salud con acceso a internet, por distrito, provincia de San Miguel, 2025

Distrito	N° EE.SS	Con internet	Sin internet	%
Llapa	7	2	5	28,6
San Miguel	7	3	4	42,9
San Silvestre de Cochán	6	4	2	66,7
El Prado	5	5	0	100,0
Niepos	4	3	1	75,0
Tongod	4	2	2	50,0
San Gregorio	3	3	0	100,0
Calquis	3	2	1	66,7
Bolívar	2	1	1	50,0
Nanchoc	2	1	1	50,0
Catilluc	2	2	0	100,0
Unión Agua Blanca	2	2	0	100,0
La Florida	1	1	0	100,0
Total	48	31	17	64,6

Fuente: Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística (OITE) – Red de Salud San Miguel, 2025

VI. ANÁLISIS DE SALUD ENFERMEDAD

6.1. Análisis de la morbilidad

6.1.1. Morbilidad total por provincia

6.1.1.1. Morbilidad general de la provincia según lista 12/110 año 2025

Durante el año 2025 se registraron 38 627 atenciones por morbilidad en la población de la provincia de San Miguel, siendo las mujeres quienes recibieron mayor atención con un 40,45 % (15 626) en comparación a los varones que concentraron un 59,55 % (23 001). Las tres primeras causas de atención por morbilidad son las infecciones de vías respiratorias agudas (28,1 %), obesidad (6,9 %) y caries dental (65,8%), mientras que las de menor atención fueron la dermatitis (1,5 %) y enfermedades de la pulpa (1,5 %).

También se evidencio que el 20,9 % de patologías se agruparon como “resto de enfermedades”, lo cual indica que hubo enfermedades que se registraron con menor frecuencia estadística, la cual es baja de manera individual en esa población y periodo.

Cuadro 32. Morbilidad general de la provincia de San Miguel, según lista 12/110, 2025

Grupo Enfermedad	N°	Femenino	Masculino	%
Infecciones de vías respiratorias agudas	38 627	23 001	15 626	28,1
Obesidad	9 448	6 400	3 048	6,9
Caries dental	9 282	5 497	3 785	6,8
Gastritis y duodenitis	8 662	5 681	2 981	6,3
Lumbago y otras dorsalgias	7 616	4 821	2 795	5,5
Infección de vías urinarias	5 833	4 716	1 117	4,2
Gingivitis	5 299	3 175	2 124	3,9
Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas	4 379	3 201	1 178	3,2
Contractura muscular	4 169	2 765	1 404	3,0
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno	3 817	2 563	1 254	2,8
Otras enfermedades dentales	2 629	1 512	1 117	1,9
Desnutrición	2 450	1 434	1 016	1,8
Enfermedades infecciosas intestinales	2 260	1 201	1 059	1,6
Dermatitis	2 050	1 314	736	1,5
Enfermedades de la pulpa	2 017	1 180	837	1,5
Resto de enfermedades	28 728	18 217	10 511	20,9
Total	137 266	86 678	50 588	100

Fuente: Sistema de Información HIS MINSA, filtrado a la provincia San Miguel

Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

De acuerdo al principio de Pareto, podemos observar que en la provincia de San Miguel un grupo reducido de categorías concentra la mayor parte de las consultas por morbilidad. El primer lugar lo ocupan las infecciones de vías respiratorias agudas (38 627 casos, 28,1 %), causadas por virus o bacterias y son altamente contagiosas y se transmiten fácilmente en el aire. En segundo lugar, está la obesidad (9 448 casos, 6,9 %), relacionada con el sedentarismo y los inadecuados estilos de vida de la población. Tercero se ubica la caries dental (9 282 casos, 6,8 %), y en cuarto lugar la gastritis y duodenitis (8 662 casos, 6,3 %), ambas asociadas a hábitos alimentarios y acceso limitado a servicios odontológicos y de salud digestiva.

También se ha observado que las infecciones de transmisión sexual (71 casos) y las neoplasias malignas de estómago (10 casos), colon y recto (8 casos), próstata (4 casos) y de bronquios y pulmón (2 casos), son las que menos consultas registran, situación que puede estar relacionada con la falta de atención y prevención en estas patologías por parte de la población; los establecimientos brindan el servicio, pero no todos llegan a atenderse, muchos por temor y otros por desconocimiento, llegando a identificar el problema en una etapa avanzada, lo que hace que el paciente acuda a establecimientos de segundo nivel para su atención y tratamiento.

Cuadro 33. Morbilidad en el curso de vida niño, provincia de San Miguel, según lista 12/110, 2025

Grupo Enfermedad	N°	Femenino	Masculino	%
Infecciones de vías respiratorias agudas	13 286	6 653	6 633	56,7
Caries dental	2 607	1 234	1 373	11,1
Enfermedades infecciosas intestinales	999	466	533	4,3
Desnutrición	771	351	420	3,3
Dermatitis	551	292	259	2,4
Enfermedades de la pulpa	537	263	274	2,3
Helmintiasis	464	226	238	2,0
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y sus secuelas	375	173	202	1,6
Obesidad	329	154	175	1,4
Micosis superficiales	304	172	132	1,3
Conjuntivitis	278	115	163	1,2
Enfermedades del apéndice y de los intestinos	271	148	123	1,2
Infección de vías urinarias	210	157	53	0,9
Anemias nutricionales	206	89	117	0,9
Gingivitis	180	86	94	0,8
Resto de enfermedades	2 064	1 015	1 049	8,8
Total	23 432	11 594	11 838	100

Fuente: Sistema de Información HIS MINSA, filtrado a la provincia San Miguel
Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

En este grupo se registraron 12 261 atenciones durante el año 2025, de las cuales el 54,8 % (6 722) correspondieron a mujeres y el 45,2 % (5 539) a varones. Las infecciones de vías respiratorias agudas ocupan el primer lugar del grupo de enfermedades con el 33,8 % (4 147 casos), seguidas de caries dental (15,3 %, 1 872 casos) y gingivitis (13,9 %, 1 706 casos), reflejando la necesidad de fortalecer la atención odontológica preventiva en este grupo etario.

Cuadro 34. Morbilidad en el curso de adolescente, provincia de San Miguel, según lista 12/110, 2025

Grupo Enfermedad	N°	Femenino	Masculino	%
Infecciones de vías respiratorias agudas	4 147	2 161	1 986	33,8
Caries dental	1 872	1 077	795	15,3
Gingivitis	1 706	823	883	13,9
Obesidad	649	358	291	5,3
Desnutrición	442	254	188	3,6
Gastritis y duodenitis	295	188	107	2,4
Enfermedades de la pulpa	206	114	92	1,7
Infección de vías urinarias	188	162	26	1,5
Lumbago y otras dorsalgias	175	78	97	1,4
Enfermedades infecciosas intestinales	174	92	82	1,4
Dermatitis	164	90	74	1,3
Otras enfermedades dentales	160	78	82	1,3
Contractura muscular	146	76	70	1,2
Traumatismos superficiales y heridas	146	52	94	1,2
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno	134	92	42	1,1
Resto de enfermedades	1 657	1 027	630	13,5
Total	12 261	6 722	5 539	100

Fuente: Sistema de Información HIS MINSA, filtrado a la provincia San Miguel
Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

En el curso de vida joven, para el año 2025, las infecciones respiratorias agudas fueron la morbilidad que más casos registró en ese periodo con un 25,9 % (3 612 casos), seguida de la obesidad (11,2 %, 1 554 casos) y la caries dental (10,6 %, 1 472 casos). Es importante resaltar que en las mujeres jóvenes se muestra una alta demanda de atención en salud sexual y reproductiva, relacionada con las complicaciones del embarazo (334 casos) e infecciones de vías genitourinarias en el embarazo (265 casos), sumando ambas un 4,3 % de la morbilidad en este grupo. La obesidad también afecta principalmente a las mujeres (1 110 casos) en comparación con los varones (444 casos).

Cuadro 35. Morbilidad en el curso de vida joven, provincia de San Miguel, según lista 12/110, 2025

Grupo Enfermedad	N°	Femenino	Masculino	%
Infecciones de vías respiratorias agudas	3 612	2 513	1 099	25,9
Obesidad	1 554	1 110	444	11,2
Caries dental	1 472	1 012	460	10,6
Gingivitis	1 037	712	325	7,4
Infección de vías urinarias	687	599	88	4,9
Lumbago y otras dorsalgias	550	325	225	3,9
Gastritis y duodenitis	541	370	171	3,9
Complicaciones relacionadas con el embarazo	334	334	0	2,4
Enfermedades de la pulpa	325	203	122	2,3
Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	265	265	0	1,9
Otras enfermedades dentales	257	173	84	1,8
Contractura muscular	245	167	78	1,8
Dermatitis	231	182	49	1,7
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno	231	172	59	1,7
Micosis superficiales	174	116	58	1,2
Resto de enfermedades	2 411	1 680	731	17,3
Total	13 926	9 933	3 993	100

Fuente: Sistema de Información HIS MINSA, filtrado a la provincia San Miguel
Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

Las tres causas de morbilidad en los adultos son las infecciones respiratorias agudas (23,7 %, 11 788 casos), el lumbago y otras dorsalgias (8,2 %, 4 090 casos) y la obesidad (8,0 %, 3 983 casos). Podemos observar que las enfermedades crónicas como la obesidad están en incremento en este grupo, lo cual está relacionado con el sedentarismo y los inadecuados estilos de vida que ha adoptado la población. Esto también se ve reflejado en el 3,9 % (1 924 casos) de personas que padecieron trastornos del metabolismo de las lipoproteínas (colesterol y triglicéridos). Otra causa de morbilidad en este grupo es la gastritis y duodenitis, que abarca el 6,8 % (3 382 casos), asociada a hábitos alimentarios inadecuados.

Cuadro 36. Morbilidad en el curso de vida adulto, provincia de San Miguel, según lista 12/110, 2025

Grupo Enfermedad	N°	Femenino	Masculino	%
Infecciones de vías respiratorias agudas	11 788	8 282	3 506	23,7
Lumbago y otras dorsalgias	4 090	2 778	1 312	8,2
Obesidad	3 983	3 004	979	8,0
Gastritis y duodenitis	3 382	2 361	1 021	6,8
Infección de vías urinarias	3 330	2 858	472	6,7
Caries dental	2 554	1 757	797	5,1
Contractura muscular	2 086	1 497	589	4,2
Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas	1 924	1 509	415	3,9
Gingivitis	1 772	1 260	512	3,6
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno	1 413	1 074	339	2,8
Micosis superficiales	771	573	198	1,5
Enfermedades de la pulpa	755	534	221	1,5
Otras enfermedades dentales	750	522	228	1,5
Mialgia	739	483	256	1,5
Dolor en articulación	681	516	165	1,4
Resto de enfermedades	9 726	6 872	2 854	19,6
Total	49 744	35 880.0	13 864.0	100

Fuente: Sistema de Información HIS MINSA, filtrado a la provincia San Miguel
Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

Al igual que en los cursos de vida niño, joven y adulto, las infecciones de vías respiratorias agudas son la primera causa de morbilidad en los adultos mayores (15,3 %, 5 794 casos), seguidas de la gastritis y duodenitis (11,6 %, 4 390 casos), la obesidad (7,7 %, 2 933 casos) y el lumbago y otras dorsalgias (7,3 %, 2 781 casos), evidenciando problemas gastrointestinales y osteomusculares importantes en las personas mayores de 60 años. Otra causa notable es la desnutrición, que ocupa el 2,7 % (1 017 casos). Las mujeres son el grupo más afectado con las diferentes comorbilidades, concentrando el 59,5 % de las atenciones (22 549 casos).

Cuadro 37. Morbilidad en el curso de vida adulto mayor, provincia de San Miguel, según lista 12/110, 2025

Grupo Enfermedad	N°	Femenino	Masculino	%
Infecciones de vías respiratorias agudas	5 794	3 392	2 402	15,3
Gastritis y duodenitis	4 390	2 734	1 656	11,6
Obesidad	2 933	1 774	1 159	7,7
Lumbago y otras dorsalgias	2 781	1 636	1 145	7,3
Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas	2 180	1 516	664	5,8
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno	1 878	1 140	738	5,0
Contractura muscular	1 658	999	659	4,4
Infección de vías urinarias	1 418	940	478	3,7
Otras enfermedades dentales	1 296	669	627	3,4
Dolor en articulación	1 157	769	388	3,1
Desnutrición	1 017	649	368	2,7
Hipertensión esencial	843	503	340	2,2
Otras enfermedades osteomusculares	785	440	345	2,1
Caries dental	777	417	360	2,0
Gingivitis	604	294	310	1,6
Resto de enfermedades	8 392	4 677	3 715	22,1
Total	37 903	22 549	15 354	100

Fuente: Sistema de Información HIS MINSA, filtrado a la provincia San Miguel
Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

6.1.1.3. Morbilidad general por distritos, por sexo, según lista 12/110 año 2025

Durante el año 2025, el distrito de San Miguel concentró el mayor número de atenciones por morbilidad de la provincia, con 21 947 atenciones (16,0 %), seguido de San Silvestre de Cochán con 15 130 (11,0 %) y Catilluc con 12 978 (9,5 %). En todos los distritos las mujeres registraron mayor número de atenciones que los varones, siendo el distrito de Bolívar el que presentó la menor cantidad de atenciones (3 189 casos, 2,3 % del total). La razón del porque las mujeres hacen uso de los servicios de salud, podría relacionarse a sus necesidades biológicas reproductivas y la mayor prevalencia de enfermedades crónicas que afecta a este género.

Cuadro 38. Morbilidad general por distritos de la provincia de San Miguel, por sexo, según lista 12/110, 2025

Distrito	N°	Femenino	Masculino	%
San Miguel	21947	13951	7996	16,0
San Silvestre de Cochán	15130	9763	5367	11,0
Catilluc	12978	7937	5041	9,5
El Prado	12697	8097	4600	9,2
Llapa	12349	8107	4242	9,0
Tongod	11694	7266	4428	8,5
Niepos	10964	7068	3896	8,0
Unión Agua Blanca	8898	5733	3165	6,5
La Florida	7939	4931	3008	5,8
Nanchoc	7819	4852	2967	5,7
Calquis	6943	4154	2789	5,1
San Gregorio	4719	2945	1774	3,4
Bolívar	3189	1874	1315	2,3
Total	137266	86678	50588	100

Fuente: Estadística e Informática – DIRESA Cajamarca, 2025

Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

6.1.2. Análisis de la morbilidad según enfermedades sujetas a vigilancia en salud pública

La provincia de San Miguel en el último año registró 1857 episodios de infecciones respiratorias agudas, lo cual representó la mayor cantidad de notificaciones obligatorias en los establecimientos de salud de San Miguel durante el 2025, con impacto en los distritos de San Miguel, Llapa, San Silvestre de Cochán, Unión Agua Blanca, Tongod y Catilluc. Las infecciones Respiratorias Agudas (IRA) registraron un comportamiento endémico con picos estacionales definidos durante las épocas de bajas temperaturas (junio a agosto). Los niños menores de 5 años y los adultos mayores concentraron más del 60% de los casos reportados.

Las neumonías se también se mantuvieron bajo vigilancia, reportándose 232 casos en el año 2025. Los casos se notificaron en niños mayores de 2 meses hasta adultos mayores, siendo más frecuentes en este último grupo etario.

La segunda enfermedad más notificada fueron las enfermedades diarreicas agudas (EDA), vigilancia realizada en todas las edades, observándose que los grupos más afectados son los niños mayores de 5 años hasta los adultos mayores. El comportamiento de las EDA acuosas y disintéricas mostró picos en las temporadas de inicio de lluvias, situación que puede estar relacionada por la contaminación de fuentes de agua. También se han reportado casos de

enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), la misma que están relacionadas a las brechas estructurales en saneamiento básico rural que persisten en varios distritos de la provincia, las afecciones gastrointestinales.

Otra enfermedad bajo vigilancia en la provincia es la exposición a Metales Pesados y Metaloides, en este caso por arsénico, metal que fue encontrado en agua de consumo humano, en las comunidades del distrito de San Miguel (La Comunidad, Tayapampa las Cuevas, Nueva Esperanza y Vista Alegre).

Asimismo, se realizó la vigilancia de enfermedades inmunoprevenibles como la Tos Ferina (Pertussis), Varicela, Sarampión, entre otras. Notificación que se ha realizado de forma oportuna, y que durante el año 2025 no se han reportado casos.

También se ha vigilado las enfermedades metaxénicas y zoonóticas, siendo la Leishmaniasis cutánea la de mayor reporte con 22 casos notificados, daño que viene siendo endémico en algunas de las comunidades de los distritos de Niepos, El Prado, Unión Agua Blanca, San Miguel, Bolívar y La Florida.

Otro evento de importancia es la vigilancia Materno-Perinatal, durante el año 2025 no se ha reportado casos de mortalidad materna, pero si seis casos de defunciones perinatales.

6.2. Análisis de la mortalidad

6.2.1. Mortalidad general

6.2.1.1. Mortalidad general de la provincia según lista 10/110 año 2025

El presente cuadro muestra la mortalidad general de la provincia de San Miguel en el año 2025, evidencia que las infecciones respiratorias agudas constituyen la principal causa específica registrada, con un 12 % del total de defunciones, afectando ligeramente más a mujeres que a hombres. Aunque en menor proporción, se identifican casos aislados de desnutrición, enfermedades digestivas, infecciosas intestinales y problemas dentales, que reflejan la persistencia de determinantes sociales de la salud vinculados a nutrición, saneamiento y acceso a servicios básicos. Sin embargo, la mayor carga de mortalidad (86,5 %) se concentra en el grupo denominado “resto de enfermedades”, donde se podrían incluir causas crónicas, accidentes y otras no especificadas; que por ser un porcentaje estadístico

mínimo que agrupa a diversas patologías limita realizar un análisis más preciso, por lo cual es necesario fortalecer la calidad del registro epidemiológico.

En cuanto a la distribución por sexo, se observa mayor mortalidad en hombres (54,5 %) frente a mujeres (45,5 %), patrón consistente con riesgos asociados a violencia, accidentes y enfermedades crónicas.

En conclusión, la mortalidad en la provincia de San Miguel durante 2025 refleja tanto la persistencia de problemas prevenibles como la predominancia de causas crónicas y no especificadas. Este panorama exige un abordaje integral bajo el Modelo de Cuidado Integral, con énfasis en prevención, vigilancia epidemiológica y estrategias diferenciadas por género, para orientar la planificación sanitaria de la Red de Salud San Miguel en los siguientes años.

Cuadro 39. Mortalidad general de la provincia de San Miguel, según lista 10/110, 2025

Grupo enfermedad	N°	Femenino	Masculino	%
Enfermedades isquémicas del corazón	26	10	16	12,7
Infecciones respiratorias agudas bajas	25	15	10	12,3
Enfermedades hipertensivas	23	12	11	11,3
Enfermedades cerebrovasculares	16	7	9	7,8
Septicemia, excepto neonatal	11	3	8	5,4
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar	9	4	5	4,4
Enfermedad pulmonar intersticial	7	3	4	3,4
Insuficiencia respiratoria	6	2	4	2,9
Diabetes mellitus	6	2	4	2,9
Insuficiencia renal, incluye, incluye la aguda, crónica y la no especificadas	6	1	5	2,9
Las demás causas externas	5	1	4	2,5
Neoplasia maligna de estómago	5	3	2	2,5
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	3	2	1	1,5
Accidentes de transporte terrestre	3	1	2	1,5
Neoplasia maligna de hígado y vías biliares	3	1	2	1,5
Resto de enfermedades	50	25	25	24,5
Total	204	92	112	100

Fuente: Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), filtrado a la provincia San Miguel
Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

6.2.1.2. Mortalidad general de la provincia por curso de vida y sexo según lista 10/110 año 2025

La mortalidad en el curso de vida niño en la provincia de San Miguel durante el año 2025 muestra que se registraron 7 defunciones en total, de las cuales el 14,3 % corresponde a anomalías congénitas y el 85,7 % se agrupa en la categoría de “resto de enfermedades”. Esto nos refleja que, si bien, en este grupo etario las causas específicas como infecciones respiratorias, desnutrición, anemias o enfermedades intestinales que son las más comunes no aparecen registradas en este periodo y puede deberse a una baja incidencia en este periodo.

En conclusión, la mortalidad infantil en San Miguel durante 2025 se concentra en causas poco específicas y en anomalías congénitas, lo que nos plantea dos retos principales: fortalecer la vigilancia epidemiológica y el registro de causas de muerte en la niñez, y reforzar la atención materno-infantil con énfasis en prevención, control prenatal y acceso a servicios especializados.

Cuadro 40. Mortalidad en el curso de vida niño, provincia de San Miguel, según lista 10/110, 2025

Grupo Enfermedad	N°	Femenino	Masculino	%
Otras ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1	0	1	14,3
Signos, síntomas y afecciones mal definidas	1	1	0	14,3
Infecciones específicas del periodo perinatal	1	1	0	14,3
Defectos de la coagulación en órganos hematopoyéticos y trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	1	0	1	14,3
Trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal	1	1	0	14,3
Epilepsia y estado de mal epiléptico	1	0	1	14,3
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1	1	0	14,3
Total	7	4	3	100

Fuente: Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), filtrado a la provincia San Miguel
Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

En el curso de vida adolescente en la provincia de San Miguel durante el año 2025 muestra que se registró una sola defunción en total, correspondiente a una enfermedad cardiopulmonar vinculada a la circulación pulmonar, que afectó a una adolescente mujer. No se reportaron muertes por causas externas, infecciones respiratorias, suicidios, neoplasias, accidentes ni deficiencias nutricionales, lo que sugiere una baja mortalidad en este grupo etario. En

conclusión, la mortalidad adolescente en San Miguel durante 2025 fue mínima en número, pero significativa en cuanto a la causa registrada, la misma que indica que debemos fortalecer la atención integral del adolescente, con énfasis en la detección temprana de enfermedades cardiopulmonares, la promoción de estilos de vida saludables y la consolidación de sistemas de vigilancia que permitan identificar oportunamente riesgos asociados a violencia, accidentes y salud mental, asegurando un abordaje preventivo y diferenciado en este grupo etario.

Cuadro 41. Mortalidad en el curso de vida adolescente, provincia de San Miguel, según lista 10/110, 2025

Grupo Enfermedad	N°	Femenino	Masculino	%
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar	1	1	0	100,0
Total	1	1	0	100

Fuente: Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), filtrado a la provincia San Miguel
Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

El presente cuadro corresponde al curso de vida joven en la provincia de San Miguel que durante el año 2025 muestra un total de 4 defunciones; dos de ellas (50 %) se registraron por las demás causas externas y las otras dos (50 %) por accidentes de transporte terrestre. No se registraron muertes por causas específicas como infecciones respiratorias o por complicaciones relacionadas con el embarazo, ni por enfermedades digestivas, lo que podría interpretarse como un indicador positivo en cuanto a la cobertura de programas preventivos en este grupo etario.

La distribución por sexo muestra mayor mortalidad en hombres (3 casos) frente a mujeres (1 caso), lo que se alinea con los patrones epidemiológicos nacionales donde los varones jóvenes suelen estar más expuestos a riesgos asociados a accidentes de tránsito y otras causas externas.

Cuadro 42. Mortalidad en el curso de vida joven, provincia de San Miguel, según lista 10/110, 2025

Grupo Enfermedad	N°	Femenino	Masculino	%
Las demás causas externas	2	0	2	50,0
Accidentes de transporte terrestre	2	1	1	50,0
Total	4	1	3	100

Fuente: Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), filtrado a la provincia San Miguel
Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

Para el año 2025 la mortalidad en el curso de vida adulto en la provincia de San Miguel registró un total de 16 defunciones. La principal causa fueron las enfermedades cerebrovasculares (18,8 %, 3 casos), seguidas de las demás causas externas (12,5 %, 2 casos); el resto de causas —entre ellas septicemia, infecciones respiratorias agudas bajas, neoplasia del cuello uterino, enfermedades hipertensivas, insuficiencia respiratoria, diabetes mellitus, enfermedades del sistema urinario, insuficiencia cardíaca, neoplasia de estómago, neoplasia de mama y encefalitis— se presentaron con 1 caso cada una (6,2 % cada una). Esta dispersión de causas específicas confirma que la mortalidad adulta en la provincia responde principalmente a enfermedades crónicas no transmisibles y a causas externas.

En conclusión, la mortalidad adulta en San Miguel durante 2025 nos plantea mejorar la vigilancia epidemiológica y reforzar la atención integral de enfermedades crónicas no transmisibles bajo el Modelo de Cuidado Integral. Este enfoque permitirá orientar la planificación sanitaria hacia la prevención, el control de factores de riesgo y la atención diferenciada por género, asegurando una respuesta más efectiva de la Red de Salud San Miguel en el año 2026.

Cuadro 43. Mortalidad en el curso de vida adulto, provincia de San Miguel, según lista 10/110, 2025

Grupo Enfermedad	N°	Femenino	Masculino	%
Enfermedades cerebrovasculares	3	0	3	18,8
Las demás causas externas	2	1	1	12,5
Septicemia, excepto neonatal	1	1	0	6,2
Infecciones respiratorias agudas bajas	1	1	0	6,2
Neoplasia maligna del cuello del útero	1	1	0	6,2
Enfermedades hipertensivas	1	1	0	6,2
Insuficiencia respiratoria	1	0	1	6,2
Diabetes mellitus	1	0	1	6,2
Enfermedades del sistema urinario	1	1	0	6,2
Insuficiencia cardíaca	1	0	1	6,2
Neoplasia maligna de estómago	1	1	0	6,2
Neoplasia maligna de la mama	1	1	0	6,2
Encefalitis, mielitis y encefalomielitis	1	0	1	6,2
Total	16	8	8	100

Fuente: Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), filtrado a la provincia San Miguel
Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

En el curso de vida adulto mayor en la provincia de San Miguel durante el año 2025 muestra un panorama que debe ser considerado con alta prioridad para el Análisis de Situación de Salud de la Red San Miguel. Se registraron 176 defunciones, de las cuales el 14,8 %

corresponde a enfermedades isquémicas del corazón, el 13,6 % a infecciones respiratorias agudas bajas y el 12,5 % a enfermedades hipertensivas; en conjunto, estas tres causas concentran el 41 % de la mortalidad en este grupo etario. El 14,2 % restante de los casos se agrupa en la categoría de resto de enfermedades, que incluye patologías de menor frecuencia individual.

La distribución por sexo evidencia mayor mortalidad en hombres (98 casos, 55,7 %) frente a mujeres (78 casos, 44,3 %), lo que refleja mayores riesgos en la población masculina y la necesidad de intervenciones diferenciadas. El peso de las infecciones respiratorias y las enfermedades cardiovasculares en este grupo etario confirma la vulnerabilidad de los adultos mayores frente a enfermedades transmisibles y crónicas no transmisibles, lo que exige reforzar la cobertura de vacunación, la detección temprana y el acceso oportuno a servicios de salud.

Cuadro 44. Mortalidad en el curso de vida adulto mayor, provincia de San Miguel, según lista 10/110, 2025

Grupo Enfermedad	N°	Femenino	Masculino	%
Enfermedades isquémicas del corazón	26	10	16	14,8
Infecciones respiratorias agudas bajas	24	14	10	13,6
Enfermedades hipertensivas	22	11	11	12,5
Enfermedades cerebrovasculares	13	7	6	7,4
Septicemia, excepto neonatal	10	2	8	5,7
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar	8	3	5	4,5
Enfermedad pulmonar intersticial	7	3	4	4,0
Insuficiencia renal, incluye, incluye la aguda, crónica y la no especificadas	6	1	5	3,4
Insuficiencia respiratoria	5	2	3	2,8
Diabetes mellitus	5	2	3	2,8
Neoplasia maligna de estómago	4	2	2	2,3
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado	3	2	1	1,7
Neoplasia maligna de hígado y vías biliares	3	1	2	1,7
Enfermedad de Parkinson	3	0	3	1,7
Neoplasia maligna del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos	2	1	1	1,1
Embolia, trombosis arteriales y otros trastornos arteriales o arteriolas	2	1	1	1,1
Neoplasia maligna de la próstata	2	0	2	1,1
Neoplasia maligna secundaria (metástasis)	2	1	1	1,1
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	2	2	0	1,1
Neoplasia maligna de la tráquea, los bronquios y el pulmón	2	1	1	1,1
Resto de enfermedades	25	12	13	14,2
Total	176	78	98	100

Fuente: Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), filtrado a la provincia San Miguel
Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

6.2.1.3. Mortalidad general por distritos por sexo según lista 10/110 año 2025

Durante el año 2025, las defunciones en la población de la provincia de San Miguel estuvieron relacionadas a enfermedades de las vías respiratorias (la principal por neumonías) y resto de enfermedades.

Como distritos, San Miguel registró el mayor número de defunciones con 44 casos (21,6 %), seguido de Llapa con 40 (19,6 %) y San Silvestre de Cochán con 28 (13,7 %). El distrito de Tongod presentó la menor cantidad de defunciones (4 casos, 2,0 % del total).

El distrito de Bolívar registro 6 defunciones por enfermedades hipertensivas, El Prado registró 4 muertes por enfermedades isquémicas del corazón al igual que La Florida. Llapa notificó 9 defunciones por enfermedades cerebrovasculares y 5 por septicemia no neonatal. Niepos registro 5 muertes por infecciones respiratorias agudas bajas. Mientras que San Gregorio registró 3 casos por insuficiencia respiratoria. San Miguel fue el distrito que mayor caso reportó, 6 defunciones por enfermedades isquémicas del corazón, 6 por enfermedad cardiopulmonar, 6 por enfermedad pulmonar intersticial y 5 por septicemia no neonatal. Al igual que Niepos, Unión Agua Blanca y San Silvestre de Cochán reportaron defunciones por infecciones respiratorias agudas bajas, 6 y 5 respectivamente. El resto de distritos registraron un caso de defunción por alguna patología.

Cuadro 45. Mortalidad general por distritos de la provincia de San Miguel, por sexo, según lista 10/110, 2025

Distrito	N°	Femenino	Masculino	%
San Miguel	44	20	24	21,6
Llapa	40	17	23	19,6
San Silvestre de Cochán	28	11	17	13,7
El Prado	15	7	8	7,4
La Florida	13	5	8	6,4
San Gregorio	13	6	7	6,4
Unión Agua Blanca	11	9	2	5,4
Niepos	11	4	7	5,4
Bolívar	10	9	1	4,9
Calquis	5	2	3	2,5
Catilluc	5	0	5	2,5
Nanchoc	5	1	4	2,5
Tongod	4	1	3	2,0
Total	204	92	112	100

Fuente: Estadística e Informática – DIRESA Cajamarca, 2025
Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 2025

6.2.2. Análisis de la mortalidad según enfermedades sujetas a vigilancia en salud pública

Durante muchos años la muerte materna viene siendo un problema de salud pública en nuestro país y región, cuya reducción ha sido priorizada a nivel nacional e internacional mediante el planteamiento de diversas estrategias que han permitido disminuir ligeramente los casos de mortalidad. La muerte materna viene hacer la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y localización del embarazo, debido a cualquier causa relacionada o agravada por el mismo embarazo o su manejo, pero no por causas accidentales o incidentales.

Copia pública: se retiró el relato clínico individual para proteger la privacidad. Los indicadores agregados se conservan. El original permanece en el archivo local.

En tanto, los casos de mortalidad infantil y neonatal son fluctuantes en los periodos del 2021 al 2025, siendo el 2021 (8 defunciones perinatales) donde se registró mayores defunciones con respecto a los otros años. En el año 2025 se registró tres defunciones fetales, uno en Bolívar y dos en Catilluc; mientras que las neonatales se registraron en Tongod, Llapa y Calquis. Las defunciones fetales estuvieron relacionadas asfixia, infecciones y prematuridad; en tanto las neonatales a hipoxia intrauterina y otras causas presentadas durante el proceso del intraparto.

Tabla 15. Mortalidad perinatal (fetal y neonatal), por distritos, provincia San Miguel, 2025

Distrito	Fetales	Neonatales
Bolívar	1	
Calquis		1
Catilluc	2	
Llapa		1
Tongod		1
Provincia	3	3

Fuente: Notiweb, data 2025

Elaborado por epidemiología – Red de Salud San Miguel, 205

La razón de mortalidad materna (RMM) en la provincia de San Miguel mostró el siguiente comportamiento en el periodo 2023-2025: 0 muertes maternas en 2023, 1 muerte materna en 2024 (equivalente a una RMM puntual elevada dado el reducido número de nacidos vivos de la provincia, por lo que esta cifra no debe extrapolarse como tasa estable) y nuevamente 0 muertes maternas en 2025. La ausencia de muertes maternas en el último año es un resultado favorable, coherente con el fortalecimiento del seguimiento de gestantes de alto riesgo y la referencia oportuna a establecimientos con capacidad resolutive (FONB/FONE) implementado por la Red; no obstante, con un único caso en tres años, cualquier estimación de razón o tendencia a nivel provincial tiene alta variabilidad estadística y debe interpretarse con cautela.

La mortalidad perinatal (que agrupa muertes fetales tardías y neonatales precoces) mostró una tendencia creciente en el número absoluto de casos: 1 caso en 2023, 3 casos en 2024 y 6 casos en 2025, sobre una base de nacidos vivos también creciente (660, 740 y 795, respectivamente). Este incremento en el número de casos debe verificarse contra el registro de hechos vitales (SINADEF) y el sistema de vigilancia de mortalidad materna y perinatal del MINSA, dado que un mejor registro y notificación (más que un deterioro real de la atención) puede explicar parte del incremento observado. En el curso de vida niño, el Cuadro 18 (numeral 6.2.1.2) identificó 3 defunciones asociadas a afecciones específicas del periodo perinatal (trastornos respiratorios, infecciones y otras afecciones originadas en el periodo perinatal) sobre un total de 7 defunciones en ese curso de vida durante 2025, lo que confirma al periodo perinatal como una de las principales ventanas de riesgo de mortalidad infantil en la provincia.

Cuadro 46. Mortalidad materna y perinatal, provincia de San Miguel, 2023-2025

Indicador	2023	2024	2025
N° de muertes maternas	0	1	0
N° de muertes perinatales	1	3	6
N° de nacidos vivos (base poblacional)	660	740	795

Fuente: Cuantificador de Desigualdades en Salud - DGE, MINSA / SINADEF, 2023-2025
Elaborado por epidemiología - Red de Salud San Miguel, 2026

El gradiente social de la mortalidad perinatal mostró una mayor concentración de casos en 2025 en los distritos de mayor pobreza y mayor tasa de analfabetismo, sin un patrón perfectamente monótono dado el bajo número de eventos. Se recomienda que la auditoría de muertes maternas y perinatales, ya normada por el MINSA, incorpore explícitamente el análisis

de determinantes sociales (distancia al establecimiento FONB/FONE más cercano, disponibilidad de transporte de emergencia y nivel educativo de la madre) como parte del análisis de causas evitables.

VII. VINCULACIÓN DEL ASIS CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

El presente ASIS se articula con los instrumentos de gestión vigentes en los tres niveles de gobierno: el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Cajamarca al 2033 (PDRC 2033), el Plan Estratégico Institucional 2023-2027 (PEI) del Gobierno Regional de Cajamarca, y las Prioridades Nacionales de Investigación e Intervención Sanitaria 2024-2030 del MINSA.

De acuerdo a la matriz de priorización de problemas se han priorizado once problemas de salud en la provincia de San Miguel, como la desnutrición y anemia en niños, las complicaciones y morbilidad materna perinatal, el embarazo en adolescentes, la prevalencia de tuberculosis, ITS/VIH-SIDA, enfermedades metaxénicas como la Leishmaniasis, las neoplasias malignas, las enfermedades cardiovasculares y metabólicas como la hipertensión y diabetes mellitus, las enfermedades mentales (ansiedad y depresión) y el saneamiento básico (aguas y desagüe).

Cuadro 46. Vinculación de los problemas de salud priorizados con los instrumentos de gestión regional y nacional

Objetivo estratégico	Problema priorizado	Indicador	Determinante social / de servicios / biológico (para vinculación)				Fuente
AER 03.04 Reducir la prevalencia de anemia y desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años	Malnutrición y anemia por déficit en el binomio-madre niño durante el embarazo y hasta los 36 meses	Proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica infantil (DCI)	Pobreza	Desempleo	Acceso a agua potable	Acceso a desagüe	ENDES, INEI
		Proporción de niños de 6 a 35 meses de edad con anemia	Pobreza	Desempleo	Acceso a agua potable	Acceso a desagüe	ENDES, INEI
AER 03.03 Reducir la mortalidad materna e infantil en el departamento de Cajamarca	Complicaciones, morbilidad y mortalidad materna, fetal y neonatal	Razón de mortalidad materna	Pobreza	Educación	Dependencia económica		ENDES, INEI
		Tasa de Mortalidad Neonatal	Pobreza	Educación	Densidad del estado		SINADEF
AEI. 03.04 Atención integral a los niños, niñas y adolescentes en estado de riesgo y desprotección familiar	Inadecuada salud sexual y reproductiva con énfasis en el embarazo durante la adolescencia	% de embarazo en adolescente	Educación	Densidad del estado	Dependencia económica		HIS MINSA
AER 03.05 Mejorar los servicios de detección y control oportuno de las enfermedades transmisibles, causantes de la morbilidad	Incremento de casos de tuberculosis	% de Prevalencia de TBC	Pobreza	Hacinamiento	Desempleo	Hogares que cocinan con leña	INEI, SIGTB, SIEPITB
AEI.01.07 Atención de enfermedades transmisibles de manera oportuna por curso de vida a la población del departamento de Cajamarca	Enfermedad de transmisión sexual y VIH/SIDA	Prevalencia de VIH	Pobreza	Nivel educativo	Migración		ES-ITS/VIH
	Enfermedades metaxénicas y zoonóticas con énfasis leishmaniasis	Incidencia de Leishmaniasis	Densidad del Estado	Migración	Educación		NOTIWEB, SALUD AMBIENTAL, HIS MINSA
AER 03.06 Mejorar servicios de detección y control oportuno y disminución de las enfermedades no transmisibles causantes de la morbilidad	Neoplasias malignas	Prevalencia de cáncer	Nivel educativo	Pobreza	Ocupación		ES-CANCER, HIS MINSA, LAB.

AEI.01.03 Atención de enfermedades no transmisibles de manera oportuna por curso de vida a la población de Cajamarca	Enfermedades cardiovasculares y metabólicas, con énfasis en hipertensión arterial, diabetes mellitus.	Incidencia de diabetes mellitus	Bajo nivel educativo	Ingresos	Pobreza		ES-DNT, HIS MINSA
		Incidencia de hipertensión arterial	Bajo nivel educativo	Ingresos	Pobreza		ES-DNT, HIS MINSA
AER 12.02 Fortalecer intervenciones de lucha frente a la violencia contra la mujer y el grupo familiar	Enfermedades mentales del sistema nervioso con énfasis en: degeneración cerebral, depresión unipolar, estrés postraumático por desastres y violencia, alcoholismo y drogadicción y en el centro laboral.	% de personas tamizadas en problemas de salud mental, ansiedad, depresión y abuso de alcohol	Educación	Dependencia económica			ES-SALUD MENTAL, NOTIWEB-VIF
AEI.01.04 Atención de salud mental integral a la población por curso de vida	Escasa sensibilidad de la población por los problemas de salud mental	% de personas atendidas con problema asociados a violencia familiar	Educación	Dependencia económica			ES-SALUD MENTAL, NOTIWEB-VIF
OEI.04 Promover el acceso a los servicios básicos de agua y calidad, saneamiento y vivienda a la población del departamento de Cajamarca	Deficiente acceso al agua segura y saneamiento básico	% de población rural con abastecimiento de servicios de agua potable por red pública	Pobreza	Desempleo	Acceso a agua potable	Acceso a desagüe	Salud ambiental
		% de población urbana con abastecimiento de servicios de agua potable por red pública	Pobreza	Desempleo	Acceso a agua potable	Acceso a desagüe	Salud ambiental
AEI. 04.06 Vigilancia de calidad de agua para consumo humano de la población del departamento de Cajamarca		% de centros poblados vigilados con sistema de agua para consumo humano	Pobreza	Desempleo	Acceso a agua potable	Acceso a desagüe	Salud ambiental

Fuente: Matriz de vinculación de instrumentos de gestión, Red de Salud San Miguel, 2025
 Elaborado por epidemiología - Red de Salud San Miguel, 2025

VIII. ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES SOCIALES Y DESIGUALDADES

El análisis de los determinantes sociales de la salud de la provincia de San Miguel combina dos fuentes: los gráficos de gradiente social (barras por Grupo social 1 a 4), que muestran cómo se comporta cada indicador de salud según su exposición a un determinante estructural, de servicios o biológico; y los mapas distritales, que muestran la distribución territorial conjunta del indicador (puntos graduados en 3 categorías) y su determinante (coroplético en 3 categorías, por cuantiles).

El indicador de razón de mortalidad materna no registró casos en la provincia durante 2025, por lo que no se presentan como gráfico ni mapa de gradiente.

1.1. Desnutrición Crónica Infantil (DCI)

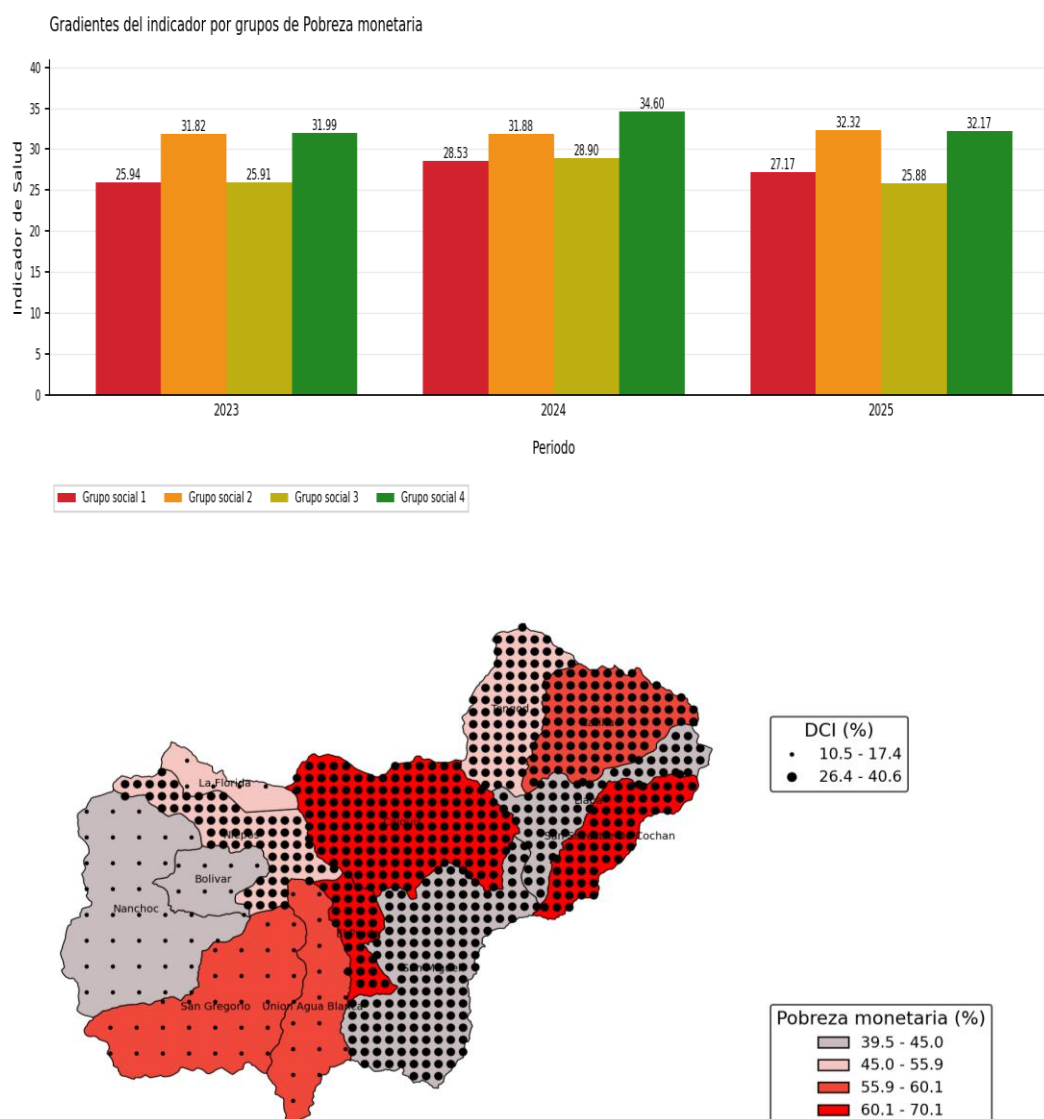
Este indicador corresponde al objetivo "Reducir la prevalencia de anemia y desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años", asociado al problema priorizado "Malnutrición y anemia por déficit en el binomio madre-niño durante el embarazo y hasta los 36 meses", con pobreza, desempleo y acceso a agua y desagüe como determinantes de referencia, teniendo como fuente ENDES-INEI.

La desnutrición crónica infantil (DCI) en menores de 5 años se relaciona de forma distinta con los cuatro determinantes evaluados, según el año y el grupo social considerado; a continuación, se describe su comportamiento frente a la pobreza monetaria, el determinante que muestra la asociación más consistente en la provincia.

Entre los grupos sociales 1 a 4, la DCI se ubicó en 27,17 %, 32,32 %, 25,88 % y 32,17 % durante 2025, con una diferencia de 5,00 puntos porcentuales entre los grupos extremos. El comportamiento se repite con magnitudes similares en 2023 y 2024 (brechas de 6,05 y 6,07 puntos, respectivamente), sin que ningún par de grupos llegue a duplicarse entre sí; la asociación con la pobreza monetaria es, por tanto, moderada y sostenida en el tiempo, más que una brecha extrema. Esta relación es consistente con lo esperado, los hogares en situación de pobreza tienen menor capacidad para acceder a una alimentación diversa y de calidad nutricional adecuada, además de mayores dificultades para acceder oportunamente a controles de crecimiento y desarrollo (CRED) y a agua segura, factores que en conjunto favorecen la desnutrición crónica infantil. Territorialmente, los distritos de mayor pobreza monetaria, entre ellos Tongod y Catilluc, coinciden con los de mayor incidencia de DCI, lo que respalda priorizar intervenciones integrales sobre este determinante como estrategia para mejorar la salud infantil en la provincia.

La pobreza monetaria distrital puede influir en la capacidad de compra en alimentos ricos en hierro hemínico (carnes rojas, sangrecita) y de alto valor nutricional, así mismo el deficiente saneamiento básico favorece las infecciones parasitarias y gastrointestinales recurrentes que impiden la absorción de nutrientes. Situación que debe ser vista desde diferentes aristas institucionales, para generar programas de seguridad alimentaria focalizados en distritos con mayor pobreza, incidencia y prevalencia de DCI; así como fortalecer las visitas domiciliarias por parte de los actores sociales comunitarios para el seguimiento del cumplimiento de suplementación y controles CRED de los niños de su ámbito.

Gráfico 4. Desnutrición Crónica Infantil (DCI) vs pobreza monetaria a nivel distrital, año 2025



Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN), procesado mediante el Cuantificador de Desigualdades en Salud (DGE), ámbito filtrado a la provincia San Miguel
Elaborado: Equipo ASIS - Red de Salud San Miguel

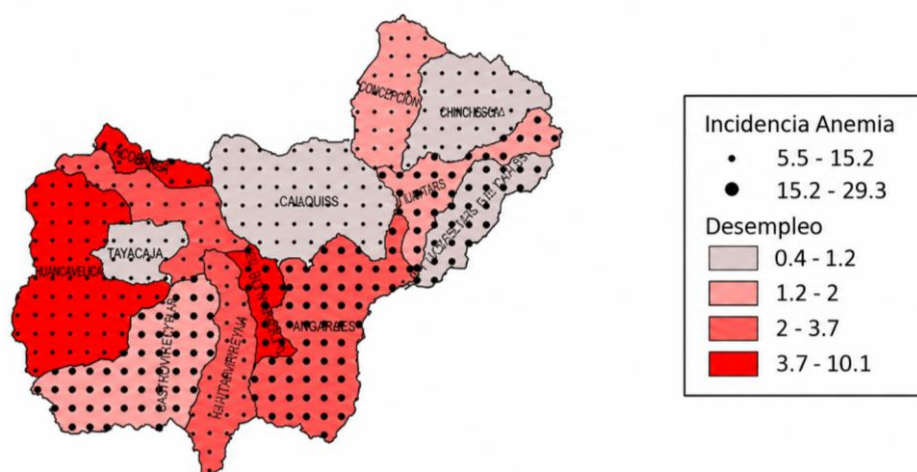
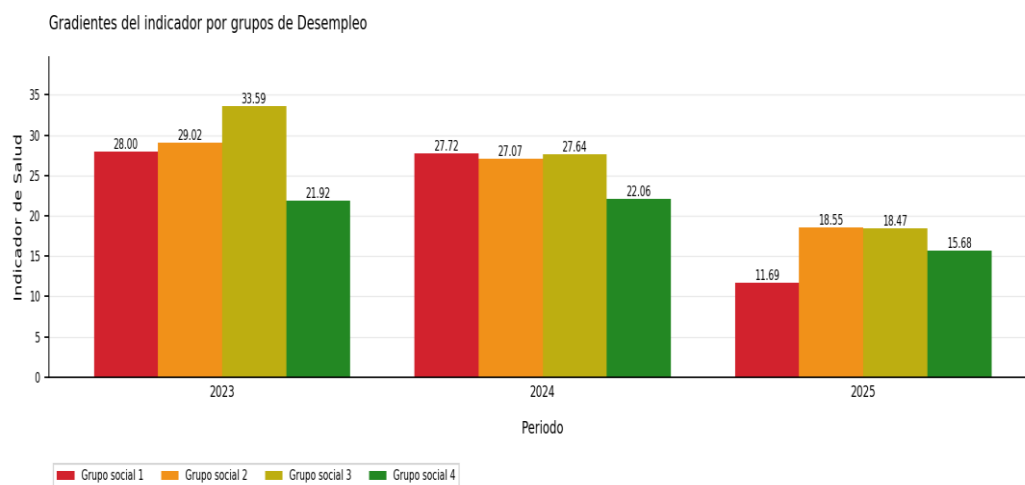
1.2. Anemia en menores de 5 años

La anemia infantil se analizó frente a los mismos cuatro determinantes que la DCI, dada su estrecha relación biológica y social con la nutrición infantil. La anemia infantil en la provincia se relaciona principalmente con el desempleo, determinante que se analiza a continuación.

En la provincia de San Miguel se evidencia una relación territorial directa entre el mayor desempleo y la mayor frecuencia de anemia en menores de 5 años: en 2025 los grupos sociales 1 a 4 registraron 11,69 %, 18,55 %, 18,47 % y 15,68 % respectivamente, con una brecha absoluta de 3,99 puntos porcentuales entre los grupos extremos. El desempleo limita el ingreso familiar disponible para adquirir alimentos ricos en hierro de origen animal, de mayor costo relativo, y puede reducir la adherencia a la suplementación con multimicronutrientes cuando las familias priorizan otras necesidades urgentes. Estos hallazgos respaldan priorizar intervenciones sobre el acceso al empleo y la seguridad alimentaria, como estrategia para reducir la anemia infantil en la provincia.

En 2025, los grupos sociales 1 a 4 registraron 11,69 %, 18,55 %, 18,47 % y 15,68 %, respectivamente. La diferencia entre los grupos extremos (3,99 puntos) resulta menor que la que separa al grupo con el valor más bajo del más alto (6,86 puntos, entre 11,69 % y 18,55 %), por lo que la lectura del gradiente conviene apoyarla en el comportamiento territorial y no solo en la comparación de extremos. El mapa muestra una distribución heterogénea: San Gregorio, San Miguel, Llapa, Calquis, Bolívar, San Silvestre de Cochán y La Florida concentran las prevalencias más altas (23,9 % a 29,3 %), mientras que Nanchoc, Niepos, Unión Agua Blanca, Catilluc y Tongod registran las más bajas (9,5 % a 11,7 %). La coincidencia espacial entre mayor anemia y menor acceso a agua potable sugiere que el saneamiento básico podría actuar como determinante intermedio, asociación que es territorial y no permite establecer causalidad; conviene complementarla con el análisis de otros determinantes sociales, ambientales, nutricionales y de acceso a los servicios de salud.

Gráfico 5. Anemia en menores de 5 años vs desempleo a nivel distrital, año 2025



Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN), procesado mediante el Cuantificador de Desigualdades en Salud (DGE), ámbito filtrado a la provincia San Miguel.

Elaborado: Equipo ASIS - Red de Salud San Miguel

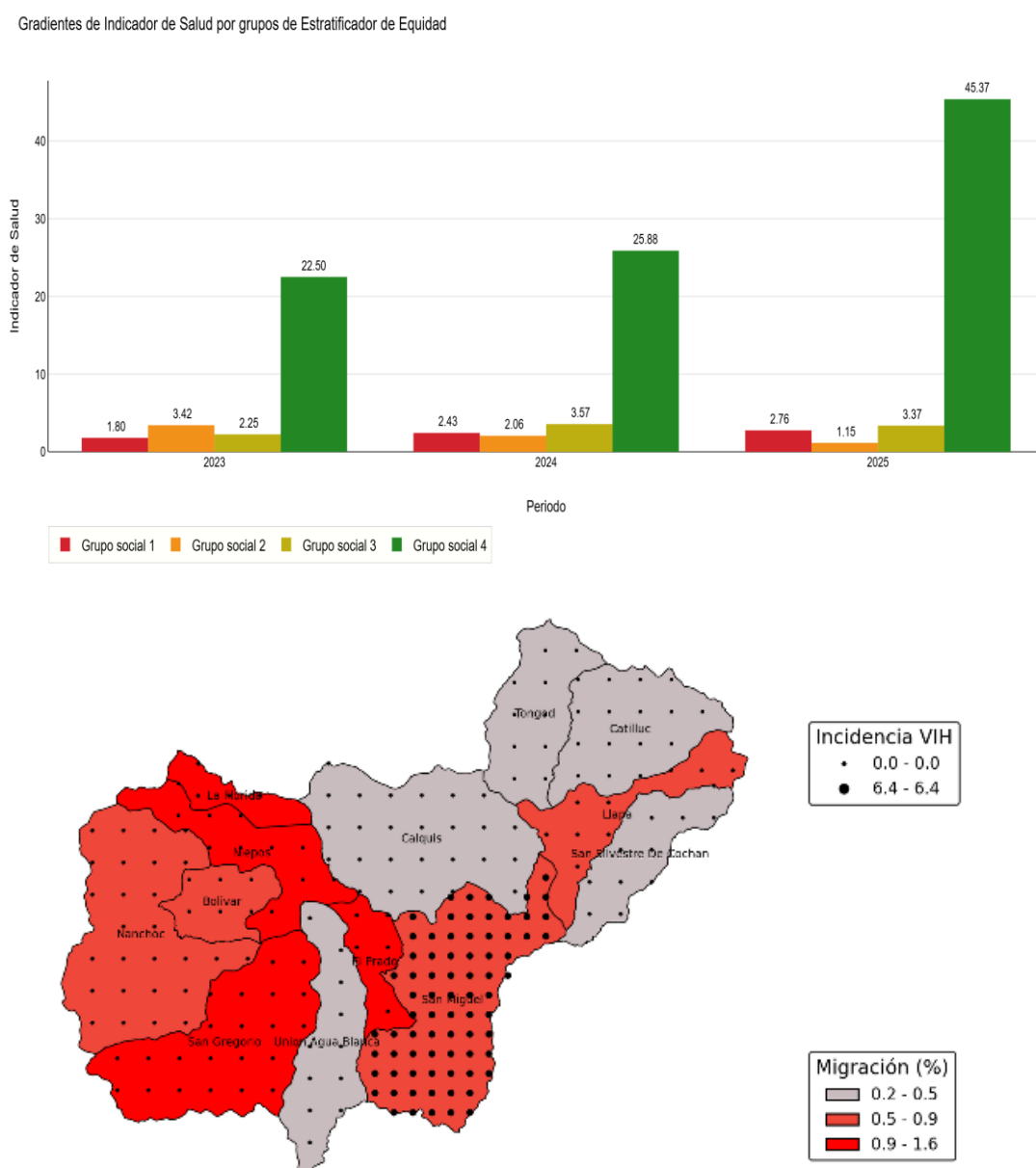
1.3. Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)

A diferencia de la DCI y la anemia, el VIH no muestra un gradiente ligado a la pobreza monetaria; la asociación más clara aparece con la migración. Los distritos con mayor movilidad poblacional hacia Lambayeque, La Libertad y Cajamarca concentran sistemáticamente las tasas más altas de VIH en los tres años analizados. La coincidencia espacial observada en el mapa requeriría un análisis estadístico específico para confirmar si existe una asociación significativa entre migración y casos de VIH.

La mayor incidencia en distritos con más migración es consistente con patrones descritos en la literatura, la movilidad poblacional hacia zonas urbanas de mayor tránsito, como Lambayeque y La

Libertad, expone a la población a redes sociales y sexuales más amplias, mientras que la discontinuidad de la atención en salud al desplazarse dificulta el diagnóstico y seguimiento oportunos. Como política pública, los distritos con mayor concentración de migración podrían considerarse zonas prioritarias para prevención y educación sexual, diagnóstico temprano, acceso al tratamiento antirretroviral, así como la reducción de barreras económicas y geográficas para acceder a los servicios de salud.

Gráfico 6. VIH vs migración, año 2023-2025



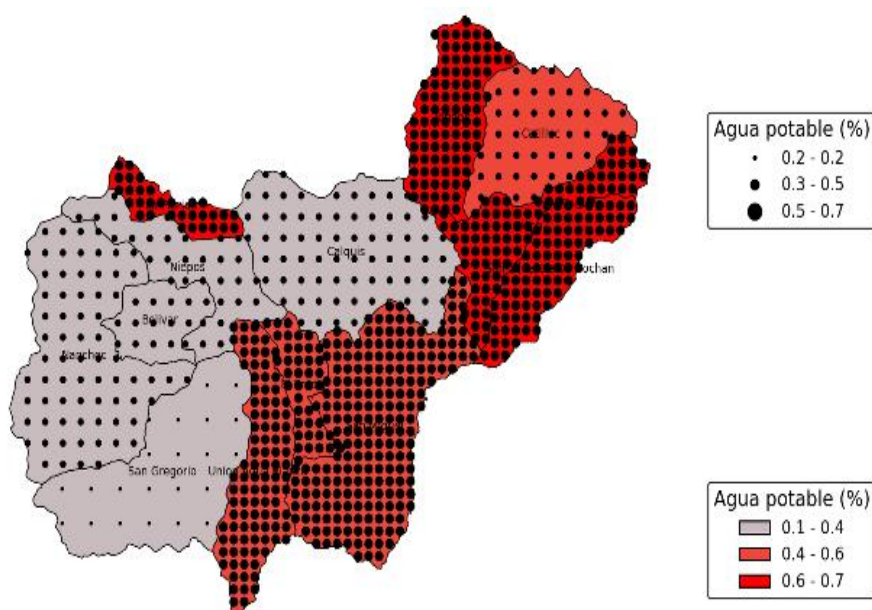
Fuente: NOTIWEB, procesado mediante el Cuantificador de Desigualdades en Salud (DGE), ámbito filtrado a la provincia San Miguel

Elaborado: Equipo ASIS - Red de Salud San Miguel

1.4. Acceso a agua potable (determinante de servicios)

Se analizó también la desigualdad en el propio acceso a agua potable frente a otros determinantes, como línea base de los determinantes intermedios de la provincia. La cobertura de agua potable muestra una brecha territorial marcada y estable en los últimos tres años, los distritos del norte concentran sistemáticamente la menor cobertura, con una diferencia de hasta 33 puntos porcentuales frente a los de mejor cobertura.

Mapa 5. Cobertura de agua potable vs su propio gradiente social a nivel distrital, año 2025



Fuente: Cuantificador de Desigualdades en Salud (DGE), calculadoradesigualdadesregional2023_2025, ámbito filtrado a la provincia San Miguel
Elaborado: Equipo ASIS - Red de Salud San Miguel

1.5. Tuberculosis (TBC)

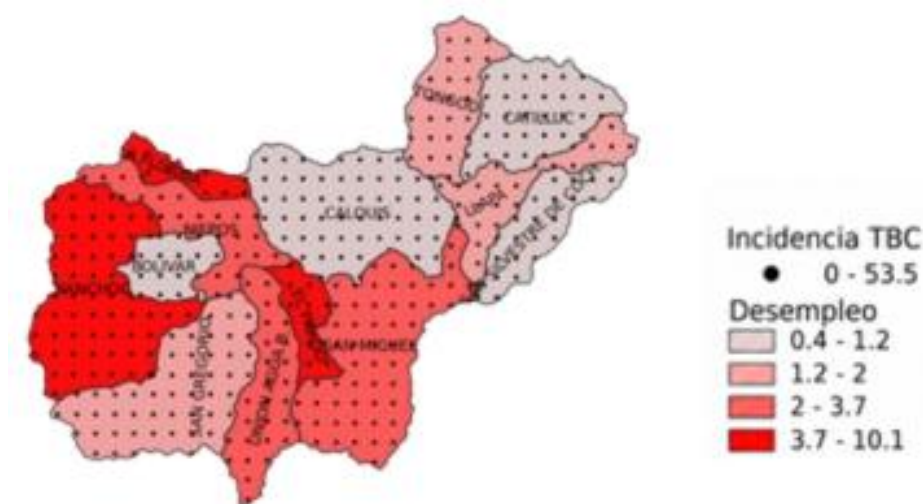
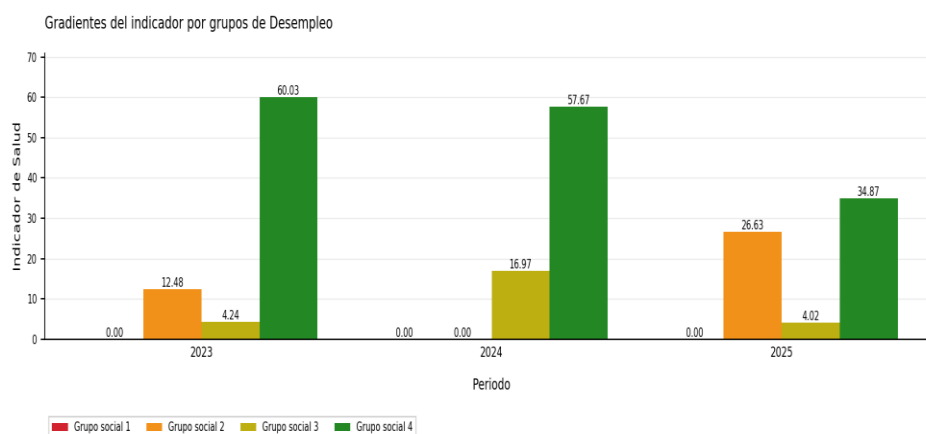
La provincia de San Miguel registró cuatro casos de tuberculosis en el año 2025, número reducido que limita la robustez estadística del análisis territorial, pero permite una primera aproximación a los determinantes de mayor peso.

En la provincia de San Miguel se evidencia una relación territorial entre el mayor desempleo y la mayor incidencia de tuberculosis, en el 2025 los grupos sociales 1 a 4 registraron 0,00; 26,63; 4,02 y 34,87 (tasa x100,000 hab.) respectivamente, con una brecha absoluta de 34,87 puntos entre los grupos extremos. El desempleo suele asociarse a hacinamiento por la necesidad de compartir vivienda para reducir gastos, a una alimentación menos completa que debilita la respuesta inmunológica, y a mayor informalidad laboral en espacios cerrados y poco ventilados, todas condiciones que favorecen la transmisión del bacilo. Con solo cuatro casos en toda la provincia,

este hallazgo debe leerse como una señal de alerta que respalda fortalecer la vigilancia y el tamizaje en los distritos de mayor vulnerabilidad económica, más que como una estimación precisa de riesgo.

Frente al desempleo, la incidencia se concentra en distritos con mayor desempleo relativo, mientras los de menor desempleo no registran casos en el año.

Gráfico 7. Tuberculosis (TBC) vs desempleo a nivel distrital, año 2023-2025



Fuente: Sistema de Información Gerencial de Tuberculosis (SIGTB), procesado mediante el Cuantificador de Desigualdades en Salud (DGE), ámbito filtrado a la provincia San Miguel
Elaborado: Equipo ASIS - Red de Salud San Miguel

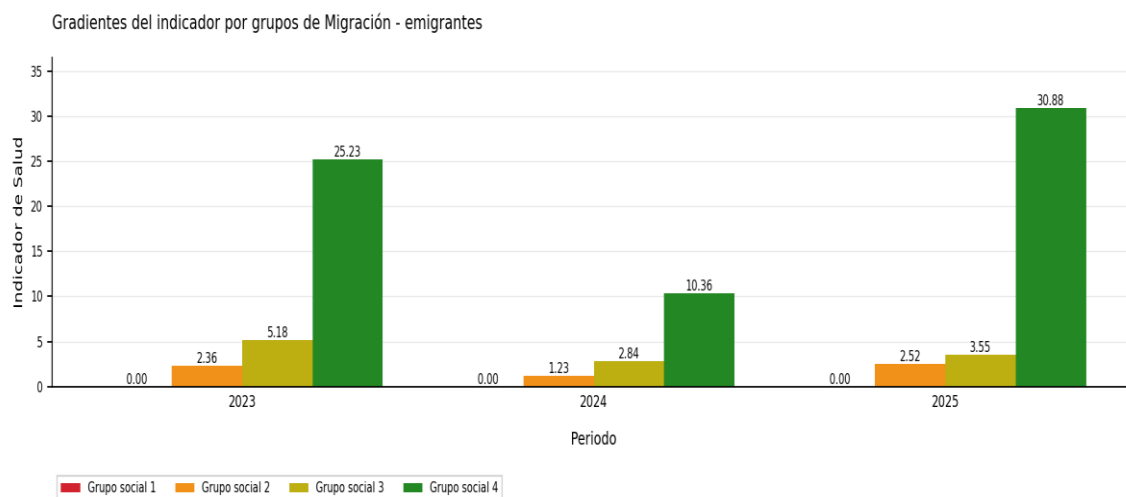
1.6. Enfermedades metaxénicas (Dengue y Leishmaniasis Cutánea)

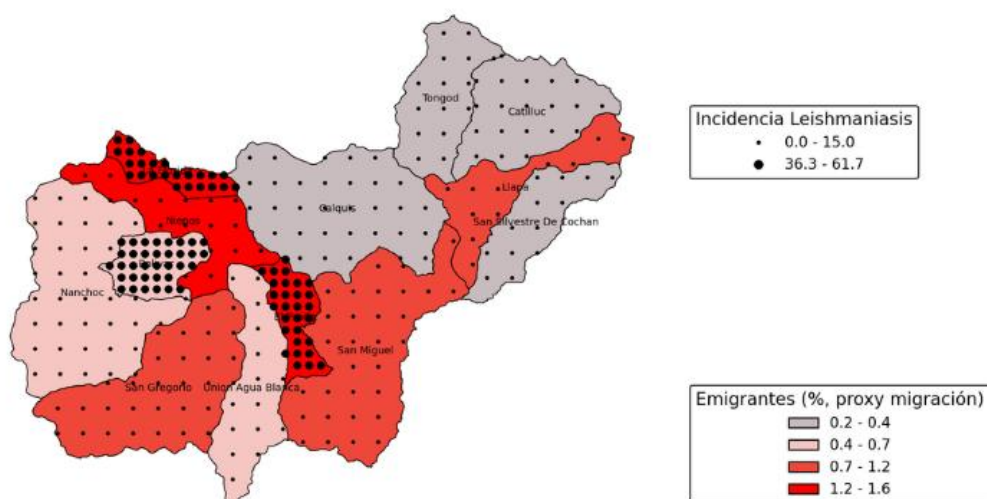
El dengue no registró casos autóctonos en la provincia durante 2025 (frente a 34 y 31 casos en 2023 y 2024, respectivamente), por lo que no se presenta un mapa ni gráfico de gradiente para este año; se recomienda mantener la vigilancia entomológica activa dado el antecedente reciente de transmisión.

En la provincia de San Miguel se evidencia una relación territorial entre la mayor proporción de emigrantes y la mayor incidencia de leishmaniasis cutánea: en 2025 los grupos sociales 1 a 4 registraron 0,00, 2,52, 3,55 y 30,88 (tasa x10,000 hab.) respectivamente, con una brecha absoluta de 30,88 puntos entre los grupos extremos. Estos hallazgos respaldan priorizar la vigilancia entomológica y la educación sanitaria en los distritos con mayor migración hacia zonas de exposición ocupacional agrícola.

La Leishmaniasis cutánea, con 22 casos en 2025, sí permite el análisis territorial. La incidencia se concentra en los distritos con mayor migración hacia fuera de la provincia, como Contumazá y Chepén, coherente con mayor exposición ocupacional agrícola (cosecha arroz) en dichas zonas.

Gráfico 8. Leishmaniasis cutánea vs migración a nivel distrital, año 2023 - 2025





Fuente: NOTIWEB, procesado mediante el Cuantificador de Desigualdades en Salud (DGE), ámbito filtrado a la provincia San Miguel

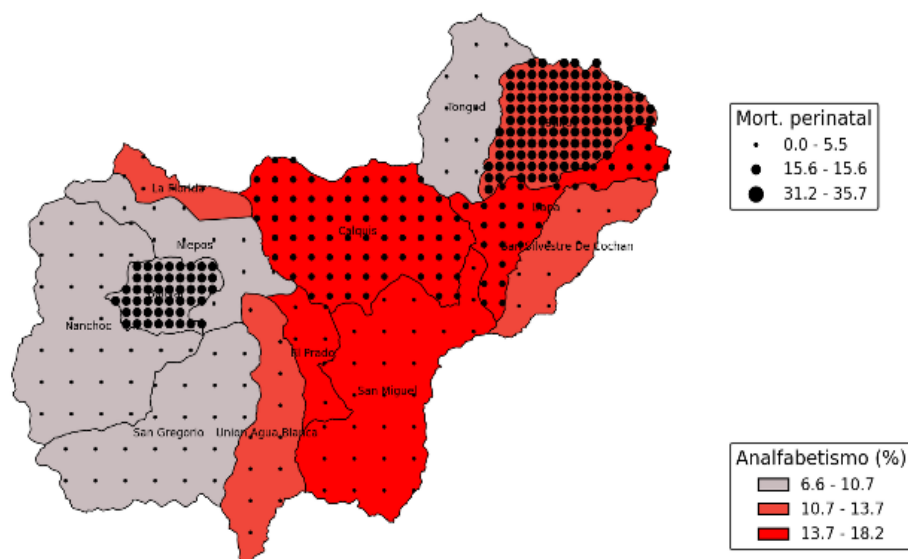
Elaborado: Equipo ASIS - Red de Salud San Miguel

1.7. Salud materno-infantil (mortalidad materna y perinatal)

La provincia no registró muertes maternas en el 2025, resultado favorable que no se presenta como gráfico de gradiente por no aportar información territorial; en el periodo del 2023 a 2025 se registró un único caso en el año 2024, lo que ilustra la fragilidad estadística de este indicador a nivel distrital.

La mortalidad perinatal en la provincia registró seis casos en 2025. Se evaluaron la pobreza monetaria, el nivel educativo y la densidad del Estado como determinantes; ninguno de los tres mostró en 2025 un patrón social consistente (brechas de 1,85; 0,39 y 7,13 puntos respectivamente, todas con oscilaciones entre grupos), por lo que no se identifica un determinante predominante con la información disponible.

Mapa 6. Mortalidad perinatal a nivel distrital, provincia de San Miguel, año 2025



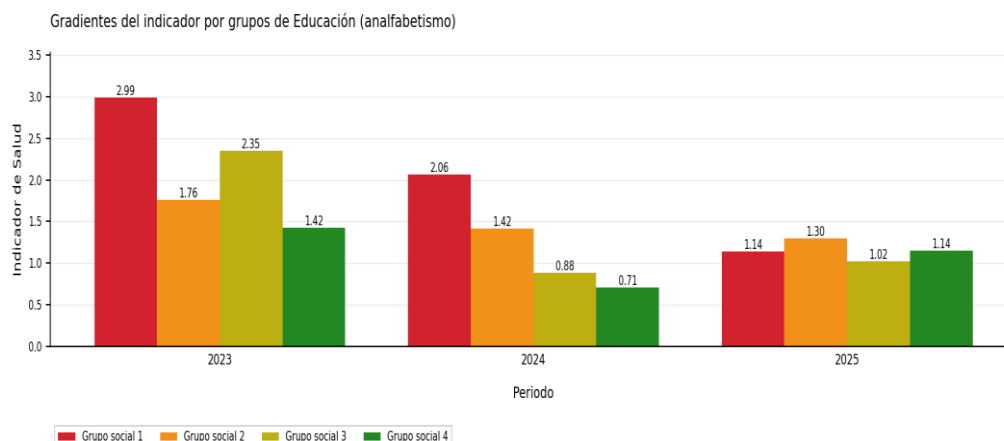
Fuente: NOTIWEB, procesado mediante el Cuantificador de Desigualdades en Salud (DGE), ámbito filtrado a la provincia San Miguel

Elaborado: Equipo ASIS - Red de Salud San Miguel

1.8. Embarazo adolescente

En la provincia de San Miguel se evidencia una relación territorial débil entre el mayor analfabetismo y el embarazo adolescente: en 2025 los grupos sociales 1 a 4 registraron 1,14 %, 1,30 %, 1,02 % y 1,14 % respectivamente, con una brecha absoluta de apenas 0,01 puntos porcentuales entre los grupos extremos. La escasa magnitud de esta brecha sugiere que el analfabetismo por sí solo no explica el embarazo adolescente en la provincia; factores como el inicio temprano de la vida en pareja como proyecto de vida frente a pocas oportunidades educativas o laborales, patrones culturales de las zonas rurales andinas, y el acceso limitado a educación sexual integral y métodos anticonceptivos en adolescentes, no capturados en esta matriz, probablemente tienen mayor peso explicativo. Por ello, las intervenciones deben ampliarse más allá del nivel educativo.

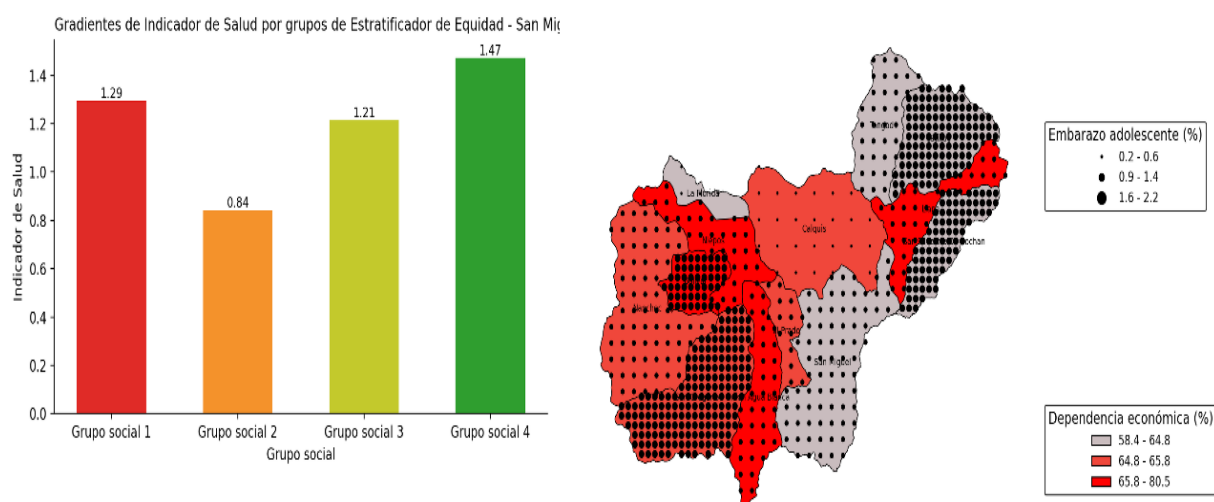
Gráfico 9. Embarazo adolescente vs analfabetismo a nivel distrital, año 2023-2025



Fuente: Sistema de Información HIS MINSA, procesado mediante el Cuantificador de Desigualdades en Salud (DGE), ámbito filtrado a la provincia San Miguel
Elaborado: Equipo ASIS - Red de Salud San Miguel

Referente a la dependencia económica, el patrón territorial sí es consistente con lo esperado, los distritos de mayor dependencia económica concentran la mayor proporción de embarazo adolescente.

Gráfico 10. Embarazo adolescente vs dependencia económica a nivel distrital, año 2025



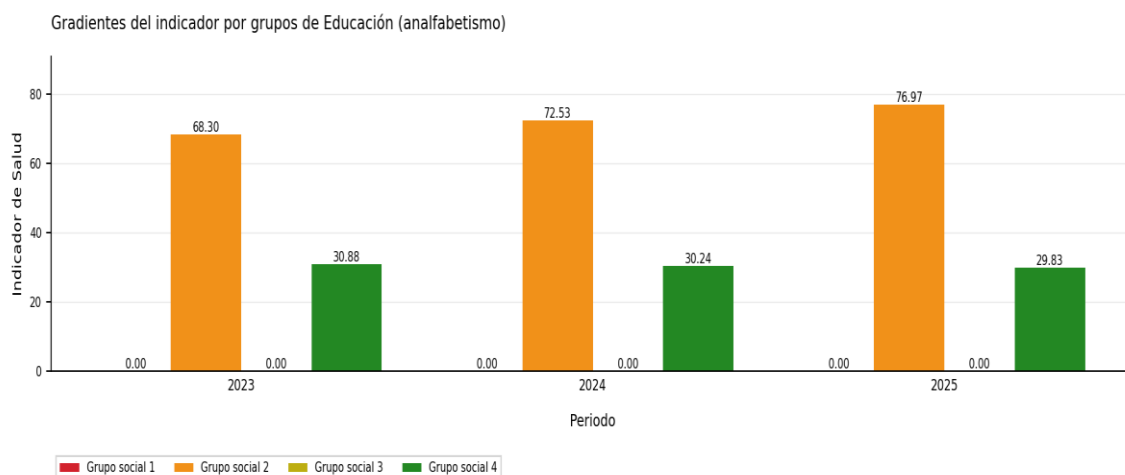
Fuente: Sistema de Información HIS MINSA
Elaborado: Equipo ASIS - Red de Salud San Miguel

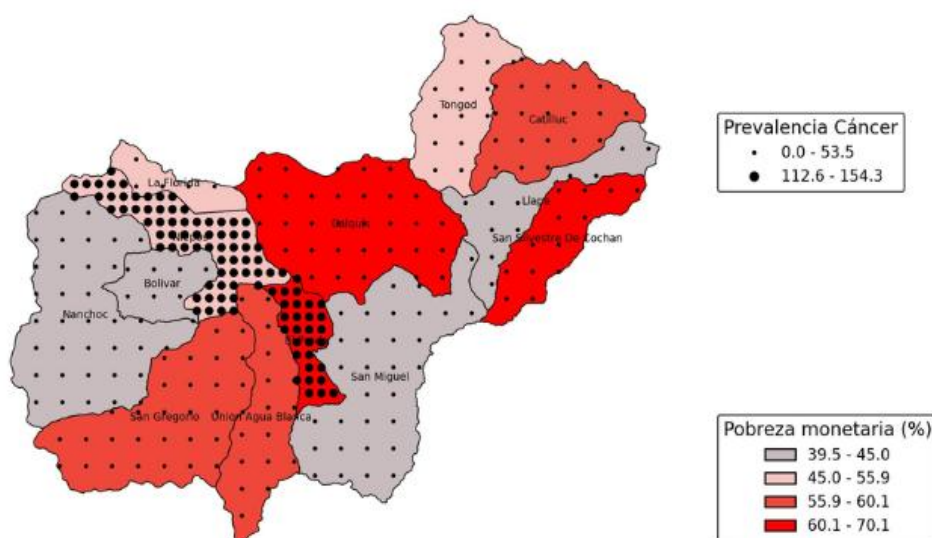
1.9. Cáncer

El cáncer (piel, mama, cuello uterino y estómago) registró 11 casos en la provincia en el 2025, número que limita la robustez estadística del análisis territorial.

En la provincia de San Miguel se evidencia una relación territorial entre el mayor analfabetismo y la mayor prevalencia de cáncer, en 2025 los grupos sociales 1 a 4 registraron 0,00, 76,97, 0,00 y 29,83 (tasa x100,000 hab.) respectivamente, con una brecha absoluta de 29,83 puntos. Esta desigualdad puede explicarse por varios mecanismos que suelen operar de forma conjunta en zonas rurales con bajo nivel educativo, un menor acceso a servicios de tamizaje oportuno (mamografía, Papanicolaou, endoscopia) retrasa el diagnóstico hasta etapas avanzadas, cuando la enfermedad ya es evidente; el desconocimiento de los signos de alarma y la desconfianza hacia los establecimientos de salud frecuentes en poblaciones con menor escolaridad postergan la búsqueda de atención; y factores culturales, como recurrir primero a la medicina tradicional o el temor al diagnóstico, refuerzan este retraso. Con solo 11 casos en toda la provincia, esta distribución debe leerse como indicativa y no concluyente, pero respalda fortalecer el tamizaje y el diagnóstico oportuno en los distritos de mayor rezago educativo, junto con estrategias de comunicación en salud culturalmente pertinentes.

Gráfico 11. Cáncer vs analfabetismo a nivel distrital, año 2023 - 2025





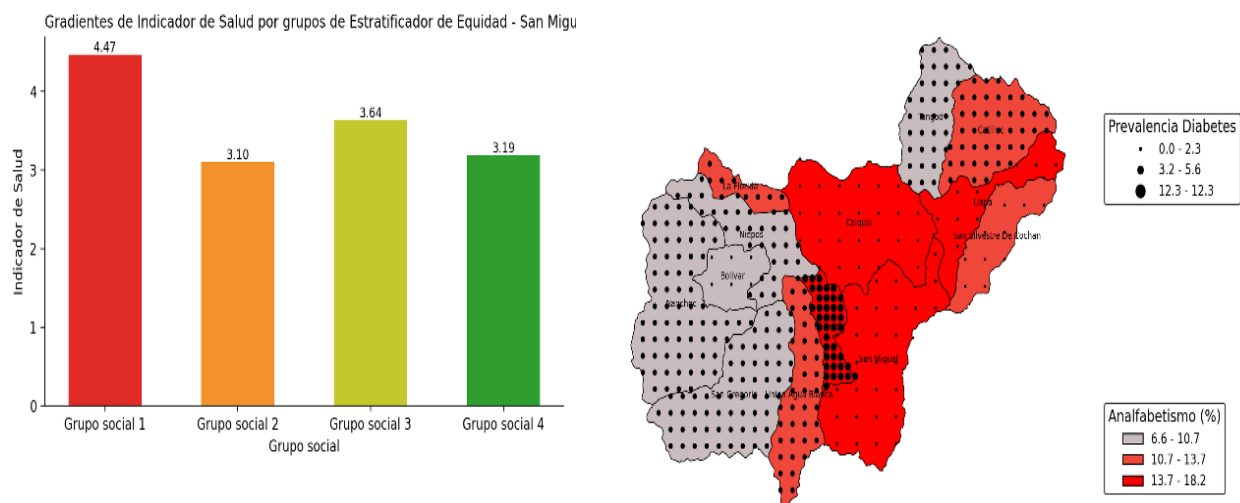
Fuente: Sistema de Información HIS MINSA, procesado mediante el Cuantificador de Desigualdades en Salud (DGE), ámbito filtrado a la provincia San Miguel
Elaborado: Equipo ASIS - Red de Salud San Miguel

1.10. Diabetes

Para el año 2025 se registraron 121 casos de diabetes en la provincia, dato que ofrece una base más robusta que el cáncer para el análisis territorial.

La diabetes en la provincia no muestra una relación territorial clara con los determinantes sociales evaluados en este análisis, lo que es consistente con su naturaleza multifactorial, a diferencia de indicadores como la DCI o la anemia, la diabetes tipo 2 responde a una combinación de predisposición genética, hábitos alimentarios y actividad física que no necesariamente sigue el mismo gradiente que la pobreza o la educación, y su detección depende en gran medida del acceso desigual a pruebas diagnósticas (glicemia) entre distritos, lo que puede enmascarar la verdadera distribución territorial del problema. Por lo cual es de suma importancia la implementación de los establecimientos de salud con equipos e insumos para realizar este tipo de exámenes, así como la capacitación del personal de laboratorio para ejecutarlos.

Gráfico 12. Diabetes vs analfabetismo a nivel distrital, año 2025



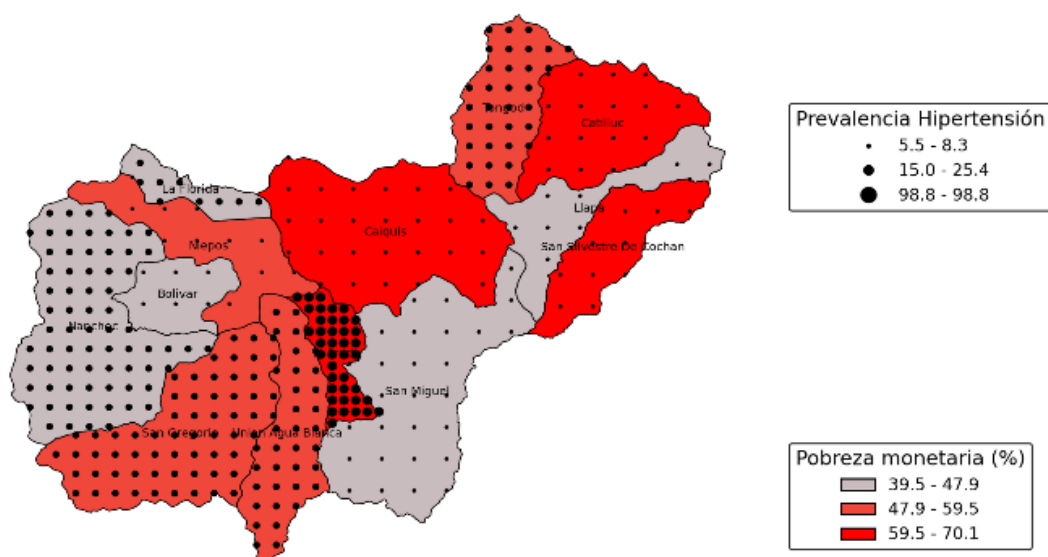
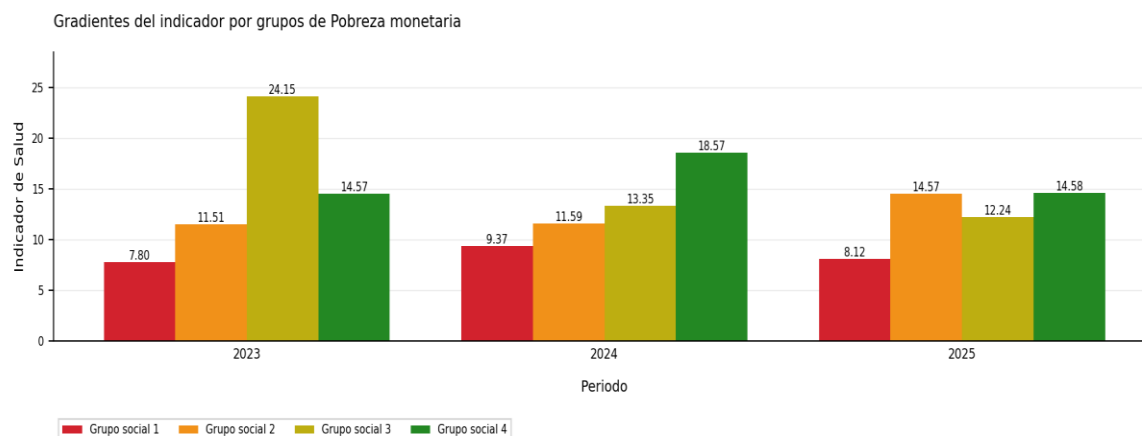
Fuente: Sistema de Información HIS MINSA, procesado mediante el Cuantificador de Desigualdades en Salud (DGE), ámbito filtrado a la provincia San Miguel
Elaborado: Equipo ASIS - Red de Salud San Miguel

1.11. Hipertensión

La hipertensión, con 498 casos en 2025, es el indicador con mayor volumen de casos de todo el análisis territorial. En la provincia de San Miguel se evidencia una relación territorial directa entre la mayor pobreza monetaria y la mayor prevalencia de hipertensión arterial. En 2025 los grupos sociales 1 a 4 registraron 8,12, 14,57, 12,24 y 14,58 (tasa x1,000 hab.) respectivamente, con una brecha absoluta de 6,46 puntos entre los grupos extremos. La pobreza se asocia frecuentemente a dietas con mayor contenido de sodio y alimentos procesados de bajo costo, a menor acceso a controles preventivos periódicos, y a niveles más altos de estrés crónico ligado a la precariedad económica, todos factores de riesgo conocidos para la hipertensión arterial. Estos hallazgos respaldan priorizar el tamizaje y control de enfermedades crónicas no transmisibles en los distritos de mayor pobreza monetaria.

Frente a pobreza monetaria el patrón territorial es similar, decreciente pero no perfectamente lineal, con el alto volumen de casos permitiendo una lectura más confiable que en cáncer o tuberculosis.

Gráfico 13. Hipertensión vs analfabetismo, año 2023 - 2025



Fuente: Sistema de Información HIS MINSA, procesado mediante el Cuantificador de Desigualdades en Salud (DGE), ámbito filtrado a la provincia San Miguel
Elaborado: Equipo ASIS - Red de Salud San Miguel

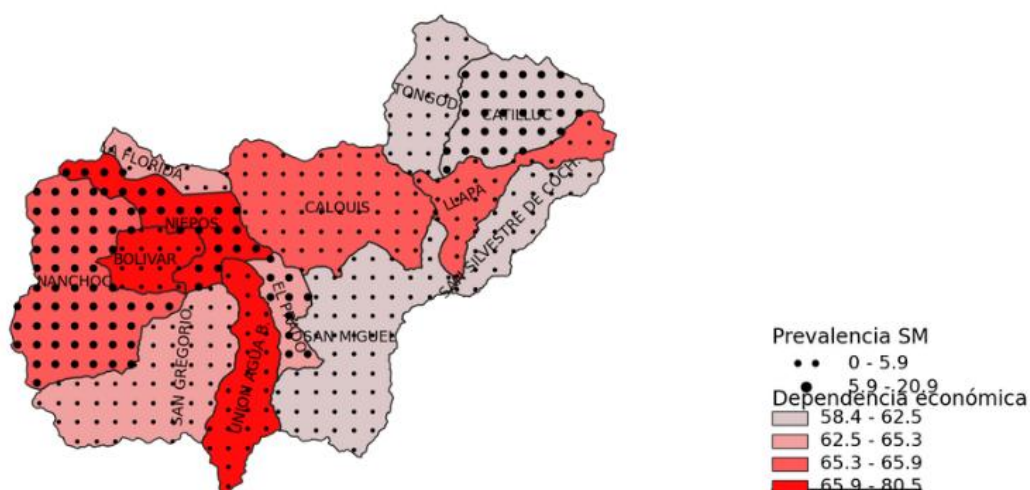
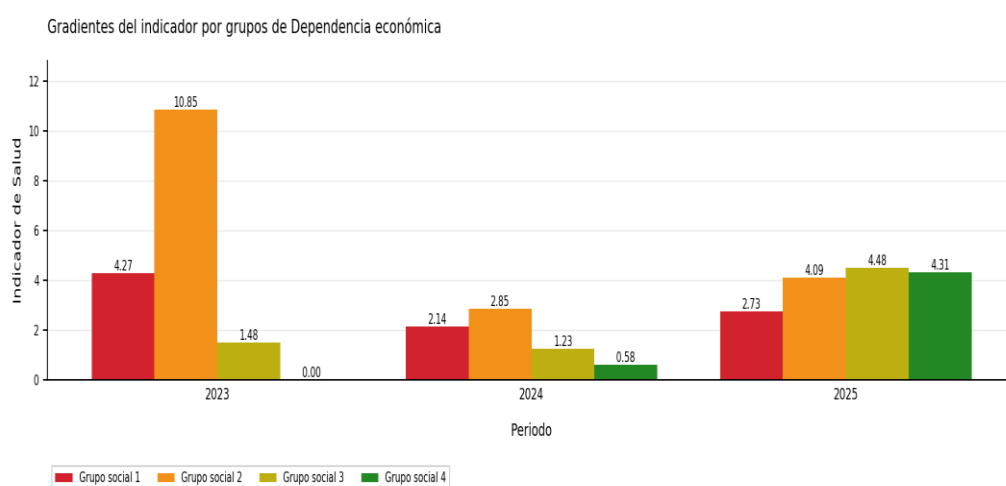
1.12. Salud mental (ansiedad, depresión y suicidio)

Con 155 casos tamizados en 2025, la salud mental muestra un patrón territorial particular que amerita revisión cualitativa. La prevalencia se concentra territorialmente en los distritos de menor analfabetismo, patrón que podría reflejar mayor acceso a tamizaje y menor estigma en dichos distritos, más que una mayor prevalencia real del problema.

En la provincia de San Miguel se evidencia una relación territorial directa entre la mayor dependencia económica y la mayor prevalencia de problemas de salud mental. En 2025 los grupos

sociales 1 a 4 registraron 2,73, 4,09, 4,48 y 4,31 (tasa x1,000 hab.) respectivamente, con una brecha absoluta de 1,58 puntos entre los grupos extremos. Una mayor dependencia económica implica que menos miembros del hogar sostienen económicamente a más personas, lo que genera sobrecarga y estrés crónico en quienes trabajan, además de limitar el acceso a redes de apoyo formal y aumentar el estigma asociado a buscar ayuda por problemas de salud mental en contextos de escasez de recursos. Estos hallazgos respaldan fortalecer los servicios de salud mental comunitaria en los distritos con mayor dependencia económica.

Gráfico 14. Salud mental vs dependencia económica a nivel distrital, año 2025



Fuente: Sistema de Información HIS MINSA, procesado mediante el Cuantificador de Desigualdades en Salud (DGE), ámbito filtrado a la provincia San Miguel
Elaborado: Equipo ASIS - Red de Salud San Miguel

IX. LÍNEAS DE ACCIÓN

A partir de los resultados obtenidos, se plantean líneas de acción orientadas a reducir las desigualdades en salud identificadas entre los grupos de población. Las intervenciones deben priorizar los problemas que presentan mayores brechas, particularmente cáncer, tuberculosis, salud mental, hipertensión y VIH. Para ello, se requiere fortalecer la atención primaria de salud mediante acciones de promoción, prevención, tamizaje, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y seguimiento de los casos. Asimismo, resulta necesario intervenir sobre los determinantes sociales asociados con las desigualdades, como la pobreza monetaria, el hacinamiento, la dependencia económica y las limitaciones en el acceso a servicios básicos.

De manera complementaria, se deben fortalecer las acciones de prevención y control de enfermedades no transmisibles, especialmente diabetes e hipertensión, mediante promoción de estilos de vida saludables y detección temprana. En población adolescente se recomienda fortalecer la educación sexual integral y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Para la TBC y el VIH se requiere intensificar la búsqueda activa, el diagnóstico oportuno y la continuidad del tratamiento. Estas intervenciones deben desarrollarse con participación comunitaria y coordinación intersectorial con todas las instituciones públicas y privadas de la provincia, especialmente con los gobiernos; priorizando los territorios y grupos que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, se recomienda implementar un sistema de monitoreo periódico en conjunto con los consejos distritales de salud para evaluar si las intervenciones están logrando disminuir las desigualdades identificadas.

Cuadro 48. Líneas de acción priorizadas según los determinantes identificados en el análisis de desigualdades (capítulo VIII)

Problema de salud priorizado	Determinante principal identificado (cap. VIII)	Línea de acción propuesta	Indicador de seguimiento
Desnutrición crónica infantil y anemia	Pobreza monetaria (determinante estructural principal); acceso a agua y desagüe (determinante intermedio)	Fortalecer la suplementación con hierro y multimicronutrientes y la consejería nutricional con énfasis en las IPRESS de los distritos de mayor pobreza (Llapa, Catilluc, Calquis, Tongod); articular con programas sociales (JUNTOS, Qali Warma) para el grupo social de mayor riesgo.	- % de DCI y anemia en menores de 5 años por IPRESS
Tuberculosis	Hacinamiento y hogares que cocinan con leña (determinantes intermedios)	Priorizar la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios y la visita domiciliaria en distritos con mayor hacinamiento; promover cocinas mejoradas en coordinación con la municipalidad provincial.	- Tasa de incidencia de TBC. - % de sintomáticos respiratorios identificados. - % de contactos censados y evaluados.
VIH y enfermedades de transmisión sexual	Migración y movilidad poblacional (determinante intermedio)	Focalizar el tamizaje y la consejería en VIH/ITS en los ejes viales de mayor tránsito poblacional y en población migrante, en lugar de basarse únicamente en criterios de pobreza monetaria	- Número de personas tamizadas para VIH. - % de positivos vinculados a tratamiento
Leishmaniasis cutánea y dengue	Migración y exposición ocupacional agrícola (determinantes intermedios)	Mantener la vigilancia entomológica activa pese a la ausencia de casos autóctonos de dengue en 2025; fortalecer el control vectorial y la protección personal en distritos de mayor incidencia de Leishmaniasis cutánea.	- Número de casos autóctonos e importados de dengue. - Tasa de incidencia de Leishmaniasis cutánea.
Mortalidad materna y perinatal; embarazo adolescente	Dependencia económica y nivel educativo (determinantes estructurales)	Sostener el seguimiento de gestantes de alto riesgo y la referencia oportuna a establecimientos FONB/FONE; fortalecer la educación sexual integral en instituciones educativas en los distritos con mayor embarazo adolescente.	- RMM. - Incidencia de muertes perinatales. - % de embarazo adolescente
Cáncer, diabetes e hipertensión	Pobreza monetaria y nivel educativo (barreras de acceso a tamizaje y diagnóstico oportuno)	Ampliar las campañas de tamizaje de cáncer (piel, mama, cuello uterino, colon y recto y próstata) y de factores de riesgo cardiometabólico en los distritos de mayor pobreza y analfabetismo, donde se concentra la mayor prevalencia.	- % de personas tamizadas para cáncer. - % de hipertensos y diabéticos con tratamiento controlado.
Salud mental (ansiedad, depresión, conducta suicida)	Nivel educativo y dependencia económica (determinantes estructurales)	Priorizar el tamizaje de salud mental en las IPRESS de los distritos con mayor precariedad educativa y económica; fortalecer la capacidad resolutoria del primer nivel de atención en consejería y derivación oportuna.	- % de personas tamizadas en salud mental. - Número de personas atendidas por primera vez
Acceso a agua potable y saneamiento básico	Pobreza monetaria (determinante estructural subyacente)	Gestionar ante el Gobierno Regional y la municipalidad provincial la priorización de proyectos de inversión en agua y saneamiento en los distritos con mayor brecha (Tongod, Catilluc,	- % de viviendas con acceso a agua potable y desagüe, por distrito

Fuente: Elaborado por epidemiología - Red de Salud San Miguel, 2026, a partir del análisis de determinantes y desigualdades (capítulo VIII) y la matriz de priorización.

X. CONCLUSIONES

- ✓ La provincia de San Miguel presenta un perfil epidemiológico mixto, con enfermedades transmisibles endémicas (Leishmaniasis cutánea, tuberculosis) y una carga creciente de enfermedades no transmisibles (hipertensión, diabetes, cáncer), en un contexto de pobreza monetaria elevada y brechas persistentes en el acceso a agua potable y saneamiento básico.
- ✓ De acuerdo al análisis de los determinantes sociales se confirma que la pobreza monetaria y el saneamiento básico explican de manera consistente las desigualdades en desnutrición crónica infantil, anemia, diabetes e hipertensión, mientras que el VIH y las enfermedades metaxénicas responden principalmente a la movilidad poblacional, y la tuberculosis al hacinamiento.
- ✓ La provincia de San Miguel no registró muertes maternas ni casos autóctonos de dengue en el año 2025, resultados favorables que deben seguir monitoreándose.
- ✓ Persisten brechas territoriales claras: los distritos de Tongod, Catilluc, Calquis y Nanchoc concentran sistemáticamente las peores condiciones en saneamiento básico, desnutrición, anemia y enfermedades transmisibles, mientras que el distrito de San Miguel y su entorno inmediato muestran una mayor carga relativa de enfermedades no transmisibles, coherente con una transición epidemiológica en curso en la capital provincial.

XI. RECOMENDACIONES

- ✓ Priorizar las intervenciones de las líneas de acción según el determinante social predominante de cada problema, focalizando recursos en los grupos sociales y distritos con mayor brecha relativa.
- ✓ Fortalecer el registro y la calidad del dato a nivel distrital para los indicadores sanitarios y de impacto (VIH, TBC, cáncer, DCI, anemia y mortalidad perinatal).
- ✓ Gestionar ante el Gobierno Regional de Cajamarca y la Municipalidad Provincial de San Miguel la priorización de inversión en agua potable y saneamiento básico en los distritos con mayor brecha, dado que este determinante intermedio explica

una parte importante de las desigualdades identificadas en desnutrición crónica infantil y enfermedades transmisibles.

- ✓ Institucionalizar el seguimiento semestral de los indicadores de las líneas de acción en el marco del Consejo Provincial de Salud San Miguel, e integrar el análisis de gradiente social (Estratificador de Equidad en Salud) como práctica habitual del proceso de programación y evaluación de las intervenciones en salud.
- ✓ Mantener la vigilancia epidemiológica activa de las enfermedades sujetas a vigilancia en salud pública.